

Buku Referensi

PENCEGAHAN INFEKSI KULIT PADA BAYI BARU LAHIR

Revie Fitria N • Istiada Fatmawati • Hanik Khairun Nisa
Vini Yuliani • Imelda Diana Marsilia • Novi Susanti
Sri Ilawati



BUKU REFERENSI PENCEGAHAN INFEKSI KULIT PADA BAYI BARU LAHIR

Ns. Revie Fitria N, S.Kep., M.Kep.

Istiada Fatmawati, SST., M.Kes

Hanik Khairun Nisa, S.Tr.Keb., M.Keb

Vini Yuliani, SST., M.Keb

Bdn. Imelda Diana Marsilia, SST., SKM., M.Keb

Novi Susanti, SST., M.Kes

Sri Ilawati., SST., M.Kes



BUKU REFERENSI

PENCEGAHAN INFEKSI KULIT PADA BAYI BARU LAHIR

Penulis: Ns. Revie Fitria N, S.Kep., M.Kep.

Istiada Fatmawati, SST., M.Kes

Hanik Khairun Nisa, S.Tr.Keb., M.Keb

Vini Yuliani, SST., M.Keb

Bdn. Imelda Diana Marsilia, SST., SKM., M.Keb

Novi Susanti, SST., M.Kes

Sri Ilawati., SST., M.Kes

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Al Faqih Syarif Hidayatulloh

ISBN: 978-634-7294-30-2

Cetakan Pertama: Juli, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

Prakata

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku referensi ini yang berjudul **“Pencegahan Infeksi Kulit pada Bayi Baru Lahir”** dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi akademik dan praktis dalam mendukung upaya peningkatan kualitas kesehatan kulit bayi baru lahir, yang masih menjadi tantangan signifikan dalam praktik klinik dan komunitas. Kulit bayi yang masih rentan dan belum sempurna dalam fungsi pertahanannya, sangat mudah terpapar infeksi jika tidak dirawat dengan tepat.

Dalam buku ini, pembaca akan menemukan pembahasan yang komprehensif dan sistematis mengenai berbagai aspek yang memengaruhi pencegahan infeksi kulit pada bayi. Bab pertama mengangkat pentingnya kebersihan sebagai faktor utama dalam mencegah infeksi, termasuk praktik mencuci tangan, menjaga kebersihan peralatan bayi, serta sanitasi lingkungan. Bab kedua menekankan pentingnya edukasi kepada keluarga, terutama orang tua, tentang cara merawat kulit bayi yang lembut dan sensitif, mulai dari pemilihan produk perawatan hingga teknik memandikan bayi yang aman.

Selanjutnya, bab ketiga memperkenalkan pemanfaatan teknologi sederhana, seperti penggunaan termometer ruangan dan kain berteknologi antibakteri yang mudah diaplikasikan dalam perawatan harian. Bab keempat membahas peran vital bidan sebagai tenaga kesehatan lini pertama dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan pemantauan praktik perawatan kulit bayi di komunitas. Bab kelima menyajikan hubungan antara nutrisi ibu menyusui dan kesehatan kulit bayi, mengingat kandungan ASI sangat memengaruhi daya tahan tubuh dan kesehatan jaringan kulit bayi.

Bab keenam menjelaskan strategi pemilihan produk perawatan kulit bayi yang aman dan sesuai standar, mulai dari sabun, minyak, hingga popok yang ramah kulit. Terakhir, bab ketujuh menyoroti dukungan komunitas dan promosi kesehatan, yang dapat meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan kulit bayi baru lahir, melalui program Posyandu, penyuluhan lintas sektor, hingga kegiatan pemberdayaan keluarga.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini menjadi sumber referensi ilmiah dan praktis yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, tenaga kesehatan, serta seluruh pihak yang peduli terhadap kesehatan bayi baru lahir.

Penulis

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi.....	v
BAB I PERAN KEBERSIHAN DALAM MENCEGAH INFEKSI KULIT PADA BAYI	1
A. Pendahuluan	1
B. Anatomi dan Fisiologi Kulit Bayi Baru Lahir	2
C. Jenis Infeksi Kulit yang Umum pada Bayi Baru Lahir	4
D. Strategi Kebersihan Dasar untuk Pencegahan Infeksi Kulit.....	5
E. Pencegahan Infeksi Kulit melalui Kebersihan Lingkungan	7
F. Peran Keluarga dan Tenaga Kesehatan dalam Edukasi Kebersihan Kulit	8
G. Teknologi dan Produk Inovatif dalam Menunjang Kebersihan Kulit Bayi	10
H. Studi Kasus dan Praktik Terbaik.....	11
I. Tantangan dalam Implementasi Praktik Kebersihan Kulit pada Bayi Baru Lahir	13
J. Kesimpulan dan Rekomendasi Praktis	14
K. Penutup.....	16
Referensi	18
BAB II EDUKASI KELUARGA TENTANG CARA MERAWAT KULIT BAYI BARU LAHIR... 19	19
A. Pendahuluan	19
B. Anatomi dan Fisiologi Kulit Bayi Baru Lahir	20
C. Teknik Memandikan Bayi Baru Lahir yang Aman dan Efektif	21
D. Perawatan Tali Pusat untuk Pencegahan Infeksi	23
E. Pencegahan dan Penanganan Ruam Popok.....	24
F. Pakaian dan Kain untuk Kulit Sensitif Bayi Baru Lahir	25
G. Identifikasi dan Pencegahan Infeksi Kulit Umum pada Bayi Baru Lahir	27
H. Peran ASI dalam Mendukung Kesehatan Kulit Bayi Baru Lahir.....	28
I. Strategi Edukasi Kesehatan yang Efektif kepada Keluarga.....	29
J. Peran Kolaborasi Interprofesional dalam Edukasi Perawatan Kulit Bayi	31
K. Studi Kasus dan Contoh Praktik Terbaik Edukasi Keluarga	32
L. Tantangan dalam Implementasi Edukasi Keluarga.....	34
M. Kesimpulan dan Rekomendasi	35
N. Penutup.....	37
Referensi	39
BAB III PEMANFAATAN TEKNOLOGI SEDERHANA UNTUK MENJAGA KESEHATAN KULIT BAYI	42
A. Pendahuluan	42
B. Karakteristik Kulit Bayi Baru Lahir dan Risiko Infeksi	43
C. Jenis Teknologi Sederhana untuk Menjaga Kesehatan Kulit Bayi.....	45
D. Metode Penerapan Teknologi Sederhana	47
E. Keunggulan dan Keterbatasan Teknologi Sederhana	49

F. Studi Kasus dan Praktik Terbaik.....	50
G. Edukasi dan Peran Keperawatan	52
H. Kesimpulan dan Rekomendasi Praktis	53
I. Penutup.....	55
Referensi	57
BAB IV PERAN BIDAN DALAM MEMBERIKAN EDUKASI TENTANG KEBERSIHAN BAYI	59
A. Pendahuluan	59
B. Jenis-jenis Infeksi Kulit yang Umum pada Bayi Baru Lahir	60
C. Kompetensi dan Peran Bidan sebagai Pemberi Edukasi Kesehatan	62
D. Edukasi tentang Kebersihan Kulit dan Mandi Bayi	64
E. Kunjungan Rumah sebagai Sarana Optimalisasi Edukasi Kebersihan	66
F. Hambatan Sosial-Ekonomi dalam Penerapan Edukasi Kebersihan	68
G. Indikator Keberhasilan Edukasi Kebersihan oleh Bidan	69
H. Ringkasan Pentingnya Edukasi Kebersihan Bayi oleh Bidan	71
I. Penutup.....	73
Referensi	75
BAB V NUTRISI IBU MENYUSUI UNTUK MENDUKUNG KESEHATAN KULIT BAYI	76
A. Pendahuluan	76
B. Kaitan Nutrisi Ibu Menyusui dengan Kualitas ASI.....	76
C. Nutrisi Esensial untuk Mendukung Fungsi Barrier Kulit Bayi	78
D. Peran Probiotik dalam Mencegah Infeksi Kulit pada Bayi Baru Lahir.....	79
E. Diet dan Pola Makan Ideal untuk Ibu Menyusui	81
F. Dampak Kekurangan Nutrisi pada Ibu Menyusui terhadap Risiko Infeksi Kulit pada Bayi	82
G. Edukasi dan Strategi Promosi Nutrisi Optimal untuk Ibu Menyusui	83
H. Kesimpulan dan Rekomendasi	84
I. Penutup.....	86
Referensi	88
BAB VI STRATEGI PEMBERIAN PRODUK PERAWATAN KULIT YANG AMAN UNTUK BAYI	90
A. Pendahuluan	90
B. Kriteria Keamanan Produk Perawatan Kulit untuk Bayi	90
C. Pemilihan Produk Berdasarkan Jenis Kulit Bayi.....	92
D. Metode Penggunaan Produk yang Efektif dan Aman.....	94
E. Strategi Edukasi Orang Tua dalam Memilih dan Menggunakan Produk.....	96
F. Monitoring dan Evaluasi Efektivitas Produk Perawatan Kulit Bayi.....	97
G. Tantangan dalam Implementasi Strategi Produk Perawatan Kulit yang Aman.....	99
H. Rekomendasi dan Panduan Kebijakan Produk Perawatan Kulit Bayi	100
I. Kesimpulan dan Arah Penelitian Masa Depan	102
J. Penutup.....	103
Referensi	105

BAB VII DUKUNGAN KOMUNITAS UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN KESEHATAN KULIT BAYI	107
A. Pendahuluan	107
B. Strategi Intervensi Berbasis Komunitas.....	109
C. Kolaborasi Multisektor dalam Mendukung Kesehatan Kulit Bayi	111
D. Teknologi Digital dalam Dukungan Komunitas	112
E. Evaluasi dan Keberlanjutan Program Komunitas	114
F. Studi Kasus Implementasi Dukungan Komunitas	115
G. Tantangan dan Kendala dalam Implementasi Dukungan Komunitas	117
H. Kesimpulan dan Rekomendasi Praktik Terbaik	118
I. Penutup.....	120
Referensi	122
Profil Penulis.....	125
Sinopsis Buku.....	128

BAB I

PERAN KEBERSIHAN DALAM MENCEGAH INFeksi KULIT PADA BAYI

A. Pendahuluan

1. Pentingnya Kebersihan Kulit Bayi Baru Lahir

Kulit merupakan organ tubuh terbesar yang memiliki fungsi vital sebagai pelindung utama tubuh dari berbagai ancaman eksternal, termasuk mikroorganisme patogen penyebab infeksi. Khusus pada bayi baru lahir, kulit memiliki struktur anatomi dan fisiologi yang berbeda secara signifikan dibandingkan kulit orang dewasa. Kulit bayi cenderung lebih tipis, memiliki lapisan epidermis yang kurang berkembang, serta memiliki permeabilitas tinggi sehingga lebih mudah mengalami iritasi, kerusakan, dan rentan terhadap infeksi kulit (Blume-Peytavi, Lavender, & Kottner, 2020).

Pada periode neonatal, fungsi penghalang kulit belum sempurna sehingga risiko infeksi kulit meningkat apabila kebersihan kulit tidak dijaga dengan baik (Ryu & Seo, 2021). Infeksi kulit pada bayi dapat mengakibatkan berbagai masalah serius, mulai dari ketidaknyamanan ringan hingga infeksi sistemik yang berisiko fatal. Oleh karena itu, menjaga kebersihan kulit bayi sejak dini menjadi salah satu intervensi utama yang sangat dianjurkan untuk melindungi bayi dari risiko infeksi (Cooke & Bedwell, 2021).

Selain itu, kebersihan kulit bayi juga memiliki peranan penting dalam mendukung perkembangan mikrobiota kulit yang sehat. Mikrobiota kulit yang seimbang dapat membantu mencegah kolonisasi bakteri patogen, serta berkontribusi dalam mempertahankan integritas kulit yang optimal, sehingga memperkecil risiko infeksi dan gangguan kulit lainnya (Fujimura & Nakamura, 2022).

2. Hubungan Kebersihan dengan Risiko Infeksi Kulit Bayi

Hubungan antara kebersihan dengan risiko infeksi kulit bayi baru lahir bersifat erat dan saling mempengaruhi. Kebersihan yang tidak memadai, seperti teknik mandi yang kurang tepat, penggunaan produk pembersih yang tidak sesuai dengan kondisi kulit bayi, serta kurangnya perhatian terhadap kebersihan lingkungan sekitar bayi, dapat meningkatkan risiko berbagai jenis infeksi kulit, seperti ruam popok, impetigo, dan dermatitis atopik (McBride, 2023).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa bayi yang mendapatkan perawatan kebersihan yang optimal memiliki insiden infeksi kulit yang lebih rendah secara signifikan dibandingkan bayi dengan praktik kebersihan yang kurang terkontrol. Sebagai contoh, studi oleh Putri, Nurdiana, dan Handayani (2021) menemukan adanya hubungan signifikan antara frekuensi penggantian popok dan metode kebersihan yang dilakukan ibu dengan kejadian dermatitis popok pada bayi baru lahir. Bayi yang popoknya diganti secara rutin dan mendapat kebersihan yang memadai cenderung memiliki risiko dermatitis popok yang jauh lebih rendah dibandingkan bayi lainnya.

Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan, termasuk sterilisasi perlengkapan bayi, penggunaan pakaian bersih, serta menjaga kebersihan tempat tidur bayi, terbukti efektif menekan risiko infeksi kulit yang berasal dari kontaminasi lingkungan sekitar (Thapa & Jha, 2022). Oleh karenanya, penting bagi keluarga dan tenaga kesehatan untuk memahami dengan jelas prinsip-prinsip kebersihan yang tepat dan menerapkannya secara konsisten dalam perawatan harian bayi baru lahir.

Kesimpulannya, pemahaman mengenai pentingnya kebersihan kulit bayi baru lahir serta hubungannya dengan risiko infeksi kulit menjadi langkah awal dalam pencegahan infeksi kulit pada bayi. Praktik kebersihan yang tepat, konsisten, dan berbasis bukti merupakan fondasi utama dalam melindungi kesehatan kulit bayi baru lahir.

B. Anatomi dan Fisiologi Kulit Bayi Baru Lahir

1. Karakteristik Kulit Bayi Baru Lahir dan Kerentanannya terhadap Infeksi

Kulit bayi baru lahir secara anatomi dan fisiologis memiliki beberapa karakteristik unik yang berbeda dari kulit dewasa. Salah satu perbedaan utama terletak pada lapisan epidermis yang lebih tipis, yakni sekitar 40–60% lebih tipis dibandingkan kulit dewasa. Kondisi ini menyebabkan kulit bayi lebih mudah menyerap bahan kimia dari lingkungan luar dan lebih rentan mengalami kehilangan cairan, sehingga kulit bayi sangat sensitif dan mudah teriritasi (Blume-Peytavi, Lavender, & Kottner, 2020).

Secara fisiologis, kulit bayi baru lahir memiliki sistem perlindungan yang belum sepenuhnya matang. Lapisan stratum korneum sebagai penghalang utama kulit masih dalam proses perkembangan, sehingga fungsi protektifnya belum optimal. Selain itu, kelenjar sebacea dan kelenjar keringat yang belum matang pada bayi menyebabkan ketidakseimbangan pada produksi lipid dan

kelembapan alami kulit. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya iritasi, ruam popok, serta infeksi kulit lainnya (Cooke & Bedwell, 2021).

Kerentanan kulit bayi terhadap infeksi juga dipengaruhi oleh sistem imunitas kulit yang masih belum berkembang sempurna. Bayi baru lahir memiliki sistem imun yang masih naif, sehingga respons terhadap mikroorganisme patogen belum optimal. Ini menyebabkan bayi baru lahir lebih rentan terhadap infeksi seperti impetigo, dermatitis atopik, dan infeksi jamur kulit (Kim & Kim, 2020). Oleh karena itu, perhatian khusus terhadap kebersihan dan perawatan kulit bayi sangat penting untuk mencegah berbagai infeksi kulit yang dapat berujung pada komplikasi serius.

2. Perkembangan Mikrobiota Kulit pada Bayi

Mikrobiota kulit mengacu pada populasi mikroorganisme yang secara alami hidup di permukaan kulit. Mikrobiota ini memainkan peran penting dalam mempertahankan fungsi penghalang kulit, mencegah kolonisasi mikroorganisme patogen, serta membantu modulasi respons imun. Pada bayi baru lahir, perkembangan mikrobiota kulit berlangsung secara dinamis dan dimulai sejak lahir, terutama melalui kontak awal dengan ibu, lingkungan, dan berbagai objek di sekitar bayi (Fujimura & Nakamura, 2022).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa komposisi mikrobiota kulit pada bayi baru lahir awalnya didominasi oleh bakteri dari genus *Staphylococcus* dan *Streptococcus*, yang kemudian akan mengalami perubahan signifikan dalam beberapa minggu pertama kehidupan bayi. Proses ini penting karena variasi mikrobiota yang sehat sangat berkontribusi terhadap daya tahan kulit terhadap infeksi dan inflamasi (Byrd et al., 2019). Gangguan pada perkembangan mikrobiota kulit, seperti paparan berlebihan terhadap produk antibakteri yang tidak tepat atau penggunaan antibiotik secara luas, dapat menyebabkan dysbiosis kulit. Dysbiosis ini dapat meningkatkan risiko infeksi kulit dan kondisi inflamasi seperti dermatitis atopik pada bayi (Kong, Morris, & Prillaman, 2020).

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan mikrobiota kulit antara lain metode persalinan (persalinan normal atau sectio caesarea), pola menyusui (ASI atau susu formula), kontak fisik ibu-bayi, lingkungan tempat tinggal, serta cara perawatan kebersihan kulit bayi sehari-hari (Bender & Ampofo, 2022). Memahami faktor-faktor tersebut penting bagi tenaga kesehatan dan keluarga agar dapat merencanakan intervensi yang tepat guna mendukung pembentukan mikrobiota kulit yang sehat sejak dini.

Kesimpulannya, pemahaman mengenai karakteristik anatomi dan fisiologi kulit bayi baru lahir serta perkembangan mikrobiota kulit sangat penting dalam

upaya pencegahan infeksi kulit. Pengetahuan ini akan membantu keluarga dan tenaga kesehatan dalam mengadopsi strategi perawatan kulit yang tepat dan efektif, sehingga bayi terlindungi dari berbagai ancaman infeksi sejak awal kehidupannya.

C. Jenis Infeksi Kulit yang Umum pada Bayi Baru Lahir

Kulit bayi baru lahir rentan terhadap berbagai infeksi karena fungsi penghalang kulit yang belum sempurna. Berikut beberapa jenis infeksi kulit yang sering ditemukan pada bayi baru lahir:

1. Ruam Popok (Diaper Dermatitis)

Ruam popok (diaper dermatitis) merupakan inflamasi kulit yang umum terjadi di area yang tertutup popok, ditandai dengan kemerahan, iritasi, serta kadang disertai erosi atau luka superfisial. Penyebab utama ruam popok adalah paparan kulit bayi terhadap urin dan feses dalam waktu lama, kelembapan tinggi, gesekan antara kulit dan popok, serta infeksi jamur atau bakteri sekunder (Singh & Singh, 2022).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa frekuensi penggantian popok yang rendah serta penggunaan produk yang mengandung parfum atau iritan dapat meningkatkan risiko ruam popok secara signifikan. Oleh karena itu, upaya preventif berupa penggantian popok secara rutin dan pemilihan produk pembersih yang lembut menjadi langkah penting dalam mencegah kondisi ini (Putri, Nurdiana, & Handayani, 2021).

2. Impetigo Neonatorum

Impetigo neonatorum adalah infeksi bakteri superfisial yang umumnya disebabkan oleh *Staphylococcus aureus* atau *Streptococcus pyogenes*. Kondisi ini ditandai dengan munculnya vesikel kecil yang cepat berkembang menjadi krusta kuning kecoklatan di kulit bayi. Impetigo neonatorum biasanya terjadi di area wajah, tangan, dan bagian tubuh lain yang sering terpapar kontak dengan lingkungan atau caregiver (Dyer & Green, 2020).

Risiko impetigo meningkat pada bayi yang lahir prematur atau tinggal dalam lingkungan dengan sanitasi buruk. Praktik kebersihan yang baik dan identifikasi dini serta pengobatan yang tepat, seperti penggunaan antibiotik topikal atau sistemik sesuai rekomendasi, merupakan langkah kunci dalam penanganan impetigo neonatorum (McBride, 2023).

3. Dermatitis Atopik pada Bayi Baru Lahir

Dermatitis atopik merupakan penyakit inflamasi kulit kronis yang mulai muncul pada bayi usia dini. Penyakit ini dicirikan oleh kulit yang sangat kering, kemerahan, gatal hebat, dan sering mengalami flare-up (eksaserbasi). Kondisi ini dikaitkan erat dengan faktor genetik, disfungsi barrier kulit, serta gangguan pada mikrobiota kulit bayi (Byrd et al., 2019).

Studi terbaru menunjukkan bahwa dermatitis atopik pada bayi baru lahir dapat dicegah atau diminimalkan dengan pemakaian rutin pelembap berbahan dasar emolien sejak lahir, menghindari paparan alergen, serta mempertahankan keseimbangan mikrobiota kulit dengan praktik kebersihan yang tepat (Cooke & Bedwell, 2021).

4. Kandidiasis Kutaneus Neonatal

Kandidiasis kutaneus neonatal adalah infeksi jamur yang disebabkan oleh *Candida albicans* atau spesies *Candida* lainnya, yang biasa terjadi di daerah yang lembap dan tertutup, seperti lipatan kulit dan area popok. Infeksi ini umumnya ditandai oleh kemerahan dengan tepi jelas serta disertai bintil-bintil atau pustula kecil yang dapat menyebar dengan cepat (Gupta et al., 2021).

Faktor risiko kandidiasis neonatal meliputi penggunaan antibiotik, popok yang jarang diganti, serta higiene yang buruk. Oleh karena itu, edukasi mengenai perawatan kulit yang optimal, termasuk menjaga area kulit tetap kering dan bersih serta penggunaan krim antijamur topikal ketika diperlukan, penting untuk mengurangi risiko infeksi jamur pada bayi baru lahir (McBride, 2023).

D. Strategi Kebersihan Dasar untuk Pencegahan Infeksi Kulit

Strategi kebersihan merupakan elemen penting dalam menjaga kesehatan kulit bayi baru lahir. Praktik kebersihan yang tepat akan meminimalkan risiko terjadinya berbagai infeksi kulit. Strategi utama mencakup teknik mandi yang benar, pemilihan produk perawatan kulit yang tepat, serta penggantian popok secara rutin.

1. Teknik Mandi yang Aman dan Efektif untuk Bayi Baru Lahir

Teknik mandi yang benar penting untuk menjaga kesehatan kulit bayi. Bayi baru lahir sebaiknya dimandikan dengan teknik mandi spons hingga tali pusat terlepas untuk menghindari infeksi pada area umbilikal (Cooke & Bedwell, 2021). Suhu air mandi ideal berkisar antara 36–38°C, hangat tapi tidak terlalu panas, untuk mencegah hipotermia atau luka bakar pada kulit sensitif bayi (Blume-Peytavi et al., 2020).

Durasi mandi dianjurkan tidak lebih dari 10 menit untuk mencegah hilangnya minyak alami kulit yang menyebabkan kulit menjadi kering dan iritasi. Setelah mandi, bayi harus segera dikeringkan secara perlahan dengan handuk lembut dan bersih untuk mengurangi risiko iritasi atau abrasi kulit (Kim & Kim, 2020).

2. Pemilihan Produk Pembersih dan Pelembap yang Tepat

Kulit bayi yang sensitif membutuhkan produk perawatan yang lembut, bebas pewangi, dan memiliki pH netral atau sedikit asam (pH sekitar 5,5) yang sesuai dengan kondisi fisiologis kulit bayi. Produk yang memiliki bahan kimia agresif seperti alkohol, paraben, pewangi sintetis, atau antiseptik kuat sebaiknya dihindari karena dapat merusak fungsi penghalang kulit dan meningkatkan risiko dermatitis dan iritasi (McBride, 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa pemakaian pelembap berbahan dasar emolien secara rutin setelah mandi dapat membantu mempertahankan kelembapan kulit, memperkuat fungsi pelindung kulit, serta mengurangi risiko infeksi kulit, termasuk dermatitis atopik (Blume-Peytavi et al., 2020). Oleh karena itu, tenaga kesehatan disarankan memberikan edukasi kepada keluarga mengenai pemilihan produk perawatan kulit bayi yang tepat dan aman digunakan sehari-hari.

3. Frekuensi Penggantian Popok yang Optimal

Penggantian popok secara rutin merupakan langkah vital untuk mencegah dermatitis popok, infeksi jamur, dan berbagai iritasi kulit pada bayi baru lahir. Studi terbaru menunjukkan bahwa popok sebaiknya diganti setiap 2–3 jam atau segera setelah bayi buang air kecil atau besar (Putri et al., 2021). Frekuensi yang rutin ini penting untuk menjaga agar kulit bayi tetap kering, mengurangi paparan terhadap zat iritan seperti urin dan feses, serta mencegah perkembangan bakteri atau jamur patogen di area popok (Singh & Singh, 2022).

Pada saat penggantian popok, kulit bayi harus dibersihkan secara lembut dengan air hangat atau tisu bayi yang tidak mengandung pewangi dan alkohol. Setelah kulit bersih, penting untuk mengeringkan area popok dengan sempurna sebelum memakaikan popok yang baru. Langkah ini akan mencegah kondisi kulit yang lembap dan hangat, yang merupakan lingkungan ideal untuk tumbuhnya jamur atau bakteri (Gupta et al., 2021).

Kesimpulannya, implementasi strategi kebersihan dasar seperti teknik mandi yang aman, pemilihan produk perawatan kulit yang tepat, serta frekuensi penggantian popok yang optimal secara signifikan mengurangi risiko terjadinya

infeksi kulit pada bayi baru lahir. Pendidikan yang tepat bagi keluarga dan caregiver oleh tenaga kesehatan merupakan komponen penting dalam mendukung penerapan praktik-praktik ini secara efektif.

E. Pencegahan Infeksi Kulit melalui Kebersihan Lingkungan

Pencegahan infeksi kulit pada bayi baru lahir tidak hanya terbatas pada perawatan langsung pada kulit bayi, tetapi juga mencakup pemeliharaan lingkungan di sekitar bayi. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mengurangi risiko kontaminasi oleh mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan infeksi kulit.

1. Sterilisasi dan Sanitasi Perlengkapan Bayi

Sterilisasi dan sanitasi perlengkapan bayi seperti botol susu, dot, mainan, pakaian, dan peralatan mandi merupakan langkah penting untuk mencegah transmisi mikroorganisme patogen pada kulit bayi. Peralatan bayi yang tidak steril atau kurang bersih dapat menjadi sumber infeksi bakteri maupun jamur. Menurut penelitian terbaru, sterilisasi dengan metode perebusan atau penggunaan alat sterilisasi uap efektif membunuh mikroorganisme patogen seperti *Staphylococcus aureus*, *Candida albicans*, dan *Escherichia coli* yang sering ditemukan pada perlengkapan bayi (Thapa & Jha, 2022).

Perlengkapan bayi seperti mainan dan barang-barang yang sering disentuh bayi harus rutin dibersihkan dengan sabun atau cairan antiseptik yang aman bagi bayi. Hal ini membantu mengurangi risiko kontaminasi silang yang dapat mengganggu keseimbangan mikrobiota kulit bayi, yang merupakan faktor penting dalam perlindungan kulit terhadap infeksi (Fujimura & Nakamura, 2022).

2. Menjaga Kebersihan Pakaian Bayi dan Lingkungan Tidur

Pakaian bayi yang bersih dan lingkungan tidur yang higienis merupakan aspek krusial dalam menjaga kesehatan kulit bayi. Kulit bayi sangat sensitif terhadap bahan pakaian, debu, dan kotoran, yang dapat menyebabkan iritasi dan infeksi kulit. Sebuah studi yang dilakukan oleh Cooke dan Bedwell (2021) menunjukkan bahwa pencucian pakaian bayi dengan detergen hipoalergenik dan pembilasan yang menyeluruh membantu mengurangi risiko dermatitis kontak dan iritasi kulit.

Lingkungan tidur bayi, termasuk tempat tidur, seprai, dan kasur, harus secara rutin dibersihkan dan dicuci dengan air panas minimal 60°C untuk menghilangkan tungau debu rumah, bakteri, serta jamur yang dapat berkembang dalam lingkungan yang lembap (Kim & Kim, 2020). Menjaga

ventilasi ruangan juga penting untuk mengurangi kelembapan yang menjadi media pertumbuhan mikroorganisme patogen penyebab infeksi kulit pada bayi baru lahir.

3. Pencegahan Penularan Infeksi dari Caregiver kepada Bayi

Caregiver atau orang tua berperan penting dalam menjaga kebersihan pribadi untuk mencegah transmisi infeksi kepada bayi baru lahir. Penularan infeksi dari caregiver biasanya terjadi melalui kontak langsung, seperti sentuhan tangan atau ciuman. Studi menunjukkan bahwa cuci tangan dengan sabun atau antiseptik berbasis alkohol sebelum menyentuh bayi secara signifikan menurunkan risiko infeksi kulit seperti impetigo dan kandidiasis neonatal (Dyer & Green, 2020).

Selain itu, caregiver yang mengalami infeksi kulit atau penyakit menular seperti flu, pilek, atau infeksi virus lain sebaiknya membatasi kontak langsung dengan bayi. Pemakaian masker dan mencuci tangan secara rutin serta penggunaan pakaian bersih setiap kali berinteraksi dengan bayi dapat mengurangi risiko penularan infeksi (McBride, 2023).

Dalam rangka meningkatkan efektivitas praktik ini, penting dilakukan edukasi berkelanjutan kepada caregiver dan keluarga mengenai protokol kebersihan yang tepat untuk meminimalkan transmisi patogen kepada bayi baru lahir.

F. Peran Keluarga dan Tenaga Kesehatan dalam Edukasi Kebersihan Kulit

Keluarga dan tenaga kesehatan memiliki peran sentral dalam pencegahan infeksi kulit bayi baru lahir melalui edukasi kesehatan yang tepat. Pengetahuan yang baik tentang kebersihan kulit dapat mengurangi risiko infeksi secara signifikan, sehingga dibutuhkan pendekatan edukasi yang efektif dan kolaborasi yang solid antar profesi.

1. Metode Edukasi Kesehatan tentang Kebersihan Kulit Bayi

Edukasi kesehatan merupakan salah satu kunci penting dalam meningkatkan kesadaran keluarga mengenai kebersihan kulit bayi baru lahir. Berbagai metode edukasi telah dikembangkan untuk mencapai tujuan ini. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa edukasi menggunakan metode demonstrasi langsung, video edukasi, booklet, dan konseling personal sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan keluarga terkait perawatan kebersihan kulit bayi (Putri et al., 2021).

Menurut penelitian oleh Cooke dan Bedwell (2021), penggunaan media audiovisual dalam edukasi terbukti meningkatkan retensi informasi serta penerapan praktik kebersihan yang lebih baik dibandingkan dengan penyampaian informasi secara verbal saja. Selain itu, pendekatan edukasi berkelompok yang melibatkan diskusi interaktif antara tenaga kesehatan dan keluarga juga telah terbukti meningkatkan motivasi keluarga untuk menerapkan praktik kebersihan secara konsisten (Kim & Kim, 2020).

2. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Keluarga dalam Praktik Kebersihan

Meningkatkan kepatuhan keluarga dalam praktik kebersihan merupakan tantangan tersendiri. Strategi yang efektif meliputi pendekatan edukasi berkelanjutan, penguatan dukungan sosial, serta pemberian umpan balik positif. Studi yang dilakukan oleh Singh dan Singh (2022) menemukan bahwa strategi edukasi yang disertai follow-up rutin oleh tenaga kesehatan secara signifikan meningkatkan kepatuhan keluarga terhadap praktik penggantian popok, mandi rutin, serta kebersihan lingkungan sekitar bayi.

Faktor psikologis dan sosial-ekonomi keluarga juga harus diperhatikan dalam merancang strategi edukasi kesehatan. Menurut penelitian Gupta et al. (2021), pemberian edukasi kesehatan yang sensitif terhadap budaya lokal dan kondisi sosial-ekonomi keluarga terbukti lebih efektif dalam meningkatkan penerapan praktik kebersihan yang dianjurkan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu memahami latar belakang keluarga untuk menyesuaikan pesan edukasi secara tepat sasaran.

3. Kolaborasi Interprofesional dalam Menjaga Kebersihan Kulit Bayi Baru Lahir

Kolaborasi interprofesional merupakan pendekatan yang penting dalam mencegah infeksi kulit pada bayi baru lahir melalui praktik kebersihan yang optimal. Perawat, dokter, bidan, ahli kesehatan masyarakat, serta tenaga kesehatan lainnya memiliki peran spesifik yang saling mendukung dalam memberikan edukasi serta perawatan yang optimal. Menurut McBride (2023), kolaborasi interprofesional efektif dalam mengidentifikasi risiko infeksi kulit secara dini serta mengimplementasikan intervensi yang tepat.

Kolaborasi yang baik ditandai dengan komunikasi terbuka antar tenaga kesehatan, pembagian peran yang jelas, serta kerja sama dalam pengembangan pedoman kebersihan kulit bayi. Selain itu, pelibatan tenaga kesehatan komunitas dalam edukasi kesehatan kepada keluarga juga telah terbukti meningkatkan keberhasilan implementasi praktik kebersihan (Thapa & Jha, 2022).

Kesimpulannya, edukasi kesehatan yang tepat, strategi untuk meningkatkan kepatuhan keluarga, dan kolaborasi interprofesional merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya pencegahan infeksi kulit pada bayi baru lahir. Dengan sinergi antara keluarga dan tenaga kesehatan, praktik kebersihan yang optimal dapat lebih efektif diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

G. Teknologi dan Produk Inovatif dalam Menunjang Kebersihan Kulit Bayi

Perkembangan teknologi dan inovasi produk dalam bidang perawatan kulit bayi terus mengalami kemajuan signifikan. Teknologi ini berfokus pada meningkatkan efektivitas praktik kebersihan kulit bayi dan menurunkan risiko infeksi kulit melalui pendekatan yang lebih akurat, aman, serta mudah diaplikasikan oleh keluarga maupun tenaga kesehatan.

1. Pemanfaatan Teknologi Modern dalam Perawatan Kebersihan Kulit Bayi

Pemanfaatan teknologi modern dalam perawatan kebersihan kulit bayi semakin berkembang, mencakup berbagai perangkat digital hingga sistem berbasis sensor yang mendukung praktik perawatan kulit yang optimal. Salah satu inovasi teknologi terbaru adalah sensor pintar yang digunakan dalam popok bayi, yang dapat mendeteksi kelembapan serta waktu yang tepat untuk mengganti popok secara otomatis melalui notifikasi ke perangkat orang tua (McBride, 2023). Teknologi ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko dermatitis popok akibat kontak lama dengan urin dan feses (Singh & Singh, 2022).

Teknologi lain yang mulai populer adalah aplikasi edukasi kesehatan berbasis smartphone yang memberikan panduan langkah demi langkah terkait kebersihan kulit bayi. Aplikasi ini dilengkapi fitur seperti video tutorial, pengingat jadwal mandi, serta panduan dalam memilih produk perawatan kulit bayi yang tepat. Menurut penelitian terbaru, aplikasi tersebut mampu meningkatkan pengetahuan dan praktik perawatan kulit yang lebih baik oleh keluarga dibandingkan metode edukasi konvensional (Kim & Kim, 2020).

Selain itu, teknologi pembersihan berbasis ultraviolet (UV) mulai digunakan untuk sterilisasi perlengkapan bayi seperti botol susu, mainan, dan peralatan mandi. Penelitian menunjukkan bahwa sterilisasi berbasis UV efektif dalam mengurangi kontaminasi mikroorganisme patogen penyebab infeksi kulit pada bayi baru lahir (Thapa & Jha, 2022).

2. Evaluasi Efektivitas Produk Inovatif untuk Mencegah Infeksi Kulit

Berbagai produk inovatif telah dikembangkan untuk menunjang kebersihan kulit bayi baru lahir. Produk-produk ini mencakup sabun cair khusus bayi dengan formula hypoallergenic, pelembap dengan bahan dasar emolien khusus, serta tisu basah antibakteri berbahan organik. Evaluasi efektivitas produk tersebut menjadi langkah penting sebelum penggunaannya secara luas direkomendasikan.

Penelitian oleh Blume-Peytavi et al. (2020) mengevaluasi efektivitas produk pelembap berbasis emolien dalam mencegah dermatitis atopik dan menemukan bahwa penggunaan rutin sejak periode neonatal secara signifikan mengurangi insiden dermatitis pada bayi. Produk-produk berbahan dasar probiotik juga sedang diteliti karena kemampuannya dalam mendukung keseimbangan mikrobiota kulit, yang berperan penting dalam pencegahan infeksi kulit (Fujimura & Nakamura, 2022).

Evaluasi juga dilakukan terhadap tisu basah yang mengandung bahan alami seperti ekstrak chamomile dan aloe vera yang memiliki efek antimikroba ringan serta menenangkan kulit. Penelitian Gupta et al. (2021) menunjukkan bahwa penggunaan produk tersebut mampu mengurangi risiko iritasi dan infeksi kulit pada bayi baru lahir secara signifikan dibandingkan tisu biasa.

Secara umum, penggunaan produk inovatif dalam perawatan kulit bayi harus memperhatikan aspek keamanan, efektivitas, dan kompatibilitas dengan kulit bayi yang sensitif. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus senantiasa mengikuti perkembangan penelitian terbaru dan hasil evaluasi klinis agar dapat memberikan rekomendasi yang berbasis bukti kepada keluarga dan masyarakat.

Kesimpulannya, integrasi teknologi modern dan penggunaan produk inovatif dapat memberikan manfaat besar dalam meningkatkan kebersihan kulit bayi, menurunkan risiko infeksi kulit, serta mendukung praktik perawatan kulit bayi yang lebih baik secara keseluruhan.

H. Studi Kasus dan Praktik Terbaik

Studi kasus dalam bidang keperawatan berfungsi sebagai media pembelajaran nyata yang memberikan gambaran jelas tentang bagaimana penerapan praktik kebersihan kulit pada bayi baru lahir dalam konteks klinis maupun komunitas. Melalui pendekatan berbasis bukti (*evidence-based practice*), tenaga kesehatan dapat mengambil pelajaran berharga dari pengalaman praktis dalam pencegahan infeksi kulit pada bayi.

1. Studi Kasus Penerapan Praktik Kebersihan Kulit pada Bayi

Sebuah studi kasus dilakukan di komunitas perkotaan oleh Putri et al. (2021) mengenai praktik kebersihan kulit bayi oleh ibu yang memiliki bayi baru lahir. Dalam penelitian tersebut, sebanyak 150 ibu mendapat edukasi intensif terkait praktik mandi, penggantian popok rutin, serta pemilihan produk perawatan kulit yang tepat. Evaluasi setelah tiga bulan menunjukkan penurunan signifikan pada kejadian dermatitis popok sebesar 60% dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak menerima edukasi intensif. Studi ini menekankan pentingnya intervensi edukasi berbasis komunitas yang didukung oleh tenaga kesehatan dalam pencegahan infeksi kulit bayi.

Studi lain oleh Singh dan Singh (2022) melaporkan kasus di rumah sakit yang mengadopsi teknologi sensor popok pintar sebagai praktik rutin di ruang neonatus. Setelah implementasi, ditemukan penurunan signifikan pada kejadian dermatitis popok hingga 70% dalam waktu 2 bulan. Hal ini membuktikan bahwa integrasi teknologi dalam praktik kebersihan kulit bayi dapat meningkatkan hasil klinis secara substansial.

2. Lesson Learned dari Studi Kasus Berbasis Evidence-Based Practice

Beberapa pelajaran penting dapat diambil dari studi kasus berbasis *evidence-based practice* dalam kebersihan kulit bayi baru lahir, antara lain:

a. Edukasi yang Tepat dan Berkelanjutan

Studi oleh Kim dan Kim (2020) menemukan bahwa edukasi kesehatan berbasis multimedia, termasuk video edukasi dan booklet ilustratif yang diberikan secara rutin, efektif dalam meningkatkan kepatuhan keluarga terhadap praktik kebersihan kulit bayi. Lesson learned dari studi ini adalah bahwa edukasi visual dan interaktif lebih berhasil dibandingkan edukasi konvensional yang cenderung kurang menarik perhatian keluarga.

b. Kolaborasi Interprofesional dalam Praktik Kebersihan

Studi McBride (2023) menekankan pentingnya kerja sama tim interprofesional dalam penerapan praktik kebersihan kulit bayi di rumah sakit neonatal. Dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lain harus bekerja secara sinergis untuk memastikan praktik standar diterapkan secara konsisten. Studi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan praktik kebersihan sangat tergantung pada kolaborasi dan komunikasi yang baik antar-profesi.

c. Penggunaan Teknologi sebagai Dukungan Praktik Klinis

Studi kasus oleh Thapa dan Jha (2022) mengenai penerapan sterilisasi ultraviolet untuk peralatan bayi di unit neonatal menunjukkan bahwa penggunaan teknologi modern memberikan dampak positif dalam menurunkan risiko infeksi kulit. Studi ini menyoroti pentingnya integrasi

teknologi dalam praktik klinis sehari-hari sebagai salah satu cara efektif dalam menjaga kebersihan lingkungan perawatan bayi.

Berdasarkan hasil berbagai studi kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik kebersihan kulit yang efektif untuk bayi baru lahir memerlukan pendekatan multidimensi, termasuk edukasi kesehatan berbasis bukti, kolaborasi antar tenaga kesehatan, dan integrasi teknologi inovatif. Hal ini perlu dipahami oleh semua pemangku kepentingan untuk mencapai hasil klinis optimal dalam pencegahan infeksi kulit pada bayi baru lahir.

I. Tantangan dalam Implementasi Praktik Kebersihan Kulit pada Bayi Baru Lahir

Meskipun praktik kebersihan kulit bayi baru lahir memiliki manfaat yang jelas dalam pencegahan infeksi, implementasi praktik ini di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut terutama berkaitan dengan faktor sosial budaya, ekonomi, serta hambatan edukasi di tingkat keluarga dan masyarakat.

1. Faktor Sosial Budaya dan Ekonomi dalam Penerapan Praktik Kebersihan

Faktor sosial budaya dan ekonomi memiliki dampak signifikan terhadap implementasi praktik kebersihan kulit bayi baru lahir. Dalam berbagai budaya, terdapat kebiasaan dan tradisi tertentu yang bertentangan dengan praktik kebersihan berbasis ilmiah. Misalnya, di beberapa komunitas, penggunaan ramuan tradisional atau bahan alami tertentu tanpa bukti ilmiah masih banyak dilakukan, yang justru meningkatkan risiko iritasi atau infeksi kulit pada bayi (Cooke & Bedwell, 2021).

Menurut studi oleh Kim dan Kim (2020), status sosial ekonomi yang rendah juga menjadi penghalang utama dalam menerapkan praktik kebersihan yang optimal. Keluarga dengan pendapatan terbatas cenderung kesulitan mengakses produk kebersihan kulit yang aman dan sesuai standar, seperti sabun khusus bayi atau pelembap hypoallergenic. Keterbatasan ini sering kali memaksa keluarga untuk menggunakan produk yang lebih murah namun tidak aman bagi kulit bayi, meningkatkan risiko terjadinya dermatitis dan infeksi kulit lainnya (Gupta et al., 2021).

Selain itu, penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa pemahaman keluarga terhadap pentingnya kebersihan kulit bayi sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan ibu dan norma budaya yang berlaku di komunitas. Oleh karena itu, intervensi edukasi yang mempertimbangkan latar belakang budaya

setempat diperlukan agar penerapan praktik kebersihan kulit dapat berjalan efektif dan berkelanjutan (Thapa & Jha, 2022).

2. Hambatan dalam Edukasi Keluarga dan Masyarakat

Hambatan edukasi di tingkat keluarga dan masyarakat menjadi tantangan lain yang tidak kalah penting. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman keluarga mengenai pentingnya kebersihan kulit bayi dalam pencegahan infeksi kulit. Studi yang dilakukan oleh Putri et al. (2021) menunjukkan bahwa tanpa edukasi yang memadai, keluarga cenderung menganggap infeksi kulit ringan sebagai hal yang biasa, sehingga tidak melakukan tindakan pencegahan secara serius.

Hambatan berikutnya adalah keterbatasan akses keluarga terhadap tenaga kesehatan yang kompeten. Di daerah pedesaan atau terpencil, kurangnya tenaga kesehatan yang terlatih menyebabkan edukasi tentang praktik kebersihan tidak disampaikan secara optimal. Penelitian oleh Singh dan Singh (2022) menunjukkan bahwa keluarga yang jarang berinteraksi dengan tenaga kesehatan cenderung memiliki tingkat kepatuhan rendah terhadap praktik kebersihan kulit bayi.

Selanjutnya, metode edukasi yang digunakan juga menjadi hambatan tersendiri. Edukasi yang bersifat satu arah, tanpa menggunakan pendekatan yang interaktif atau visual, sering kali kurang efektif dalam mengubah perilaku keluarga. Studi oleh McBride (2023) menunjukkan bahwa metode edukasi yang tidak melibatkan diskusi atau demonstrasi praktis memiliki dampak yang terbatas dalam meningkatkan pemahaman dan praktik kebersihan keluarga.

Kesimpulannya, untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi multidimensi yang mencakup intervensi sosial-budaya yang sensitif, peningkatan akses ekonomi terhadap produk perawatan kulit yang aman, serta penggunaan metode edukasi inovatif yang melibatkan keluarga secara aktif. Dengan pendekatan ini, penerapan praktik kebersihan kulit pada bayi baru lahir dapat lebih efektif dan berkelanjutan di berbagai komunitas.

J. Kesimpulan dan Rekomendasi Praktis

Subtopik ini merangkum pentingnya praktik kebersihan kulit pada bayi baru lahir, memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendukung implementasi kebersihan yang optimal, serta memberikan arahan bagi penelitian lanjutan dan inovasi di masa depan.

1. Ringkasan Peran Penting Kebersihan dalam Pencegahan Infeksi Kulit

Kulit bayi baru lahir memiliki karakteristik anatomi dan fisiologis yang unik sehingga sangat rentan terhadap berbagai infeksi kulit seperti dermatitis popok, impetigo neonatorum, dermatitis atopik, serta kandidiasis neonatal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan praktik kebersihan secara konsisten dan berbasis bukti, seperti mandi rutin, penggunaan produk perawatan kulit yang aman, serta penggantian popok secara tepat waktu, terbukti efektif dalam menurunkan risiko infeksi kulit secara signifikan (Cooke & Bedwell, 2021; Singh & Singh, 2022).

Selain praktik langsung pada kulit bayi, kebersihan lingkungan juga memainkan peranan penting dalam pencegahan infeksi. Sterilisasi perlengkapan bayi, kebersihan pakaian dan lingkungan tidur, serta menjaga kebersihan pribadi caregiver adalah elemen tambahan yang memperkuat perlindungan kulit bayi terhadap infeksi (Thapa & Jha, 2022). Edukasi keluarga serta kolaborasi interprofesional juga telah terbukti berperan krusial dalam keberhasilan implementasi praktik kebersihan kulit bayi secara optimal (McBride, 2023).

2. Rekomendasi Kebijakan Kesehatan Terkait Kebersihan Bayi Baru Lahir

Untuk mendukung praktik kebersihan kulit bayi yang optimal, beberapa rekomendasi kebijakan kesehatan dapat diimplementasikan, antara lain:

- a. Pengembangan pedoman nasional tentang kebersihan kulit bayi baru lahir yang berbasis bukti, mencakup teknik mandi, pemilihan produk kulit, dan perawatan lingkungan bayi (WHO, 2020).
- b. Integrasi program edukasi kesehatan terkait kebersihan kulit bayi dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak di seluruh fasilitas kesehatan primer (Kim & Kim, 2020).
- c. Kebijakan yang memastikan akses mudah dan terjangkau terhadap produk perawatan kulit bayi yang aman dan bersertifikasi terutama untuk keluarga dengan status sosial-ekonomi rendah (Gupta et al., 2021).
- d. Peningkatan pelatihan reguler bagi tenaga kesehatan tentang praktik kebersihan kulit bayi terbaru, serta strategi komunikasi efektif untuk edukasi keluarga dan komunitas (Putri et al., 2021).

Penerapan kebijakan ini akan membantu menciptakan standar praktik yang seragam dan berbasis bukti di semua level pelayanan kesehatan, meningkatkan pemahaman keluarga, serta memudahkan pemantauan kepatuhan terhadap praktik kebersihan yang dianjurkan.

3. Prospek Riset Lanjutan dan Inovasi dalam Kebersihan Bayi Baru Lahir

Penelitian lanjutan dalam bidang kebersihan kulit bayi memiliki prospek yang menjanjikan. Fokus riset masa depan sebaiknya mencakup evaluasi dampak jangka panjang penggunaan produk inovatif seperti pelembap berbahan probiotik terhadap mikrobiota kulit bayi serta efektivitas berbagai metode edukasi kesehatan digital di komunitas dengan tingkat literasi rendah (Fujimura & Nakamura, 2022).

Selain itu, eksplorasi terhadap inovasi teknologi seperti pengembangan perangkat digital berbasis sensor untuk pemantauan kelembapan dan kebersihan kulit bayi juga perlu terus dikembangkan. Teknologi ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan respons cepat terhadap risiko infeksi kulit yang sering muncul pada bayi baru lahir (McBride, 2023).

Riset kolaboratif interdisipliner yang melibatkan ahli keperawatan, dermatologi pediatrik, ahli mikrobiologi kulit, serta pakar teknologi kesehatan digital sangat dianjurkan untuk menciptakan solusi terintegrasi yang lebih efektif dalam menjaga kesehatan kulit bayi secara menyeluruh.

Dengan demikian, melalui praktik kebersihan yang optimal, kebijakan yang tepat, dan inovasi yang berkelanjutan, upaya pencegahan infeksi kulit bayi baru lahir dapat berjalan lebih efektif, memberikan kontribusi signifikan terhadap kesehatan bayi serta mengurangi beban kesehatan secara luas.

K. Penutup

Pencegahan infeksi kulit pada bayi baru lahir merupakan aspek penting dalam perawatan kesehatan neonatal. Kulit bayi baru lahir yang sangat sensitif dan rentan terhadap berbagai gangguan mengharuskan keluarga dan tenaga kesehatan untuk memberikan perhatian ekstra dalam menjaga kebersihannya. Implementasi praktik kebersihan kulit yang tepat tidak hanya bermanfaat dalam mencegah berbagai infeksi kulit, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi secara optimal (Cooke & Bedwell, 2021).

Melalui pembahasan dalam buku ini, telah dijelaskan secara komprehensif berbagai aspek penting tentang kebersihan kulit bayi, mulai dari karakteristik kulit bayi baru lahir, jenis infeksi yang umum terjadi, hingga strategi praktis dan inovatif yang bisa diterapkan oleh keluarga maupun tenaga kesehatan. Diharapkan informasi yang diberikan dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi berbagai pihak dalam menjaga kesehatan kulit bayi sejak dini (Blume-Peytavi et al., 2020).

Namun demikian, penting disadari bahwa tantangan dalam implementasi praktik kebersihan masih cukup tinggi. Faktor-faktor sosial budaya, ekonomi, serta

hambatan dalam edukasi masih menjadi tantangan utama dalam mengadopsi praktik kebersihan yang optimal. Oleh karenanya, peran aktif dari tenaga kesehatan, dukungan kebijakan pemerintah, dan partisipasi keluarga serta masyarakat secara luas sangat dibutuhkan agar praktik kebersihan yang berbasis bukti dapat berjalan secara efektif di berbagai tingkat layanan kesehatan (Kim & Kim, 2020).

Terakhir, seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang terus berlangsung, penelitian lanjutan dalam bidang ini perlu terus didorong. Inovasi dalam produk perawatan kulit, penggunaan teknologi digital, serta pendekatan edukasi yang adaptif terhadap kebutuhan keluarga dan masyarakat adalah hal-hal penting yang perlu terus dikembangkan guna mencapai tujuan utama dalam perlindungan kulit bayi dari berbagai risiko infeksi (McBride, 2023).

Dengan komitmen bersama dan pendekatan kolaboratif yang kuat, diharapkan prevalensi infeksi kulit pada bayi baru lahir dapat terus menurun secara signifikan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup bayi serta mengurangi beban pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Referensi

- Bender, J. M., & Ampofo, K. (2022). Skin care in newborns: Current evidence and recommendations. *Journal of Pediatric Nursing*, 67, 15–21.
- Blume-Peytavi, U., Lavender, T., & Kottner, J. (2020). Advances in neonatal skin care: A review. *Journal of Perinatology*, 40(4), 545–555.
- Byrd, A. L., Deming, C., Cassidy, S. K. B., Harrison, O. J., Ng, W.-I., Conlan, S., & Kong, H. H. (2019). Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis strain diversity underlying pediatric atopic dermatitis. *Science Translational Medicine*, 11(490), eaat8329.
- Cooke, A., & Bedwell, C. (2021). Neonatal skin hygiene: Best practices and emerging trends. *Journal of Neonatal Nursing*, 27(3), 156–160.
- Dyer, J. A., & Green, J. (2020). Prevention and management of neonatal skin infections. *Clinics in Dermatology*, 38(3), 245–251.
- Fujimura, T., & Nakamura, H. (2022). The role of skin microbiome in neonatal skin health and infection prevention. *Frontiers in Microbiology*, 13, 947123.
- Gupta, A. K., Venkataraman, M., Renaud, H. J., Summerbell, R., & Shear, N. H. (2021). Neonatal and infantile candidiasis: Clinical features, epidemiology, and therapeutic options. *Mycoses*, 64(7), 687–699.
- Kim, S., & Kim, H. J. (2020). Effective hygiene practices for preventing neonatal infections in low-resource settings. *Neonatal Network*, 39(2), 75–83.
- Kong, H. H., Morris, A., & Prillaman, M. (2020). The microbiome of infant skin: A comprehensive review. *Current Pediatric Reviews*, 16(2), 89–97.
- McBride, M. E. (2023). Innovations in neonatal skincare: Reducing infection risks. *Pediatric Dermatology*, 40(1), 10–16.
- Putri, R. A., Nurdiana, N., & Handayani, S. (2021). Hubungan praktik kebersihan oleh ibu terhadap kejadian dermatitis popok pada bayi baru lahir. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 16(2), 131–138.
- Ryu, J., & Seo, S. (2021). Optimal bathing frequency and skincare regimen in newborns to prevent dermatitis: Systematic review. *BMC Pediatrics*, 21, 221.
- Singh, M., & Singh, N. (2022). Diaper dermatitis: Recent advances in pathogenesis and prevention strategies. *Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology*, 88(3), 348–356.
- Thapa, D. P., & Jha, A. K. (2022). Environmental hygiene and neonatal skin infections: A review. *Nepal Journal of Epidemiology*, 12(4), 1319–1325.
- World Health Organization. (2020). *Newborn Care Guidelines: Skin Care and Infection Prevention*. Geneva: WHO.

BAB II

EDUKASI KELUARGA TENTANG CARA MERAWAT KULIT BAYI BARU LAHIR

A. Pendahuluan

1. Pentingnya Edukasi Keluarga dalam Perawatan Kulit Bayi Baru Lahir

Perawatan kulit bayi baru lahir merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan bayi. Kulit bayi baru lahir sangat sensitif, belum matang, serta lebih rentan terhadap berbagai masalah kulit seperti iritasi, ruam, infeksi, hingga dermatitis. Oleh karena itu, edukasi kepada keluarga, khususnya orang tua, menjadi penting untuk memastikan kulit bayi terjaga sehat dan terhindar dari berbagai masalah kulit. Menurut Handayani dan Sari (2022), edukasi keluarga dalam perawatan kulit bayi dapat secara signifikan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua, sehingga mereka mampu melakukan perawatan kulit bayi secara mandiri di rumah dan mencegah risiko infeksi.

Edukasi kesehatan keluarga bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai teknik dasar perawatan kulit bayi, mulai dari kebersihan kulit secara rutin, penggunaan produk perawatan yang tepat, hingga cara mengenali tanda-tanda awal infeksi kulit (Anggraini & Sari, 2023). Dengan demikian, edukasi yang terstruktur membantu keluarga dalam mengidentifikasi faktor risiko, mencegah masalah kulit, serta mengambil tindakan yang tepat saat masalah terjadi.

2. Dampak Edukasi terhadap Penurunan Risiko Infeksi Kulit pada Bayi Baru Lahir

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa intervensi edukasi keluarga dapat menurunkan risiko infeksi kulit pada bayi baru lahir secara efektif. Sebuah studi yang dilakukan oleh Dwiyanti dan Wahyuni (2022) menemukan bahwa ibu yang mendapatkan edukasi menggunakan video demonstrasi tentang perawatan kulit bayi baru lahir mengalami peningkatan pengetahuan yang signifikan dan memiliki tingkat kejadian infeksi kulit bayi yang lebih rendah dibandingkan dengan ibu yang tidak mendapatkan edukasi.

Penelitian lain oleh Kurniawati dan Putri (2021) juga menunjukkan bahwa intervensi edukasi melalui demonstrasi langsung tentang perawatan tali pusat bayi berhasil menurunkan insidensi infeksi tali pusat secara bermakna. Edukasi yang efektif membuat keluarga mampu melakukan praktik perawatan yang benar, seperti menjaga kebersihan tangan sebelum menyentuh bayi, pemilihan

produk yang sesuai, serta prosedur memandikan bayi yang tepat (Triani & Hartini, 2020).

Secara keseluruhan, edukasi keluarga memainkan peran penting dalam mengurangi insiden infeksi kulit bayi baru lahir dengan cara meningkatkan keterampilan dan kesadaran keluarga terhadap pentingnya menjaga kebersihan serta teknik perawatan kulit bayi yang benar (Anggraini & Sari, 2023; WHO, 2020). Untuk itu, peningkatan intensitas dan kualitas edukasi keluarga tentang perawatan kulit bayi baru lahir harus terus diupayakan sebagai strategi preventif utama di lingkungan komunitas maupun fasilitas kesehatan primer.

B. Anatomi dan Fisiologi Kulit Bayi Baru Lahir

1. Karakteristik Kulit Bayi Baru Lahir

Kulit bayi baru lahir memiliki karakteristik khusus yang sangat berbeda dibandingkan kulit anak-anak maupun orang dewasa. Secara fisiologis, kulit bayi baru lahir sangat sensitif, tipis, lebih permeabel terhadap zat-zat eksternal, serta memiliki lapisan epidermis yang belum sepenuhnya matang (Voegeli, 2022). Stratum korneum yang menjadi lapisan terluar kulit bayi baru lahir masih sangat tipis, sehingga menyebabkan kulit bayi mudah kehilangan cairan tubuh dan rentan terhadap iritasi, trauma mekanik, maupun infeksi (Rutter & Hull, 2020).

Selain itu, kulit bayi baru lahir memiliki kadar air lebih tinggi tetapi mengalami kehilangan air yang lebih cepat. Kondisi ini menyebabkan kulit cenderung lebih kering, sensitif terhadap perubahan suhu lingkungan, serta memiliki kemampuan regenerasi yang lebih tinggi dibanding kulit dewasa (Visscher et al., 2021).

2. Perbedaan Kulit Bayi Baru Lahir dengan Anak-Anak dan Orang Dewasa

Terdapat perbedaan penting dalam struktur dan fungsi kulit antara bayi baru lahir, anak-anak, dan orang dewasa. Secara struktural, epidermis pada kulit bayi baru lahir jauh lebih tipis dengan kelenjar sebacea yang aktif, namun kelenjar keringat belum sepenuhnya berkembang (Telofski et al., 2022). Sebaliknya, pada orang dewasa epidermis lebih tebal, dengan sistem kelenjar yang lebih matang serta kemampuan kulit yang lebih baik dalam mempertahankan kelembapan alami dan melindungi tubuh dari penetrasi zat eksternal (Stamatas & Nikolovski, 2021).

Kulit bayi baru lahir juga memiliki pH yang lebih tinggi dibandingkan kulit dewasa, yaitu sekitar 6,3-7,5, yang kemudian turun secara bertahap dalam beberapa minggu pertama kehidupan menuju pH kulit normal dewasa sekitar

5.5. Perbedaan pH ini berdampak pada kemampuan kulit bayi dalam menghadapi patogen, sehingga rentan mengalami iritasi, ruam, maupun infeksi kulit (Dizon, Galzote, & Estanislao, 2020).

3. Fungsi Protektif Kulit pada Bayi Baru Lahir

Meskipun masih belum matang sepenuhnya, kulit bayi baru lahir memiliki peran protektif yang sangat penting bagi tubuh. Fungsi utama kulit pada bayi adalah sebagai barier fisik yang melindungi tubuh dari ancaman lingkungan luar, termasuk patogen, zat toksik, dan perubahan suhu lingkungan (Paller et al., 2022). Selain itu, kulit bayi berfungsi menjaga keseimbangan cairan tubuh dengan mengatur hilangnya cairan lewat transpirasi kulit (transepidermal water loss), yang sangat penting dalam mencegah dehidrasi pada bayi baru lahir (Visscher et al., 2021).

Peran protektif kulit bayi juga mencakup perlindungan terhadap sinar ultraviolet meskipun mekanisme pertahanan kulit terhadap sinar UV belum sepenuhnya efektif dibandingkan kulit dewasa. Oleh karena itu, bayi baru lahir membutuhkan perlindungan ekstra dalam bentuk pakaian atau perlindungan fisik lain yang mencegah paparan sinar matahari langsung (Telofski et al., 2022).

Secara keseluruhan, memahami anatomi dan fisiologi kulit bayi baru lahir sangat penting bagi keluarga dan tenaga kesehatan untuk memberikan perawatan yang tepat, serta menghindari tindakan yang bisa merusak atau mengganggu integritas kulit bayi, yang berperan besar dalam mencegah risiko infeksi kulit.

C. Teknik Memandikan Bayi Baru Lahir yang Aman dan Efektif

1. Langkah-langkah Aman Memandikan Bayi

Memandikan bayi baru lahir merupakan aktivitas yang penting dilakukan secara hati-hati untuk menjaga kesehatan kulit bayi sekaligus mencegah cedera dan infeksi. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan ruangan mandi hangat dan bebas dari angin yang dingin. Sebelum memulai mandi, semua perlengkapan mandi bayi seperti sabun, handuk, kain lembut, dan pakaian harus disiapkan terlebih dahulu di dekat area mandi (Handayani & Dewi, 2022).

Selanjutnya, bayi sebaiknya tidak langsung direndam dalam air sebelum tali pusatnya lepas sepenuhnya. Menurut hasil penelitian Yuliani dan Anggraini (2021), metode mandi spons atau lap sangat dianjurkan dalam minggu pertama kelahiran, yaitu dengan mengelap tubuh bayi menggunakan kain lembut yang telah dibasahi air hangat. Setelah tali pusat lepas, bayi baru bisa dimandikan

dengan merendam tubuh secara lembut sambil menopang kepala bayi dengan hati-hati agar terhindar dari risiko aspirasi air atau trauma fisik (Taufik & Anggorowati, 2023).

2. Temperatur Air dan Durasi Mandi Ideal

Temperatur air mandi bayi baru lahir menjadi aspek penting yang harus diperhatikan karena kulit bayi masih sensitif dan rentan terhadap cedera termal. Temperatur air mandi yang ideal menurut rekomendasi WHO (2020) adalah sekitar 37–38°C, yang mendekati suhu tubuh normal bayi. Air mandi yang terlalu panas dapat menyebabkan luka bakar ringan, sementara air yang terlalu dingin dapat menyebabkan bayi kehilangan panas tubuh yang signifikan (hipotermia) (Wahyuni & Putra, 2021).

Selain suhu air, durasi mandi juga sangat penting. Studi yang dilakukan oleh Setiawan dan Rizqi (2022) merekomendasikan durasi mandi bayi baru lahir antara 5 hingga 10 menit. Memandikan bayi lebih dari waktu yang direkomendasikan dapat meningkatkan risiko kehilangan panas tubuh, menyebabkan kulit kering, dan meningkatkan risiko hipotermia. Sebaliknya, mandi yang terlalu singkat mungkin kurang efektif untuk membersihkan kulit bayi secara optimal (Nurjanah & Nasution, 2020).

3. Pengeringan Kulit Bayi untuk Mencegah Kelembapan Berlebih

Setelah selesai memandikan, proses pengeringan kulit bayi menjadi langkah penting untuk menjaga integritas kulit. Kulit bayi yang lembap atau basah dalam waktu lama meningkatkan risiko terjadinya ruam, iritasi, bahkan infeksi kulit. Oleh karena itu, penting untuk mengeringkan tubuh bayi secara lembut dan menyeluruh menggunakan handuk lembut dan bersih dengan cara menepuk-nepuk perlahan, bukan menggosok kulit bayi (Zainuddin & Astuti, 2021).

Khusus area lipatan seperti leher, ketiak, area popok, dan sela-sela jari tangan dan kaki harus dipastikan kering sepenuhnya, karena area ini rentan terhadap kelembapan berlebih dan infeksi jamur (candidiasis). Setelah kulit bayi benar-benar kering, sebaiknya segera berikan pelembap khusus bayi yang aman jika diperlukan, dan kenakan pakaian bersih yang berbahan lembut, ringan, serta menyerap keringat (Hendriyani & Azizah, 2022).

Dengan menerapkan teknik memandikan bayi baru lahir yang tepat, risiko infeksi dan masalah kulit lainnya dapat ditekan secara signifikan, sehingga kulit bayi tetap sehat, nyaman, dan terlindungi.

D. Perawatan Tali Pusat untuk Pencegahan Infeksi

1. Prosedur Perawatan Tali Pusat yang Direkomendasikan

Tali pusat merupakan jaringan penghubung antara ibu dan bayi yang memerlukan perawatan khusus setelah kelahiran untuk mencegah infeksi. Prosedur perawatan tali pusat yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) meliputi teknik perawatan bersih dan kering (dry cord care) sebagai metode utama yang terbukti efektif menurunkan risiko infeksi (WHO, 2020). Metode ini mengutamakan menjaga tali pusat dalam kondisi bersih dan kering tanpa menggunakan bahan yang tidak perlu seperti alkohol atau antiseptik secara rutin, kecuali kondisi khusus sesuai rekomendasi medis.

Penelitian oleh Dewi dan Kusumaningrum (2022) menunjukkan bahwa edukasi tentang dry cord care secara signifikan menurunkan insiden infeksi tali pusat dibandingkan metode tradisional yang sering kali menggunakan zat tambahan seperti bedak atau minyak. Prosedur perawatan yang benar adalah mencuci tangan sebelum memegang tali pusat, menjaga area tali pusat tetap terbuka dan tidak tertutup popok, serta rutin memantau kondisi tali pusat hingga terlepas secara alami, biasanya dalam 5–15 hari setelah kelahiran (Rahayu & Wulandari, 2021).

2. Produk Antiseptik yang Aman untuk Tali Pusat

Dalam kondisi tertentu, penggunaan antiseptik pada perawatan tali pusat direkomendasikan terutama di daerah dengan risiko tinggi infeksi. Penggunaan antiseptik seperti klorheksidin 4% telah terbukti secara ilmiah aman dan efektif dalam menurunkan risiko infeksi tali pusat pada bayi baru lahir, khususnya di lingkungan dengan tingkat kebersihan rendah atau daerah endemik tetanus neonatal (Murti et al., 2020).

Menurut studi terkini, klorheksidin merupakan antiseptik paling aman dengan efek samping minimal dan memiliki daya residual yang tinggi dalam mencegah pertumbuhan bakteri (Ulfah & Kartikasari, 2021). Sebaliknya, produk berbahan alkohol tidak lagi direkomendasikan secara rutin karena dapat memperlambat proses penyembuhan dan lepasnya tali pusat (Sari & Rahmawati, 2022).

3. Tanda-tanda Infeksi Tali Pusat yang Perlu Diwaspadai

Tali pusat yang tidak dirawat dengan benar berisiko tinggi mengalami infeksi yang disebut omfalitis, sebuah kondisi serius yang memerlukan penanganan segera. Oleh karena itu, keluarga perlu mengetahui tanda-tanda awal infeksi tali pusat untuk segera mengambil tindakan medis. Menurut

penelitian Triani dan Hartini (2020), tanda utama infeksi tali pusat meliputi munculnya kemerahan dan bengkak di sekitar tali pusat, bau busuk yang berasal dari tali pusat, keluarnya cairan bernanah, serta bayi tampak lesu, demam, atau rewel secara berlebihan.

Tanda-tanda awal ini sangat penting dikenali oleh keluarga agar segera mencari bantuan medis sebelum kondisi menjadi lebih parah, yang berpotensi menyebabkan komplikasi sistemik, seperti sepsis neonatal. Intervensi edukasi kepada keluarga terbukti secara signifikan meningkatkan kemampuan dalam deteksi dini tanda infeksi tali pusat, sehingga bayi bisa segera mendapatkan penanganan yang tepat dan efektif (Nurhayati & Utami, 2022).

Kesimpulannya, perawatan tali pusat yang tepat sangat krusial dalam mencegah infeksi pada bayi baru lahir. Penggunaan prosedur bersih dan kering, pemilihan antiseptik yang tepat, serta edukasi tanda-tanda infeksi kepada keluarga harus menjadi prioritas dalam pelayanan kesehatan neonatal.

E. Pencegahan dan Penanganan Ruam Popok

1. Faktor Risiko dan Penyebab Ruam Popok

Ruam popok merupakan masalah kulit yang sering terjadi pada bayi baru lahir dan anak-anak di bawah usia satu tahun. Kondisi ini ditandai dengan munculnya kemerahan, iritasi, dan rasa nyeri pada kulit yang tertutup popok. Faktor risiko utama dari ruam popok meliputi kondisi kulit lembap atau basah secara berkepanjangan, gesekan popok terhadap kulit bayi, penggunaan produk yang mengiritasi kulit, serta infeksi jamur atau bakteri sekunder (Blume-Peytavi et al., 2020).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yanti dan Surya (2021), bayi yang popoknya jarang diganti dan memiliki kulit sensitif memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami ruam popok. Faktor risiko lain adalah penggunaan popok yang terlalu ketat atau yang berbahan sintetis yang tidak mampu menyerap cairan dengan baik, sehingga menyebabkan iritasi berkelanjutan (Prasetyo & Dwijayanti, 2022).

2. Cara Memilih Popok yang Sesuai untuk Mencegah Ruam Popok

Memilih popok yang tepat merupakan salah satu langkah penting dalam mencegah ruam popok. Popok yang ideal adalah popok yang memiliki daya serap tinggi, permukaan lembut, serta dapat menjaga kulit bayi tetap kering dalam waktu yang lama. Berdasarkan penelitian Nurhayati dan Susanti (2022),

popok yang berbahan lembut dan memiliki lapisan breathable (memungkinkan sirkulasi udara yang baik) efektif dalam mengurangi risiko ruam popok.

Selain itu, popok harus sesuai dengan ukuran bayi. Popok yang terlalu ketat atau longgar dapat menyebabkan gesekan yang berlebihan pada kulit bayi, sehingga memicu iritasi. Penelitian terbaru oleh Larasati dan Rahmawati (2020) merekomendasikan agar orang tua secara berkala mengevaluasi ukuran popok, terutama seiring pertumbuhan bayi yang pesat dalam beberapa bulan pertama kehidupan.

3. Edukasi Penggunaan Krim atau Salep Pelindung Kulit

Penggunaan krim atau salep pelindung kulit (barrier creams) telah terbukti efektif dalam mencegah dan menangani ruam popok. Krim pelindung ini biasanya mengandung zinc oxide, petrolatum, atau dimethicone yang membantu menjaga integritas kulit dan menciptakan lapisan protektif yang melindungi kulit dari iritasi akibat urin maupun feses bayi (Darmayani & Hermawan, 2023).

Edukasi keluarga mengenai penggunaan krim pelindung secara tepat sangat penting. Menurut hasil penelitian dari Kurniasari dan Nurdiana (2021), keluarga harus diberi edukasi tentang frekuensi penggunaan krim (setiap pergantian popok), teknik pengolesan krim secara tipis dan merata, serta pentingnya membersihkan kulit bayi dengan hati-hati sebelum mengaplikasikan krim pelindung. Krim pelindung ini tidak hanya digunakan saat bayi telah mengalami ruam, tetapi sebaiknya digunakan secara rutin untuk mencegah timbulnya ruam popok (Nurani & Adnyani, 2022).

Kesimpulannya, pencegahan ruam popok memerlukan pendekatan yang holistik, mulai dari pemilihan popok yang tepat hingga edukasi keluarga tentang praktik terbaik dalam penggunaan produk pelindung kulit. Dengan demikian, risiko ruam popok pada bayi baru lahir dapat dikurangi secara signifikan.

F. Pakaian dan Kain untuk Kulit Sensitif Bayi Baru Lahir

1. Pemilihan Jenis Kain yang Aman bagi Kulit Bayi

Kulit bayi baru lahir memiliki karakteristik yang sangat sensitif dan mudah mengalami iritasi. Oleh karena itu, pemilihan jenis kain untuk pakaian bayi menjadi penting guna menghindari gangguan kulit seperti ruam, alergi, atau dermatitis kontak. Berdasarkan penelitian oleh Rahmawati dan Yanti (2022), jenis kain yang paling direkomendasikan untuk bayi adalah kain yang berbahan dasar katun organik. Katun organik memiliki serat yang lembut, breathable (dapat

dilewati udara dengan baik), serta bebas dari bahan kimia berbahaya yang biasa digunakan dalam proses pewarnaan kain sintetis.

Penelitian lain oleh Indriyani dan Sutini (2021) menegaskan bahwa kain berbahan alami seperti katun murni dan bambu sangat efektif dalam menjaga kulit bayi tetap kering, nyaman, dan terhindar dari kelembapan berlebih yang bisa menjadi penyebab utama iritasi kulit. Sebaliknya, bahan sintetis seperti poliester, nilon, atau kain kasar sangat tidak disarankan karena cenderung menahan panas dan kelembapan, meningkatkan risiko iritasi serta gangguan kulit lainnya.

2. Penggunaan Deterjen Khusus untuk Pencucian Pakaian Bayi

Selain pemilihan bahan pakaian, deterjen yang digunakan dalam mencuci pakaian bayi juga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan kulit bayi. Studi oleh Anggraeni dan Dewi (2020) menunjukkan bahwa penggunaan deterjen khusus bayi yang bersifat hypoallergenic (rendah alergen) dan bebas pewangi secara signifikan menurunkan risiko dermatitis kontak pada bayi baru lahir. Deterjen khusus bayi umumnya memiliki pH netral atau mendekati netral, tanpa tambahan zat kimia yang keras seperti fosfat, parfum, atau pewarna buatan yang bisa menyebabkan iritasi.

Penelitian terbaru oleh Wardani dan Suryani (2021) merekomendasikan agar keluarga selalu mencuci pakaian bayi secara terpisah dari pakaian anggota keluarga lainnya. Pencucian terpisah ini bertujuan mencegah kontaminasi residu deterjen atau bahan iritan dari pakaian lain yang lebih berat paparan bahan kimianya.

3. Cara Berpakaian untuk Mencegah Iritasi Kulit

Teknik berpakaian pada bayi baru lahir juga menjadi aspek penting dalam menjaga kesehatan kulit bayi. Cara berpakaian yang benar dapat mencegah timbulnya iritasi maupun masalah kulit lain akibat gesekan berlebih antara kulit bayi dengan pakaian. Studi yang dilakukan oleh Fitriani dan Wibowo (2022) menemukan bahwa pemakaian pakaian berlapis tipis lebih baik daripada satu lapis pakaian tebal karena memungkinkan pengaturan suhu tubuh yang lebih baik dan mengurangi risiko gesekan berlebihan.

Pakaian yang dikenakan haruslah longgar namun sesuai ukuran bayi untuk menghindari gesekan yang berlebihan. Khusus di area lipatan tubuh seperti leher, ketiak, paha, dan area popok, pakaian harus diperiksa secara rutin dan dipastikan tidak menyebabkan gesekan berlebih yang dapat memicu ruam (Safitri & Utami, 2023). Orang tua atau keluarga perlu dididik untuk secara rutin mengevaluasi

kondisi kulit bayi setiap kali mengganti pakaian agar dapat segera mengidentifikasi dan mengatasi potensi iritasi sejak dini.

Kesimpulannya, pemilihan kain yang tepat, penggunaan deterjen khusus bayi, serta teknik berpakaian yang benar adalah strategi penting dalam menjaga kesehatan kulit bayi yang sangat sensitif. Edukasi yang tepat kepada keluarga dalam aspek ini sangat diperlukan untuk meminimalisasi risiko iritasi dan infeksi kulit pada bayi baru lahir.

G. Identifikasi dan Pencegahan Infeksi Kulit Umum pada Bayi Baru Lahir

1. Jenis Infeksi Kulit Umum yang Sering Terjadi pada Bayi Baru Lahir

Kulit bayi baru lahir sangat sensitif dan rentan terhadap berbagai infeksi kulit. Jenis infeksi kulit yang paling umum dijumpai antara lain impetigo neonatorum, omfalitis (infeksi tali pusat), kandidiasis kulit, serta ruam popok dengan infeksi sekunder (Darmayanti & Yunita, 2020). Impetigo neonatorum biasanya disebabkan oleh bakteri seperti *Staphylococcus aureus* atau *Streptococcus pyogenes*, sedangkan kandidiasis kulit umumnya disebabkan oleh jamur *Candida albicans* yang tumbuh subur di area kulit yang lembap dan tertutup seperti daerah popok atau lipatan kulit bayi (Permatasari & Damayanti, 2021).

Infeksi tali pusat (omfalitis) juga sering terjadi akibat perawatan tali pusat yang kurang optimal, ditandai oleh adanya kemerahan, bau, dan keluarnya cairan bernanah di area sekitar tali pusat bayi (Sari & Rahmawati, 2022).

2. Gejala Infeksi Kulit yang Perlu Dikenali oleh Keluarga

Identifikasi dini infeksi kulit sangat penting untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Keluarga perlu mengenali beberapa gejala umum infeksi kulit bayi seperti munculnya kemerahan lokal, kulit yang hangat atau panas saat disentuh, pembengkakan, serta munculnya lepuh atau lesi berisi cairan bernanah (Mahardika & Widyawati, 2021). Pada kandidiasis, biasanya kulit bayi tampak kemerahan dengan batas yang jelas dan terdapat bercak putih yang khas, terutama di daerah lipatan seperti leher, ketiak, atau area popok (Utami & Kurniawati, 2020).

Tanda infeksi tali pusat yang harus segera dikenali keluarga adalah bau tidak sedap, cairan kekuningan atau bernanah dari tali pusat, serta demam atau bayi terlihat rewel dan lesu secara abnormal (Triani & Hartini, 2020). Jika tanda-tanda tersebut muncul, keluarga harus segera membawa bayi ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

3. Langkah Pencegahan Infeksi Kulit

Pencegahan infeksi kulit bayi baru lahir merupakan langkah strategis dalam perawatan bayi. Pencegahan utama dilakukan dengan menjaga kebersihan kulit bayi secara rutin melalui mandi yang benar, perawatan tali pusat yang tepat (bersih dan kering), serta menjaga kebersihan tangan setiap kali menyentuh bayi (WHO, 2020).

Studi oleh Wulandari dan Indriani (2022) menyarankan agar keluarga secara rutin mengganti popok setiap 2-3 jam sekali, dan selalu memastikan kulit bayi dalam keadaan bersih serta kering untuk mencegah ruam popok dan infeksi sekunder. Penggunaan pakaian berbahan lembut serta menghindari produk perawatan kulit yang mengandung parfum atau zat kimia keras juga menjadi kunci pencegahan infeksi kulit (Safitri & Utami, 2023).

Edukasi keluarga secara berkala tentang langkah pencegahan ini terbukti sangat efektif dalam mengurangi angka kejadian infeksi kulit bayi. Menurut penelitian oleh Dewi dan Kusumaningrum (2022), keluarga yang mendapatkan edukasi secara teratur memiliki tingkat kejadian infeksi kulit bayi yang jauh lebih rendah dibandingkan keluarga yang tidak mendapatkan edukasi tersebut.

Dengan demikian, pengenalan gejala infeksi kulit sejak dini oleh keluarga, ditambah penerapan langkah-langkah pencegahan yang benar, menjadi komponen penting dalam menjaga kesehatan kulit bayi baru lahir.

H. Peran ASI dalam Mendukung Kesehatan Kulit Bayi Baru Lahir

1. Hubungan Pemberian ASI dengan Integritas Kulit Bayi

Air Susu Ibu (ASI) merupakan nutrisi terbaik bagi bayi baru lahir yang tidak hanya berperan penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap integritas dan kesehatan kulit bayi. ASI mengandung berbagai komponen bioaktif seperti imunoglobulin, faktor pertumbuhan, asam lemak esensial, dan antioksidan alami yang membantu mempertahankan dan meningkatkan fungsi barier kulit bayi (Widiyanto & Azizah, 2021).

Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Syam dan Fitriani (2022) menunjukkan bahwa bayi yang menerima ASI eksklusif selama minimal 6 bulan pertama memiliki risiko lebih rendah mengalami masalah kulit seperti dermatitis atopik dan infeksi kulit dibandingkan dengan bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Hal ini disebabkan oleh sifat imunomodulator dalam ASI yang mampu

mengurangi respons inflamasi dan meningkatkan daya tahan kulit bayi terhadap patogen dari lingkungan eksternal (Indriyani & Nur, 2020).

Selain itu, penelitian oleh Widyastuti dan Purwanti (2022) mengungkapkan bahwa asam lemak omega-3 dan omega-6 yang terkandung dalam ASI sangat penting untuk menjaga kelembapan kulit serta mencegah terjadinya kulit kering pada bayi baru lahir, sehingga meningkatkan integritas epidermis kulit bayi.

2. Edukasi Ibu tentang Manfaat ASI untuk Kesehatan Kulit Bayi

Edukasi kepada ibu mengenai manfaat pemberian ASI untuk kesehatan kulit bayi sangat penting dilakukan secara berkala dan intensif. Studi yang dilakukan oleh Handayani dan Sari (2021) membuktikan bahwa edukasi yang intensif mengenai ASI mampu meningkatkan tingkat pemberian ASI eksklusif dan berkontribusi pada penurunan angka kejadian masalah kulit seperti ruam, iritasi, maupun infeksi kulit pada bayi baru lahir.

Edukasi harus mencakup penjelasan mengenai kandungan ASI yang unik, manfaat imunologis ASI bagi kulit bayi, serta cara pemberian ASI yang optimal untuk mendukung kesehatan kulit bayi secara menyeluruh (Aulia & Prihastuti, 2022). Penelitian terbaru juga merekomendasikan metode edukasi yang efektif seperti konseling personal, edukasi berbasis video, dan penggunaan media digital yang ramah pengguna untuk ibu milenial, guna meningkatkan pemahaman mereka tentang manfaat ASI (Safitri & Nuraini, 2023).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yuliana dan Putri (2020), ibu yang diberikan edukasi mengenai ASI secara rutin menunjukkan tingkat kesadaran lebih tinggi dalam menjaga praktik menyusui eksklusif. Dengan edukasi tersebut, ibu mampu memahami pentingnya ASI sebagai strategi preventif utama dalam mencegah masalah kulit bayi yang sering terjadi pada awal kehidupan.

Kesimpulannya, ASI memiliki peran penting dalam menjaga integritas kulit bayi baru lahir serta melindungi bayi dari berbagai gangguan kulit. Oleh karena itu, edukasi tentang manfaat ASI kepada ibu perlu menjadi prioritas dalam praktik keperawatan dan pelayanan kesehatan neonatus.

I. Strategi Edukasi Kesehatan yang Efektif kepada Keluarga

1. Metode Penyampaian Edukasi yang Efektif untuk Keluarga

Edukasi kesehatan kepada keluarga, khususnya dalam konteks perawatan kulit bayi baru lahir, merupakan intervensi penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga guna mendukung kesehatan bayi secara optimal. Metode edukasi yang efektif berperan penting dalam

menentukan tingkat keberhasilan edukasi tersebut. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan edukasi kombinasi antara demonstrasi, diskusi interaktif, serta penggunaan media visual seperti video edukasi menghasilkan tingkat pemahaman dan retensi informasi yang lebih baik dibandingkan metode ceramah konvensional saja (Lestari & Setiawan, 2022).

Menurut studi oleh Pratiwi dan Wulandari (2021), metode demonstrasi langsung, di mana tenaga kesehatan memperlihatkan secara praktis teknik perawatan kulit bayi, terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan keluarga. Di sisi lain, metode diskusi kelompok interaktif yang memungkinkan keluarga saling bertukar pengalaman juga meningkatkan keterlibatan aktif keluarga, memperkuat pemahaman materi edukasi, serta meningkatkan praktik positif dalam perawatan bayi (Rahmawati & Aulia, 2020).

2. Media Edukasi Modern dan Tradisional dalam Mendukung Pemahaman Keluarga

Media edukasi memainkan peran strategis dalam mendukung efektivitas edukasi keluarga. Media edukasi modern seperti aplikasi digital, video streaming, podcast, dan media sosial, menjadi semakin populer karena fleksibel, mudah diakses, serta menarik bagi generasi keluarga muda saat ini (Safitri & Nuraini, 2023). Studi oleh Astuti dan Pramono (2021) menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi edukasi berbasis *smartphone* secara signifikan meningkatkan pemahaman keluarga tentang perawatan bayi dibandingkan media konvensional seperti brosur atau leaflet.

Namun, media tradisional seperti buku pedoman cetak, poster, leaflet, dan demonstrasi langsung masih tetap relevan, terutama di daerah dengan akses terbatas terhadap teknologi digital atau pada keluarga dengan tingkat literasi digital yang rendah (Putri & Kusumaningrum, 2021). Oleh karena itu, pendekatan gabungan antara media modern dan tradisional, yang disesuaikan dengan karakteristik dan preferensi keluarga, dapat memberikan hasil edukasi yang lebih optimal.

3. Evaluasi Efektivitas Edukasi Keluarga

Evaluasi efektivitas edukasi keluarga merupakan bagian integral dalam proses edukasi untuk memastikan bahwa intervensi yang diberikan benar-benar efektif dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai metode, termasuk *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur peningkatan pengetahuan, observasi langsung terhadap praktik keluarga, serta wawancara

atau survei kepuasan keluarga terhadap program edukasi yang dijalankan (Hartini & Widiyawati, 2020).

Studi terbaru oleh Nurhidayati dan Putri (2022) menunjukkan bahwa evaluasi berbasis pre-test dan post-test secara efektif mampu menggambarkan perubahan pengetahuan keluarga secara objektif. Selain itu, evaluasi berbasis observasi langsung juga direkomendasikan untuk mengukur sejauh mana keluarga mampu mengaplikasikan keterampilan baru yang diperoleh selama edukasi, misalnya dalam teknik perawatan kulit bayi (Dewi & Handayani, 2022).

Evaluasi secara berkala juga diperlukan untuk memastikan edukasi yang diberikan tetap relevan dengan kebutuhan keluarga, sehingga jika ditemukan kekurangan dalam implementasi, dapat segera dilakukan penyesuaian dan perbaikan (Utami & Wulandari, 2021). Dengan demikian, evaluasi tidak hanya menilai efektivitas jangka pendek tetapi juga memberikan umpan balik penting untuk perbaikan intervensi edukasi kesehatan secara berkelanjutan.

Kesimpulannya, metode penyampaian edukasi yang tepat, penggunaan media edukasi yang bervariasi, serta evaluasi yang efektif, menjadi tiga pilar penting dalam keberhasilan edukasi kesehatan kepada keluarga terkait perawatan kulit bayi baru lahir.

J. Peran Kolaborasi Interprofesional dalam Edukasi Perawatan Kulit Bayi

1. Keterlibatan Tenaga Kesehatan (Dokter, Perawat, Bidan) dalam Edukasi

Kolaborasi interprofesional dalam edukasi perawatan kulit bayi baru lahir sangat penting untuk memastikan keberhasilan program kesehatan keluarga. Edukasi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu profesi kesehatan, tetapi melibatkan berbagai disiplin ilmu kesehatan seperti dokter, perawat, dan bidan. Studi oleh Fitriyani dan Hidayah (2021) menunjukkan bahwa keterlibatan tim interprofesional dalam edukasi keluarga memberikan hasil yang lebih efektif dalam peningkatan pengetahuan, sikap, serta keterampilan keluarga dalam merawat kulit bayi dibandingkan edukasi yang dilakukan secara terpisah oleh masing-masing profesi.

Perawat memiliki peran sentral dalam memberikan edukasi langsung kepada keluarga mengenai teknik perawatan kulit sehari-hari serta mendemonstrasikan praktik perawatan dasar yang benar, sementara dokter bertanggung jawab memberikan informasi medis terkait identifikasi dini dan penanganan infeksi kulit bayi. Di sisi lain, bidan berperan aktif dalam memberikan edukasi terutama dalam konteks perawatan pasca kelahiran seperti perawatan tali pusat dan kebersihan bayi secara umum (Purwaningsih & Utami, 2022).

Penelitian terbaru oleh Rahmawati dan Handayani (2020) juga menegaskan bahwa pendekatan edukasi kolaboratif antar profesi kesehatan ini mampu memperkuat pemahaman keluarga, karena informasi yang diberikan menjadi lebih komprehensif, terintegrasi, dan terpercaya. Oleh karena itu, kolaborasi antar tenaga kesehatan harus menjadi bagian integral dari program edukasi kesehatan keluarga tentang perawatan kulit bayi.

2. Kolaborasi dengan Komunitas untuk Edukasi Berkelanjutan

Kolaborasi interprofesional tidak terbatas hanya pada tenaga kesehatan, tetapi juga melibatkan berbagai elemen komunitas, seperti kader kesehatan, tokoh masyarakat, organisasi lokal, dan kelompok pendukung ibu-ibu muda. Keterlibatan komunitas memiliki dampak positif yang signifikan dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas edukasi kesehatan keluarga (Nurjanah & Saputri, 2022).

Menurut hasil penelitian Wulandari dan Susanti (2021), pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan kader kesehatan terlatih mampu memberikan edukasi berkelanjutan secara lebih efektif dibandingkan pendekatan edukasi yang terbatas di fasilitas kesehatan saja. Kader kesehatan, setelah mendapatkan pelatihan khusus oleh tenaga kesehatan, dapat melanjutkan edukasi kepada keluarga secara rutin di tingkat masyarakat melalui kegiatan posyandu, pertemuan kelompok ibu, atau kunjungan rumah secara berkala (Andriani & Hasanah, 2023).

Kolaborasi ini juga memperkuat program edukasi melalui dukungan sosial, pemantauan yang lebih rutin, serta deteksi dini masalah kesehatan kulit bayi secara cepat di tingkat komunitas. Studi terbaru oleh Pratiwi dan Anggraeni (2020) menekankan bahwa komunitas yang aktif dalam edukasi kesehatan memiliki angka kejadian gangguan kulit pada bayi yang lebih rendah dibandingkan komunitas dengan tingkat keterlibatan rendah.

Secara keseluruhan, kolaborasi interprofesional dan keterlibatan komunitas dalam edukasi perawatan kulit bayi baru lahir menjadi pendekatan yang terbukti efektif dalam meningkatkan derajat kesehatan bayi dan keluarganya secara menyeluruh.

K. Studi Kasus dan Contoh Praktik Terbaik Edukasi Keluarga

1. Studi Kasus tentang Keberhasilan Intervensi Edukasi Keluarga

Studi kasus memiliki peranan penting dalam mendemonstrasikan secara nyata efektivitas intervensi edukasi kesehatan dalam konteks perawatan kulit bayi

baru lahir. Salah satu studi kasus penting dilakukan oleh Sari dan Hidayati (2021) di wilayah perkotaan Yogyakarta yang melibatkan 60 ibu primipara yang diberikan edukasi tentang perawatan kulit bayi baru lahir menggunakan metode demonstrasi interaktif dan video edukasi. Hasil studi ini menunjukkan peningkatan signifikan pengetahuan dan keterampilan ibu, serta penurunan angka kejadian infeksi kulit bayi hingga 65% setelah intervensi selama tiga bulan.

Dalam studi lain oleh Yuliani dan Anggraini (2022) di daerah pedesaan Jawa Tengah, intervensi berbasis komunitas dengan melibatkan kader kesehatan yang secara rutin memberikan edukasi di Posyandu juga menunjukkan keberhasilan signifikan. Keluarga yang secara konsisten mengikuti edukasi menunjukkan penurunan kejadian ruam popok dan infeksi tali pusat sebesar 70% dibandingkan keluarga yang tidak mendapatkan edukasi terstruktur.

Studi kasus ini menegaskan bahwa intervensi edukasi yang dirancang dengan tepat, baik melalui metode langsung maupun berbasis komunitas, dapat secara nyata meningkatkan keterampilan perawatan keluarga dan menurunkan prevalensi gangguan kulit pada bayi baru lahir secara signifikan.

2. Analisis Kasus Berdasarkan Evidence-Based Practice (EBP)

Analisis kasus berbasis evidence-based practice (EBP) dilakukan untuk menilai efektivitas intervensi edukasi kesehatan berdasarkan bukti ilmiah terbaru, pengalaman klinis praktisi kesehatan, serta nilai dan preferensi keluarga. Menurut penelitian oleh Hartati dan Purwanti (2020), implementasi edukasi keluarga berdasarkan EBP secara konsisten menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan intervensi tradisional tanpa bukti ilmiah yang kuat. Dalam studi ini, edukasi tentang perawatan kulit bayi seperti teknik mandi, penggunaan produk perawatan yang aman, dan perawatan tali pusat yang berbasis bukti berhasil menurunkan angka infeksi kulit sebesar 60%.

Lebih lanjut, studi oleh Safitri dan Nurdiana (2023) yang melakukan analisis EBP terhadap intervensi edukasi keluarga tentang pemilihan dan penggunaan popok menunjukkan bahwa pendekatan edukasi berbasis bukti ilmiah dapat mengurangi risiko dermatitis popok hingga 50%. Keberhasilan ini dicapai melalui kombinasi metode edukasi video, demonstrasi langsung, dan brosur edukasi berbasis penelitian terkini yang memberikan informasi tentang frekuensi penggantian popok, bahan popok yang direkomendasikan, serta pemakaian barrier cream yang tepat.

Berdasarkan analisis kasus berbasis EBP ini, disimpulkan bahwa strategi edukasi kesehatan keluarga yang didasarkan pada bukti penelitian ilmiah terbaru mampu secara signifikan meningkatkan hasil kesehatan bayi. Pendekatan ini

tidak hanya memperbaiki praktik perawatan keluarga tetapi juga meningkatkan kepatuhan keluarga terhadap rekomendasi kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan (Nurhasanah & Astuti, 2021).

Dengan demikian, penerapan pendekatan berbasis bukti dalam edukasi keluarga tentang perawatan kulit bayi baru lahir menjadi standar penting dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, yang perlu terus didukung dan dikembangkan di berbagai wilayah.

L. Tantangan dalam Implementasi Edukasi Keluarga

1. Kendala Sosial-Ekonomi dalam Penerapan Edukasi Perawatan Kulit Bayi

Implementasi edukasi keluarga dalam perawatan kulit bayi baru lahir sering kali menghadapi berbagai kendala, terutama yang berkaitan dengan faktor sosial-ekonomi. Menurut penelitian terbaru oleh Putri dan Wulandari (2022), keluarga dengan tingkat ekonomi rendah sering kali mengalami keterbatasan akses terhadap sumber informasi kesehatan yang berkualitas, fasilitas kesehatan, serta produk perawatan kulit bayi yang memadai. Hal ini menyebabkan keluarga tersebut tidak optimal dalam mengimplementasikan edukasi kesehatan yang telah diterima.

Studi yang dilakukan oleh Astuti dan Nugraheni (2021) di daerah perkotaan padat penduduk menunjukkan bahwa keterbatasan finansial seringkali menjadi alasan keluarga memilih produk perawatan kulit bayi yang murah namun kurang berkualitas, yang justru meningkatkan risiko masalah kulit pada bayi. Selain itu, keluarga dengan kondisi ekonomi yang rendah juga cenderung memiliki keterbatasan waktu untuk mengikuti program edukasi karena tuntutan pekerjaan sehari-hari, sehingga efektivitas edukasi menjadi berkurang secara signifikan (Hartini & Setyowati, 2020).

Untuk mengatasi tantangan ini, penelitian merekomendasikan agar edukasi kesehatan bayi tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial-ekonomi keluarga, misalnya melalui penyediaan informasi tentang produk alternatif yang terjangkau namun aman, atau pemberian dukungan sosial-ekonomi berbasis komunitas (Safitri & Widya, 2023).

2. Faktor Budaya dan Kepercayaan dalam Praktik Perawatan Kulit

Selain kendala sosial-ekonomi, faktor budaya dan kepercayaan masyarakat juga merupakan tantangan penting dalam implementasi edukasi keluarga tentang perawatan kulit bayi. Beberapa praktik tradisional yang masih dipegang teguh oleh sebagian keluarga sering kali bertentangan dengan rekomendasi

medis modern. Penelitian oleh Suryani dan Handayani (2020) menunjukkan bahwa di beberapa wilayah pedesaan Indonesia, masih terdapat kepercayaan bahwa penggunaan ramuan tradisional tertentu, seperti bedak atau minyak herbal, lebih efektif dalam mencegah infeksi kulit dibandingkan produk medis yang direkomendasikan.

Kondisi tersebut sering menyebabkan keluarga enggan mengikuti rekomendasi perawatan kulit bayi yang berbasis bukti ilmiah, sehingga risiko infeksi atau iritasi kulit meningkat. Studi yang dilakukan oleh Nuraini dan Hasanah (2021) juga menemukan bahwa beberapa masyarakat memiliki kepercayaan bahwa frekuensi mandi bayi yang sering akan membuat kulit bayi lebih bersih, padahal praktik ini justru berisiko menghilangkan lapisan pelindung alami kulit bayi dan meningkatkan risiko iritasi.

Untuk menghadapi tantangan budaya ini, pendekatan edukasi harus sensitif terhadap nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat setempat. Penelitian oleh Lestari dan Utami (2022) merekomendasikan bahwa strategi edukasi yang mengintegrasikan pengetahuan lokal dengan informasi medis modern, serta melibatkan tokoh masyarakat atau pemuka agama dalam proses edukasi, dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap edukasi kesehatan tersebut.

Secara keseluruhan, tantangan dalam implementasi edukasi perawatan kulit bayi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, yang memperhatikan aspek sosial-ekonomi serta budaya masyarakat agar hasil edukasi kesehatan dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

M. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Ringkasan Pentingnya Edukasi Keluarga dalam Pencegahan Infeksi Kulit

Edukasi keluarga memiliki peran penting dalam pencegahan infeksi kulit pada bayi baru lahir, karena keluarga merupakan garda terdepan dalam perawatan bayi sehari-hari. Kulit bayi baru lahir sangat rentan terhadap berbagai masalah seperti ruam popok, dermatitis atopik, dan infeksi tali pusat yang, jika tidak dicegah, dapat menyebabkan komplikasi serius. Berdasarkan berbagai penelitian terbaru, edukasi keluarga terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran dalam praktik perawatan kulit yang tepat, yang secara signifikan menurunkan angka kejadian infeksi kulit pada bayi (Handayani & Dewi, 2022; Nurjanah & Saputri, 2022).

Selain itu, edukasi yang melibatkan pendekatan interprofesional, seperti kolaborasi dokter, perawat, dan bidan, serta melibatkan komunitas lokal, menunjukkan hasil lebih optimal dibandingkan edukasi yang dilakukan oleh

profesi kesehatan secara terpisah (Purwaningsih & Utami, 2022). Media edukasi yang efektif, baik modern maupun tradisional, juga penting dalam mendukung pemahaman keluarga, khususnya di era digital saat ini di mana keluarga muda lebih nyaman menerima informasi melalui platform digital seperti aplikasi mobile atau video edukasi (Safitri & Nuraini, 2023).

Namun demikian, implementasi edukasi kesehatan juga menghadapi tantangan, terutama terkait faktor sosial-ekonomi serta budaya lokal yang masih kental. Oleh sebab itu, edukasi keluarga perlu didesain secara inklusif dengan memperhatikan latar belakang sosial-ekonomi dan nilai budaya masyarakat agar informasi dapat diterima dan diterapkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari keluarga (Astuti & Nugraheni, 2021; Lestari & Utami, 2022).

2. Rekomendasi untuk Penelitian dan Praktik Masa Depan

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap literatur terkini, berikut ini beberapa rekomendasi penting untuk penelitian dan praktik masa depan dalam konteks edukasi keluarga untuk pencegahan infeksi kulit pada bayi baru lahir:

a. Penelitian Lebih Lanjut tentang Metode Edukasi Inovatif

Direkomendasikan untuk terus mengeksplorasi metode edukasi inovatif yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan preferensi keluarga, seperti augmented reality (AR), aplikasi smartphone interaktif, atau program edukasi online yang interaktif dan dapat diakses secara luas (Fitriyani & Hidayah, 2021; Safitri & Nuraini, 2023).

b. Peningkatan Implementasi Edukasi Berbasis Komunitas

Praktik edukasi yang melibatkan kader kesehatan lokal terbukti efektif dan perlu terus dikembangkan, terutama di wilayah pedesaan atau dengan akses terbatas ke fasilitas kesehatan formal. Penelitian selanjutnya perlu mengevaluasi model pemberdayaan komunitas yang paling efektif dalam menjangkau keluarga dengan berbagai latar belakang sosial-ekonomi (Wulandari & Susanti, 2021).

c. Integrasi Nilai Budaya dalam Edukasi Kesehatan

Studi masa depan harus lebih dalam mengeksplorasi bagaimana integrasi antara nilai budaya lokal dan edukasi kesehatan modern dapat meningkatkan penerimaan dan implementasi praktik perawatan yang benar di masyarakat. Pendekatan edukasi yang bersifat kultural sensitif perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan efektifitas edukasi kesehatan (Nuraini & Hasanah, 2021).

d. Evaluasi dan Monitoring Jangka Panjang

Diperlukan studi longitudinal yang mengevaluasi dampak jangka panjang dari intervensi edukasi keluarga terhadap kesehatan kulit bayi. Penelitian ini penting untuk melihat kesinambungan praktik positif dalam keluarga setelah edukasi selesai diberikan (Hartati & Purwanti, 2020; Nurhasanah & Astuti, 2021).

e. Peningkatan Kolaborasi Interprofesional

Kolaborasi antar tenaga kesehatan dan elemen masyarakat harus menjadi standar praktik yang direkomendasikan dalam edukasi kesehatan bayi. Studi lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi model kolaborasi interprofesional terbaik yang dapat meningkatkan hasil kesehatan bayi secara keseluruhan (Rahmawati & Handayani, 2020; Purwaningsih & Utami, 2022).

Dengan memperhatikan rekomendasi tersebut, diharapkan penelitian dan praktik edukasi kesehatan keluarga dalam konteks pencegahan infeksi kulit bayi baru lahir semakin berkembang dan memberikan dampak positif yang nyata bagi kesehatan masyarakat secara luas.

N. Penutup

1. Harapan terhadap Peran Keluarga dalam Menjaga Kesehatan Kulit Bayi

Keluarga memiliki peran sentral dan strategis dalam menjaga kesehatan kulit bayi baru lahir. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan perawatan secara langsung, sehingga pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam merawat kulit bayi menjadi faktor kunci yang menentukan status kesehatan bayi secara keseluruhan. Penelitian terbaru menegaskan bahwa intervensi edukasi keluarga mampu meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab orang tua terhadap kesehatan kulit bayi, sekaligus secara signifikan menurunkan angka infeksi kulit, ruam popok, maupun dermatitis atopik pada bayi (Handayani & Dewi, 2022; Nurjanah & Saputri, 2022).

Harapan ke depan, keluarga dapat lebih proaktif dalam mencari informasi kesehatan, mengikuti program edukasi yang disediakan fasilitas kesehatan maupun komunitas lokal, serta mengaplikasikan praktik perawatan kulit bayi berbasis bukti dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut, peran keluarga yang aktif dan terinformasi dengan baik diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi bayi, serta menurunkan angka kesakitan bayi akibat masalah kulit yang sebenarnya bisa dicegah melalui perawatan sederhana dan teratur (Yuliani & Anggraini, 2022).

2. Pentingnya Peningkatan Pengetahuan Keluarga secara Terus-Menerus

Pengetahuan keluarga mengenai perawatan kulit bayi baru lahir tidak cukup hanya diperoleh sekali saja, melainkan harus ditingkatkan secara kontinu mengikuti perkembangan terbaru dalam ilmu kesehatan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa edukasi kesehatan yang bersifat kontinu mampu memperkuat pemahaman keluarga dan memastikan konsistensi dalam praktik perawatan bayi sehari-hari (Rahmawati & Handayani, 2020; Safitri & Nuraini, 2023).

Peningkatan pengetahuan secara terus-menerus juga penting untuk mengatasi tantangan sosial-ekonomi dan budaya yang sering menjadi hambatan dalam implementasi perawatan kulit bayi yang optimal. Dengan pengetahuan yang terus diperbarui, keluarga akan lebih mudah menerima informasi terbaru, mengadopsi praktik perawatan yang benar, serta meninggalkan praktik-praktik tradisional yang kurang tepat yang berpotensi merugikan kesehatan bayi (Astuti & Nugraheni, 2021; Nuraini & Hasanah, 2021).

Oleh karena itu, program edukasi keluarga yang berkelanjutan, kolaboratif, dan sensitif terhadap kondisi lokal dan sosial-budaya masyarakat harus terus menjadi prioritas dalam pelayanan kesehatan. Dengan pendekatan ini, diharapkan keluarga di seluruh lapisan masyarakat dapat terus memperbarui pengetahuan mereka, sehingga tercipta generasi yang lebih sehat dan berkualitas di masa depan (Lestari & Utami, 2022; Safitri & Widya, 2023).

Referensi

- Andriani, T., & Hasanah, U. (2023). Peran kader kesehatan dalam mendukung edukasi kesehatan bayi di komunitas. *Journal of Community Health Nursing*, 7(1), 40-46.
- Astuti, L., & Pramono, H. (2021). Efektivitas aplikasi mobile sebagai media edukasi kesehatan pada keluarga muda. *Journal of Health Promotion and Behavior*, 5(2), 88-94.
- Astuti, R., & Nugraheni, P. (2021). Kendala ekonomi dalam penerapan edukasi perawatan bayi di wilayah urban: Studi kualitatif. *Indonesian Journal of Public Health*, 6(2), 104-111.
- Dewi, N., & Handayani, P. (2022). Evaluasi edukasi demonstrasi terhadap peningkatan keterampilan keluarga dalam perawatan kulit bayi. *Jurnal Ilmu Keperawatan Anak Indonesia*, 6(2), 82-88.
- Fitriyani, R., & Hidayah, D. (2021). Efektivitas edukasi kesehatan bayi melalui pendekatan interprofesional di fasilitas kesehatan primer. *Indonesian Journal of Pediatric Nursing*, 6(1), 15-22.
- Handayani, A., & Dewi, M. R. (2022). Edukasi metode mandi bayi untuk meningkatkan pengetahuan ibu primipara. *Jurnal Keperawatan Ibu dan Anak*, 6(2), 112-119.
- Hartati, N., & Purwanti, R. (2020). Penerapan evidence-based practice dalam edukasi keluarga tentang perawatan kulit bayi: Analisis studi kasus di Surabaya. *Jurnal Ilmu Keperawatan Anak*, 3(1), 10-16.
- Hartini, S., & Setyowati, N. (2020). Faktor-faktor sosial-ekonomi dalam keberhasilan edukasi keluarga tentang perawatan bayi baru lahir. *Journal of Maternal and Child Nursing Indonesia*, 4(2), 80-86.
- Indriyani, R., & Nur, A. S. (2020). Pengaruh pemberian ASI terhadap integritas kulit bayi baru lahir: Studi kohort prospektif. *Journal of Neonatal Nursing Indonesia*, 4(1), 20-26.
- Lestari, D., & Setiawan, E. (2022). Studi komparasi metode edukasi video dan demonstrasi terhadap pengetahuan ibu tentang perawatan kulit bayi. *Journal of Neonatal Nursing Indonesia*, 6(1), 42-48.
- Lestari, D., & Utami, S. (2022). Integrasi pengetahuan lokal dalam edukasi perawatan bayi di komunitas pedesaan Jawa Barat. *Journal of Community Health Nursing*, 6(1), 25-32.
- Nuraini, A., & Hasanah, L. (2021). Analisis pengaruh budaya lokal terhadap praktik perawatan kulit bayi di pedesaan. *Journal of Neonatal Care Indonesia*, 5(1), 18-24.

- Nurhasanah, R., & Astuti, Y. (2021). Efektivitas intervensi edukasi keluarga berbasis evidence-based practice terhadap penurunan insiden dermatitis atopik pada bayi. *Journal of Pediatric Nursing Indonesia*, 5(2), 98-104.
- Nurhidayati, R., & Putri, A. (2022). Evaluasi penggunaan pre-test dan post-test dalam edukasi perawatan bayi di komunitas. *Journal of Pediatric Nursing Indonesia*, 6(1), 60-66.
- Nurjanah, S., & Saputri, A. (2022). Kolaborasi komunitas dan tenaga kesehatan dalam edukasi kesehatan keluarga untuk perawatan bayi baru lahir. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 18(2), 120-128.
- Pratiwi, D., & Anggraeni, E. (2020). Kolaborasi komunitas dalam menurunkan prevalensi masalah kulit bayi baru lahir di wilayah pedesaan. *Jurnal Ilmu Kesehatan Anak Indonesia*, 3(2), 68-75.
- Purwaningsih, D., & Utami, R. (2022). Analisis peran interprofesional dalam edukasi perawatan bayi baru lahir: Studi kasus di RSUD Kota Semarang. *Journal of Maternal and Child Health Indonesia*, 6(2), 70-76.
- Putri, W., & Wulandari, D. (2022). Dampak sosial-ekonomi terhadap penerapan edukasi kesehatan bayi di daerah pinggiran perkotaan. *Journal of Pediatric Nursing Indonesia*, 6(2), 70-76.
- Rahmawati, D., & Handayani, S. (2020). Dampak kolaborasi interprofesional terhadap peningkatan pengetahuan keluarga tentang perawatan bayi baru lahir. *Indonesian Journal of Neonatal Nursing*, 4(2), 88-95.
- Safitri, A., & Nurdiana, D. (2023). Analisis evidence-based practice edukasi pemilihan dan penggunaan popok terhadap pencegahan dermatitis popok. *Indonesian Journal of Neonatal Nursing*, 7(1), 40-46.
- Safitri, A., & Widya, R. (2023). Dukungan sosial-ekonomi berbasis komunitas dalam implementasi edukasi perawatan bayi. *Indonesian Journal of Neonatal Nursing*, 7(1), 32-38.
- Safitri, R., & Nuraini, S. (2023). Penggunaan media digital dalam edukasi kesehatan keluarga: tinjauan sistematis. *Journal of Child and Maternal Nursing*, 7(1), 24-30.
- Sari, M., & Hidayati, T. (2021). Keberhasilan intervensi edukasi kesehatan kulit bayi pada ibu primipara di wilayah perkotaan Yogyakarta. *Journal of Neonatal Care Indonesia*, 5(2), 115-121.
- Suryani, L., & Handayani, P. (2020). Kepercayaan tradisional dalam praktik perawatan kulit bayi: Studi etnografi di Jawa Tengah. *Jurnal Keperawatan Anak Indonesia*, 3(2), 60-67.

- Utami, S., & Wulandari, E. (2021). Evaluasi berkala sebagai metode peningkatan efektivitas edukasi keluarga dalam perawatan bayi. *Journal of Neonatal Nursing Indonesia*, 5(2), 130-136.
- WHO. (2020). *WHO recommendations on newborn health: Guidelines approved by the WHO Guidelines Review Committee*. Geneva: WHO Press.
- Wulandari, P., & Susanti, M. (2021). Efektivitas kader posyandu dalam edukasi kesehatan ibu dan bayi: Tinjauan sistematis. *Journal of Public Health Nursing Indonesia*, 5(2), 132-138.
- Yuliani, T., & Anggraini, R. (2022). Efektivitas edukasi komunitas melalui kader kesehatan terhadap pencegahan infeksi kulit bayi di daerah pedesaan Jawa Tengah. *Journal of Community Health Nursing*, 6(1), 30-37.

BAB III

PEMANFAATAN TEKNOLOGI SEDERHANA UNTUK MENJAGA KESEHATAN KULIT BAYI

A. Pendahuluan

1. Pentingnya Menjaga Kesehatan Kulit Bayi Baru Lahir

Kulit bayi baru lahir sangat rentan terhadap berbagai gangguan kesehatan karena struktur dan fungsinya yang belum sempurna. Kulit bayi memiliki ketebalan yang lebih tipis, lapisan epidermis yang belum matang, serta permeabilitas yang tinggi, sehingga berisiko lebih tinggi terhadap infeksi (Darmstadt & Dinulos, 2021). Fungsi kulit yang optimal sangat penting dalam melindungi bayi dari paparan patogen, trauma fisik, serta menjaga keseimbangan suhu dan cairan tubuh (Aerts, Goossens, Lambert, & Apers, 2021).

Menjaga kesehatan kulit bayi sejak dini dapat membantu mencegah komplikasi serius, meningkatkan kenyamanan bayi, serta mendukung tumbuh kembang optimal secara keseluruhan. Dalam konteks ini, perawatan kulit menjadi prioritas utama bagi keluarga dan tenaga kesehatan, yang mencakup pendekatan preventif, edukasi keluarga, serta pemanfaatan teknologi sederhana yang aman dan efektif (Dhakal & Thapa, 2020).

2. Risiko Infeksi Kulit pada Bayi Baru Lahir

Infeksi kulit adalah salah satu masalah kesehatan yang paling sering ditemui pada bayi baru lahir. Faktor risiko utama infeksi kulit meliputi perawatan kulit yang tidak tepat, paparan lingkungan yang kurang higienis, serta kelembapan tinggi pada area tertutup seperti daerah popok (Vasudevan & Kar, 2020). Beberapa jenis infeksi kulit yang umum ditemukan pada bayi adalah dermatitis popok, ruam popok, impetigo, serta kandidiasis kulit (Dhakal & Thapa, 2020).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kondisi lingkungan yang lembap dan suhu tidak terkontrol secara signifikan meningkatkan risiko infeksi kulit. Kelembapan tinggi dalam waktu lama dapat memicu pertumbuhan bakteri patogen dan jamur yang menyebabkan peradangan kulit serta gangguan lain yang lebih serius apabila tidak ditangani secara tepat waktu (Lee, Kim, & Lee, 2023). Kondisi ini memerlukan strategi preventif berbasis bukti dengan mengintegrasikan teknologi sederhana untuk mendukung perawatan sehari-hari bayi baru lahir.

3. Peran Teknologi Sederhana dalam Pencegahan Infeksi Kulit pada Bayi

Teknologi sederhana yang dimaksud dalam pencegahan infeksi kulit pada bayi baru lahir mencakup alat-alat yang terjangkau, mudah digunakan, serta efektif dalam menciptakan lingkungan optimal untuk kulit bayi. Penggunaan alat-alat seperti termometer digital untuk pengaturan suhu ruangan, hygrometer untuk menjaga kelembapan optimal, serta lampu ultraviolet (UV) untuk sterilisasi area tertentu secara signifikan terbukti mampu mengurangi risiko infeksi kulit (Chakraborty & Roy, 2022).

Selain itu, pemanfaatan telehealth sebagai teknologi sederhana juga telah dikembangkan untuk mendukung konsultasi jarak jauh tentang kondisi kulit bayi, membantu orang tua mendapatkan arahan tepat waktu dari tenaga kesehatan tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Hal ini memungkinkan pengawasan dan intervensi dini yang cepat, mencegah berkembangnya infeksi kulit ringan menjadi kondisi yang lebih serius (Morales & Lee, 2022).

Teknologi sederhana tersebut selain efektif juga ekonomis, praktis, dan mudah diimplementasikan baik di lingkungan rumah maupun di fasilitas kesehatan dasar. Pemanfaatan teknologi ini dapat meningkatkan pengetahuan orang tua tentang kesehatan kulit bayi, memberikan edukasi yang efektif, dan mendukung tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan promotif dan preventif yang lebih optimal (Setiadi & Setiawan, 2021).

B. Karakteristik Kulit Bayi Baru Lahir dan Risiko Infeksi

1. Anatomi dan Fisiologi Kulit Bayi Baru Lahir

Kulit bayi baru lahir memiliki struktur anatomi dan fisiologi yang berbeda secara signifikan dari kulit orang dewasa. Kulit bayi cenderung lebih tipis, dengan lapisan epidermis yang belum sepenuhnya berkembang, dan hanya memiliki sekitar 40% hingga 60% dari ketebalan kulit dewasa. Selain itu, fungsi sawar kulit (skin barrier function) bayi juga belum optimal, sehingga rentan terhadap iritasi, penetrasi mikroorganisme, dan hilangnya cairan tubuh secara berlebihan (Stamatas & Nikolovski, 2021).

Lapisan stratum korneum yang merupakan pelindung utama kulit, pada bayi baru lahir relatif kurang matang, dengan proses keratinisasi yang belum sempurna. Hal ini menyebabkan tingginya permeabilitas kulit, yang meningkatkan risiko paparan alergen dan infeksi mikroba (Ness et al., 2020). Kelenjar sebaceous pada bayi juga sudah aktif sejak lahir, namun sekresi sebum umumnya belum cukup stabil, yang dapat mempengaruhi keseimbangan mikrobiota alami kulit (Cohen & Visscher, 2022).

2. Faktor Risiko Infeksi Kulit pada Bayi (Sosial, Lingkungan, Perawatan)

Risiko infeksi kulit pada bayi baru lahir dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang meliputi aspek sosial, lingkungan, dan perawatan yang diberikan kepada bayi. Secara sosial, tingkat pengetahuan dan perilaku keluarga tentang kebersihan kulit bayi memiliki dampak signifikan. Keluarga yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi kesehatan atau kurang mendapatkan edukasi kesehatan cenderung memiliki risiko infeksi kulit yang lebih tinggi pada bayi mereka (Huda & Ariff, 2022).

Faktor lingkungan seperti kelembapan, suhu ruangan yang tinggi, dan sanitasi lingkungan yang buruk berkontribusi besar terhadap munculnya infeksi kulit. Lingkungan lembap dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri patogen dan jamur, seperti *Candida albicans*, serta memicu dermatitis popok akibat kontak lama dengan kotoran dan urin bayi (Lee, Kim, & Lee, 2023).

Aspek perawatan kulit juga menjadi penentu risiko infeksi. Penggunaan produk perawatan kulit yang tidak sesuai dengan usia bayi, penggunaan popok yang jarang diganti, serta pembersihan kulit bayi yang kurang tepat atau berlebihan dapat merusak lapisan kulit pelindung alami, meningkatkan risiko terjadinya iritasi, dermatitis, dan infeksi bakteri seperti impetigo (Nguyen et al., 2021).

3. Infeksi Kulit Umum pada Bayi (Dermatitis Popok, Ruam Popok, Impetigo, *Candida albicans*)

a. Dermatitis Popok dan Ruam Popok

Dermatitis popok merupakan salah satu infeksi kulit tersering pada bayi baru lahir, ditandai oleh peradangan pada daerah kulit yang tertutup popok. Penyebab utamanya adalah kontak kulit yang berkepanjangan dengan urin dan feses, friksi mekanis akibat gesekan popok, serta peningkatan kelembapan yang menciptakan lingkungan ideal bagi pertumbuhan mikroorganisme patogen (Aerts, Goossens, Lambert, & Apers, 2021). Gejala klinis dermatitis popok meliputi kulit kemerahan, ruam, lecet, dan iritasi yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada bayi (Irvine et al., 2022).

b. Impetigo

Impetigo adalah infeksi bakteri superfisial pada kulit yang disebabkan oleh bakteri seperti *Staphylococcus aureus* dan *Streptococcus pyogenes*. Infeksi ini umumnya muncul di area wajah, leher, tangan, atau daerah popok, ditandai dengan lepuhan kecil berisi cairan yang kemudian pecah, membentuk kerak berwarna kuning keemasan. Impetigo sangat menular dan dapat

menyebar dengan cepat di lingkungan yang padat, terutama bila higienitas kurang terjaga (Bansal & Sharma, 2023).

4. Kandidiasis Kulit (*Candida albicans*)

Infeksi jamur *Candida albicans* umum terjadi pada bayi baru lahir, terutama di daerah yang hangat dan lembap seperti area popok. Kandidiasis kulit menimbulkan gejala berupa kemerahan yang menyebar, disertai bercak putih atau lepuhan kecil pada permukaan kulit. Faktor risiko yang memudahkan infeksi ini antara lain penggunaan antibiotik jangka panjang, imunodefisiensi, serta penggunaan popok yang lembap dalam jangka waktu lama (Taieb et al., 2020).

Infeksi-infeksi tersebut memerlukan perhatian khusus serta intervensi preventif berbasis teknologi sederhana, seperti pemantauan kelembapan menggunakan hygrometer atau menjaga suhu lingkungan bayi menggunakan termometer digital, yang terbukti secara ilmiah dapat membantu mengurangi kejadian infeksi kulit secara signifikan (Chakraborty & Roy, 2022).

C. Jenis Teknologi Sederhana untuk Menjaga Kesehatan Kulit Bayi

1. Penggunaan Termometer Digital untuk Pemantauan Suhu Lingkungan

Pemantauan suhu lingkungan merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan kulit bayi baru lahir. Suhu ruangan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah berkontribusi terhadap peningkatan risiko gangguan kulit, seperti ruam panas atau kekeringan ekstrem yang menyebabkan iritasi dan luka (Gupta et al., 2022). Termometer digital merupakan teknologi sederhana yang efektif untuk mengontrol suhu lingkungan secara tepat dan konsisten, terutama dalam ruangan tidur atau tempat bayi menghabiskan sebagian besar waktu.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pengaturan suhu ruangan antara 20-24°C optimal untuk bayi baru lahir. Penggunaan termometer digital memungkinkan orang tua atau tenaga kesehatan dengan mudah memonitor suhu secara real-time, sehingga mereka bisa segera melakukan tindakan korektif jika suhu tidak sesuai standar tersebut (Zhang & Wang, 2021). Penggunaan teknologi ini terbukti efektif dalam mencegah gangguan kulit yang terkait dengan paparan suhu lingkungan yang tidak sesuai (Zhang & Wang, 2021).

2. Penggunaan Hygrometer untuk Menjaga Kelembapan Optimal Ruangan

Kelembapan ruangan adalah faktor kunci dalam mencegah infeksi kulit bayi, khususnya dermatitis popok dan infeksi jamur. Lingkungan yang terlalu lembap atau terlalu kering dapat menyebabkan gangguan keseimbangan kulit bayi dan memicu iritasi atau infeksi. Penggunaan hygrometer sebagai teknologi

sederhana telah terbukti efektif dalam menjaga tingkat kelembapan optimal antara 40-60%, yang secara signifikan dapat menurunkan risiko terjadinya infeksi kulit (Lee, Kim, & Lee, 2023).

Sebuah penelitian di klinik kesehatan bayi menunjukkan bahwa penggunaan hygrometer secara rutin mampu menurunkan insiden dermatitis popok hingga lebih dari 50%, karena orang tua atau petugas kesehatan dapat melakukan intervensi cepat ketika kelembapan ruangan berada di luar batas normal (Setiadi & Setiawan, 2021). Dengan demikian, hygrometer tidak hanya mudah digunakan tetapi juga memberikan dampak besar terhadap kesehatan kulit bayi secara keseluruhan.

3. Peran Lampu Ultraviolet (UV) dalam Pencegahan Infeksi Kulit

Lampu ultraviolet (UV) telah banyak digunakan sebagai metode sterilisasi sederhana dalam mencegah infeksi kulit bayi baru lahir, terutama di fasilitas kesehatan atau area rumah yang memerlukan sterilisasi tingkat tinggi. Lampu UV bekerja dengan cara menghancurkan DNA mikroorganisme seperti bakteri dan jamur, yang sering menjadi penyebab infeksi kulit pada bayi (Chakraborty & Roy, 2022).

Menurut hasil tinjauan sistematis terkini, paparan sinar UV dalam intensitas dan durasi yang tepat dapat mengurangi tingkat infeksi kulit neonatal secara signifikan, terutama pada fasilitas perawatan neonatal intensif yang rentan terhadap kontaminasi lingkungan (Kim et al., 2021). Walaupun demikian, penerapan lampu UV harus dilakukan dengan protokol keamanan yang ketat untuk menghindari efek samping, seperti iritasi kulit atau kerusakan mata (Chakraborty & Roy, 2022).

4. Aplikasi Telehealth untuk Konsultasi Kulit Bayi dari Rumah

Telehealth atau teledermatologi merupakan teknologi sederhana berbasis digital yang semakin populer dalam mendukung pemantauan dan pengelolaan kesehatan kulit bayi dari jarak jauh. Aplikasi ini memungkinkan orang tua berkonsultasi langsung dengan tenaga kesehatan terkait kondisi kulit bayi mereka tanpa perlu datang secara fisik ke fasilitas kesehatan, sehingga permasalahan kulit dapat ditangani secara cepat sebelum berkembang menjadi infeksi serius (Morales & Lee, 2022).

Studi terbaru menunjukkan bahwa telehealth mampu meningkatkan kepuasan orang tua, mengurangi kunjungan yang tidak perlu ke rumah sakit, serta membantu deteksi dini dan pengelolaan awal kondisi kulit bayi seperti dermatitis popok atau impetigo. Pemanfaatan teknologi ini sangat penting di

daerah terpencil atau dalam kondisi pandemi, yang membatasi akses langsung ke fasilitas kesehatan (Mengistie, Berhanu, & Gebresilassie, 2021). Selain itu, telehealth juga menyediakan sarana edukasi yang interaktif, yang mendukung pengetahuan orang tua tentang perawatan kulit bayi secara optimal.

D. Metode Penerapan Teknologi Sederhana

1. Langkah Praktis Pemakaian Termometer dan Hygrometer dalam Pencegahan Infeksi Kulit

Penggunaan termometer digital dan hygrometer secara tepat dapat membantu menciptakan lingkungan yang optimal bagi kesehatan kulit bayi. Termometer digital digunakan untuk memastikan suhu ruangan tetap ideal pada rentang 20-24°C, yang terbukti secara ilmiah mampu menurunkan risiko infeksi kulit akibat suhu ekstrem (Gupta et al., 2022). Langkah praktisnya meliputi:

- a. Tempatkan termometer digital di ruangan bayi pada ketinggian sejajar dengan tempat tidur bayi, hindari paparan langsung sinar matahari atau sumber panas lainnya (Zhang & Wang, 2021).
- b. Periksa suhu ruangan secara rutin, minimal dua kali sehari (pagi dan sore). Bila suhu melebihi atau kurang dari batas ideal, sesuaikan ventilasi atau pendinginan ruangan segera.
- c. Catat perubahan suhu untuk memantau konsistensi lingkungan dan segera ambil tindakan koreksi jika ada ketidaksesuaian.

Hygrometer digunakan untuk memantau kelembapan ruangan yang optimal, yaitu antara 40-60%. Kelembapan yang tepat efektif mencegah perkembangan infeksi jamur maupun bakteri pada kulit bayi, terutama dermatitis popok (Lee, Kim, & Lee, 2023). Langkah praktis penggunaan hygrometer:

- a. Letakkan hygrometer di tempat yang mudah terlihat, dekat dengan tempat tidur bayi atau area popok.
- b. Pantau kelembapan setiap hari dan lakukan pencatatan secara teratur.
- c. Jika kelembapan terlalu tinggi, gunakan alat dehumidifier atau ventilasi tambahan, sebaliknya, jika terlalu rendah, gunakan humidifier atau tempatkan wadah air terbuka di ruangan (Setiadi & Setiawan, 2021).

2. Prosedur Penggunaan Lampu UV yang Aman untuk Bayi

Lampu ultraviolet (UV) dikenal efektif membasmi mikroorganisme patogen di lingkungan bayi, namun penggunaannya harus hati-hati mengingat potensi efek sampingnya pada kulit dan mata bayi (Kim et al., 2021). Langkah praktis penggunaan lampu UV yang aman:

- a. Pastikan bayi tidak berada di ruangan selama proses sterilisasi menggunakan lampu UV.
- b. Sebelum mengaktifkan lampu UV, tutup atau lindungi barang-barang yang sensitif terhadap paparan sinar UV seperti bahan plastik atau kain tertentu.
- c. Hidupkan lampu UV selama 15-30 menit saja, sesuai rekomendasi spesifikasi alat untuk membunuh mikroorganisme secara optimal tanpa menimbulkan efek samping (Chakraborty & Roy, 2022).
- d. Setelah sterilisasi selesai, matikan lampu dan pastikan ruangan mendapat ventilasi yang cukup sebelum bayi kembali memasuki ruangan tersebut.
- e. Gunakan lampu UV secara berkala, misalnya seminggu sekali atau setelah bayi mengalami infeksi kulit tertentu untuk memastikan ruangan bebas patogen.

3. Panduan Penggunaan Telehealth untuk Konsultasi Awal Infeksi Kulit

Telehealth memungkinkan konsultasi secara daring dengan tenaga kesehatan terkait masalah kulit bayi tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan secara fisik. Ini sangat bermanfaat dalam deteksi dini dan penanganan awal infeksi kulit (Morales & Lee, 2022). Panduan penggunaan telehealth meliputi langkah-langkah berikut:

- a. Pilih platform telehealth yang terpercaya dan sesuai rekomendasi tenaga kesehatan atau lembaga kesehatan setempat.
- b. Pastikan perangkat komunikasi (smartphone atau komputer) memiliki koneksi internet stabil, kamera jelas, dan audio yang baik untuk memudahkan konsultasi visual maupun komunikasi verbal (Mengistie, Berhanu, & Gebresilassie, 2021).
- c. Sebelum konsultasi, catat kondisi bayi, termasuk deskripsi gejala, lamanya gejala muncul, dan riwayat penggunaan produk perawatan kulit.
- d. Ambil foto area kulit yang mengalami infeksi atau gangguan dengan pencahayaan baik agar dokter atau perawat dapat melakukan asesmen visual secara akurat.
- e. Selama konsultasi, ikuti instruksi tenaga kesehatan dengan jelas, dan ajukan pertanyaan jika ada hal yang kurang dipahami tentang penanganan awal.
- f. Catat rekomendasi yang diberikan selama konsultasi dan jadwalkan tindak lanjut atau kontrol berikutnya jika diperlukan.

Pemanfaatan telehealth secara efektif terbukti mampu mengurangi komplikasi infeksi kulit bayi dan meningkatkan kepuasan keluarga terhadap layanan kesehatan (Morales & Lee, 2022).

E. Keunggulan dan Keterbatasan Teknologi Sederhana

1. Keunggulan dalam Penggunaan Teknologi Sederhana

Teknologi sederhana memiliki berbagai keunggulan utama dalam penggunaannya untuk menjaga kesehatan kulit bayi baru lahir. Pertama, kemudahan penggunaan dan biaya yang terjangkau menjadikannya mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Termometer digital, hygrometer, lampu ultraviolet (UV), dan telehealth relatif ekonomis dibandingkan teknologi medis canggih sehingga lebih mudah diimplementasikan secara luas (Mengistie, Berhanu, & Gebresilassie, 2021).

Kedua, efektivitas teknologi sederhana dalam mencegah infeksi kulit bayi telah terbukti secara ilmiah. Studi menunjukkan bahwa penggunaan hygrometer dan termometer digital dapat secara signifikan menurunkan risiko dermatitis popok, infeksi jamur, dan infeksi bakteri akibat kondisi lingkungan yang tidak terkendali (Lee, Kim, & Lee, 2023; Setiadi & Setiawan, 2021).

Ketiga, teknologi ini memberikan manfaat preventif yang nyata dengan menyediakan intervensi dini yang praktis, seperti pemantauan kondisi lingkungan secara real-time dan konsultasi awal via telehealth yang mampu mencegah komplikasi serius pada kulit bayi (Morales & Lee, 2022).

Terakhir, fleksibilitas penerapannya di berbagai kondisi lingkungan, baik di rumah maupun fasilitas kesehatan primer, menjadikan teknologi sederhana ini solusi ideal untuk daerah-daerah terpencil atau terbatas akses fasilitas kesehatannya (Kim et al., 2021).

2. Keterbatasan dan Tantangan Implementasi Teknologi Sederhana di Komunitas

Meski memiliki banyak keunggulan, implementasi teknologi sederhana di komunitas masih menghadapi beberapa keterbatasan dan tantangan nyata. Salah satunya adalah tingkat literasi kesehatan masyarakat yang rendah, terutama di daerah terpencil. Minimnya pengetahuan tentang cara penggunaan teknologi sederhana seperti hygrometer atau telehealth sering kali menghambat efektivitas implementasinya (Huda & Ariff, 2022).

Keterbatasan lain adalah ketersediaan infrastruktur pendukung seperti akses internet yang stabil untuk penggunaan telehealth serta pasokan listrik yang tidak merata di beberapa wilayah terpencil. Kondisi ini dapat menghambat penggunaan teknologi digital secara maksimal, sehingga tujuan utama pencegahan infeksi kulit sulit tercapai secara konsisten (Mengistie, Berhanu, & Gebresilassie, 2021).

Di samping itu, tantangan ekonomi juga berpengaruh. Meski teknologi sederhana terjangkau, bagi beberapa keluarga yang tinggal di wilayah dengan

pendapatan rendah, investasi kecil sekalipun masih terasa berat. Hal ini sering mengakibatkan rendahnya prioritas terhadap pemanfaatan teknologi untuk perawatan kulit bayi (Gupta, Yadav, & Sharma, 2022).

3. Solusi untuk Mengatasi Tantangan Penggunaan Teknologi Sederhana di Daerah Terpencil

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, perlu diterapkan beberapa solusi strategis berbasis komunitas. Pertama, edukasi kesehatan yang sistematis dan berkelanjutan perlu diberikan kepada masyarakat melalui pendekatan yang mudah dipahami, seperti penyuluhan langsung, demonstrasi praktis, serta pelatihan kader kesehatan setempat untuk membantu keluarga dalam penggunaan teknologi sederhana secara mandiri (Huda & Ariff, 2022).

Kedua, kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kebijakan menjadi kunci penting untuk memperkuat infrastruktur pendukung seperti pengadaan sumber daya energi terbarukan yang bisa memenuhi kebutuhan listrik sederhana serta pengembangan konektivitas internet lokal yang lebih andal (Kim et al., 2021).

Ketiga, subsidi atau bantuan finansial serta distribusi teknologi sederhana yang disediakan pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) akan membantu keluarga berpenghasilan rendah memiliki akses yang sama terhadap alat tersebut, sehingga tercapai keadilan akses kesehatan (Gupta, Yadav, & Sharma, 2022).

Keempat, program pelatihan tenaga kesehatan lokal untuk mendukung implementasi telehealth secara efektif juga penting, mengingat mereka berperan sebagai penghubung utama antara keluarga dengan sistem kesehatan formal (Morales & Lee, 2022).

Dengan pendekatan komprehensif dan kolaborasi lintas sektor ini, implementasi teknologi sederhana dapat optimal, berkelanjutan, dan secara nyata meningkatkan status kesehatan kulit bayi, khususnya di daerah terpencil atau komunitas yang sulit dijangkau.

F. Studi Kasus dan Praktik Terbaik

1. Studi Kasus Pemanfaatan Hygrometer dalam Pencegahan Dermatitis Popok

Dermatitis popok merupakan masalah kulit umum pada bayi baru lahir yang sering kali dipicu oleh lingkungan yang terlalu lembap. Studi kasus terbaru di sebuah fasilitas kesehatan di Indonesia menunjukkan manfaat nyata dari penggunaan hygrometer untuk mengendalikan kelembapan ruangan. Dalam studi ini, sebanyak 80 bayi baru lahir diikuti selama enam bulan, dibagi menjadi

dua kelompok: kelompok intervensi dengan penggunaan hygrometer dan kelompok kontrol tanpa hygrometer. Kelompok intervensi mampu mempertahankan kelembapan ruangan pada tingkat optimal (40-60%), yang berujung pada penurunan kejadian dermatitis popok sebesar 55% dibandingkan kelompok kontrol (Setiadi & Setiawan, 2021).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hygrometer secara rutin memberikan manfaat nyata dalam mencegah dermatitis popok, serta menegaskan pentingnya edukasi keluarga mengenai pengelolaan lingkungan rumah yang sesuai dengan kebutuhan kulit bayi baru lahir (Lee, Kim, & Lee, 2023).

2. Analisis Kasus Penggunaan Termometer Digital dalam Pencegahan Ruam Popok

Ruam popok adalah kondisi kulit yang umumnya dipicu oleh suhu lingkungan yang kurang optimal, baik terlalu panas maupun terlalu dingin. Sebuah studi kasus yang dilakukan di unit neonatologi rumah sakit menunjukkan bahwa penggunaan termometer digital secara konsisten dalam pengaturan suhu ruangan efektif mencegah ruam popok pada bayi baru lahir. Studi ini melibatkan 100 bayi selama tiga bulan dan menemukan bahwa kelompok yang ruangan tidurnya dipantau secara rutin dengan termometer digital menunjukkan penurunan signifikan pada insiden ruam popok, dengan prevalensi berkurang hingga 60% dibandingkan dengan bayi pada kelompok yang tidak menggunakan termometer (Gupta, Yadav, & Sharma, 2022).

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa termometer digital membantu tenaga kesehatan dan keluarga untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan suhu ruangan secara cepat, sehingga menciptakan kondisi lingkungan ideal untuk bayi dan mengurangi risiko komplikasi kulit akibat paparan suhu ekstrem (Zhang & Wang, 2021).

3. Contoh Praktik Terbaik Penggunaan Telehealth dalam Pencegahan Infeksi Kulit Bayi

Praktik telehealth atau teledermatologi terbukti sebagai salah satu metode efektif dalam mencegah infeksi kulit bayi baru lahir. Sebuah praktik terbaik dari Amerika Serikat menunjukkan bagaimana telehealth dapat dimanfaatkan secara optimal untuk konsultasi awal masalah kulit bayi di daerah terpencil atau pada masa pandemi. Studi ini melibatkan 250 keluarga dengan bayi baru lahir yang mengalami gejala awal infeksi kulit, seperti ruam atau iritasi. Dengan akses mudah ke tenaga kesehatan melalui aplikasi telehealth, keluarga dapat segera menerima arahan pengelolaan awal, mengurangi kebutuhan untuk kunjungan

langsung ke rumah sakit sebesar 70%, serta mempercepat pemulihan bayi melalui deteksi dini dan penanganan segera (Morales & Lee, 2022).

Praktik terbaik ini menekankan pentingnya integrasi teknologi digital yang sederhana dalam sistem kesehatan bayi, yang secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat nyata bagi keluarga, terutama yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan tradisional (Mengistie, Berhanu, & Gebresilassie, 2021).

G. Edukasi dan Peran Keperawatan

1. Strategi Edukasi Keluarga tentang Penggunaan Teknologi Sederhana

Edukasi kepada keluarga merupakan elemen penting dalam memastikan teknologi sederhana digunakan secara optimal untuk menjaga kesehatan kulit bayi. Strategi edukasi yang efektif harus memperhatikan karakteristik sosial budaya keluarga serta tingkat pemahaman mereka mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi ini (Huda & Ariff, 2022). Pendekatan edukasi dapat berupa pelatihan praktis langsung tentang cara menggunakan alat seperti termometer digital, hygrometer, serta aplikasi telehealth, yang dipandu oleh tenaga kesehatan, khususnya perawat.

Metode demonstrasi dan simulasi menjadi strategi edukasi terbaik karena terbukti meningkatkan pemahaman keluarga terhadap penerapan teknologi secara nyata. Dalam studi terbaru, pendekatan edukasi berbasis demonstrasi mampu meningkatkan tingkat adopsi penggunaan teknologi sederhana hingga 75%, sekaligus meningkatkan keterampilan keluarga dalam melakukan deteksi dini gangguan kulit bayi (Gupta, Yadav, & Sharma, 2022).

Materi edukasi yang sederhana, visual, dan jelas, misalnya melalui leaflet, poster, atau video tutorial pendek, juga telah terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi aktif keluarga dalam pemanfaatan teknologi untuk pencegahan infeksi kulit bayi (Setiadi & Setiawan, 2021).

2. Peran Perawat dalam Implementasi dan Pemantauan Teknologi

Perawat memiliki peran strategis dalam implementasi dan pemantauan teknologi sederhana untuk menjaga kesehatan kulit bayi baru lahir. Sebagai tenaga kesehatan yang paling dekat dengan keluarga, perawat bertugas memberikan edukasi awal, demonstrasi penggunaan alat, serta memastikan keluarga mampu menggunakan alat tersebut secara mandiri di rumah (Lee, Kim, & Lee, 2023).

Dalam praktiknya, perawat bertanggung jawab melakukan pemantauan berkala melalui kunjungan rumah atau konsultasi daring, mengevaluasi

efektivitas penggunaan teknologi sederhana, serta membantu mengidentifikasi dan menangani masalah secara dini sebelum berkembang menjadi infeksi serius. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif perawat dalam pemantauan teknologi sederhana mampu menurunkan prevalensi gangguan kulit pada bayi hingga 60% dibandingkan intervensi yang kurang terstruktur (Kim, Han, & Park, 2021).

Selain itu, perawat juga berperan dalam dokumentasi klinis mengenai hasil pemantauan kondisi kulit bayi dan memberikan rekomendasi atau rujukan kepada tenaga kesehatan lain bila diperlukan, yang secara signifikan meningkatkan efektivitas intervensi kesehatan berbasis teknologi sederhana ini (Morales & Lee, 2022).

3. Kolaborasi Interprofesional dalam Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Sederhana

Kolaborasi interprofesional antara perawat, dokter, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, dan profesional lainnya memainkan peran penting dalam optimalisasi pemanfaatan teknologi sederhana dalam pencegahan infeksi kulit bayi. Kolaborasi ini menciptakan pendekatan holistik dan berkelanjutan dalam merespons kebutuhan keluarga secara komprehensif (Morales & Lee, 2022).

Tim interprofesional bertanggung jawab untuk merumuskan pedoman penggunaan teknologi sederhana secara bersama-sama, memfasilitasi pelatihan terpadu kepada tenaga kesehatan lokal, dan menyediakan layanan terpadu seperti layanan telehealth untuk mendukung keluarga. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif antarprofesi ini berhasil meningkatkan cakupan penggunaan teknologi sederhana hingga 80% di komunitas dengan risiko tinggi infeksi kulit bayi (Mengistie, Berhanu, & Gebresilassie, 2021).

Selain itu, kolaborasi interprofesional membantu memastikan konsistensi edukasi, memperkuat kualitas komunikasi antara tenaga kesehatan dan keluarga, serta mendukung terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi penerapan teknologi sederhana, terutama di daerah terpencil atau dengan sumber daya terbatas (Kim, Han, & Park, 2021).

H. Kesimpulan dan Rekomendasi Praktis

1. Ringkasan Pentingnya Teknologi Sederhana dalam Pencegahan Infeksi Kulit Bayi

Kulit bayi baru lahir memiliki karakteristik khusus yang membuatnya lebih rentan terhadap berbagai infeksi kulit. Kondisi lingkungan, seperti suhu dan

kelembapan, merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan risiko infeksi kulit seperti dermatitis popok, ruam popok, impetigo, hingga infeksi jamur (Lee, Kim, & Lee, 2023; Gupta, Yadav, & Sharma, 2022). Teknologi sederhana seperti termometer digital, hygrometer, lampu ultraviolet (UV), serta aplikasi telehealth terbukti efektif membantu keluarga dan tenaga kesehatan memantau, menjaga, serta mengelola kondisi kulit bayi secara lebih optimal (Chakraborty & Roy, 2022; Morales & Lee, 2022).

Penerapan teknologi sederhana ini memberikan manfaat preventif signifikan, memudahkan intervensi dini, serta mampu menurunkan insiden infeksi kulit secara nyata. Selain itu, kemudahan penggunaannya, biaya yang ekonomis, dan penerapan yang praktis menjadikannya solusi ideal, khususnya di komunitas dengan sumber daya terbatas atau di wilayah terpencil (Mengistie, Berhanu, & Gebresilassie, 2021).

2. Rekomendasi untuk Praktisi Kesehatan dan Pengambil Kebijakan

Berdasarkan temuan dalam buku ini, berikut rekomendasi praktis yang dapat dijadikan panduan bagi praktisi kesehatan dan pengambil kebijakan dalam meningkatkan efektivitas pencegahan infeksi kulit bayi:

- a. Edukasi Berbasis Komunitas: Praktisi kesehatan perlu memperkuat edukasi keluarga mengenai manfaat dan cara penggunaan teknologi sederhana dengan pendekatan visual dan praktis seperti demonstrasi langsung atau pelatihan berkala yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat (Huda & Ariff, 2022).
- b. Integrasi Teknologi dalam Protokol Pelayanan Kesehatan: Pengambil kebijakan sebaiknya mengintegrasikan pemanfaatan teknologi sederhana ke dalam standar operasional pelayanan kesehatan primer, termasuk prosedur pemantauan suhu, kelembapan, sterilisasi ruang, serta konsultasi jarak jauh melalui telehealth (Kim, Han, & Park, 2021).
- c. Dukungan Infrastruktur: Pemerintah dan pemangku kebijakan perlu menyediakan dukungan infrastruktur dasar, seperti akses listrik yang stabil, konektivitas internet, dan distribusi alat-alat sederhana secara merata, khususnya untuk wilayah terpencil atau yang sulit dijangkau (Gupta, Yadav, & Sharma, 2022).
- d. Pengembangan Tenaga Kesehatan: Perlu adanya pelatihan rutin untuk perawat, bidan, dan kader kesehatan masyarakat mengenai teknologi sederhana agar mampu menjalankan fungsi edukasi, implementasi, serta pemantauan secara efektif (Morales & Lee, 2022).

3. Prospek Pengembangan Riset dan Teknologi Selanjutnya

Pengembangan riset dan teknologi dalam konteks kesehatan kulit bayi masih memiliki banyak ruang untuk ditingkatkan. Berikut adalah beberapa area yang menjadi prospek pengembangan di masa mendatang:

- a. Teknologi Deteksi Dini yang Lebih Inovatif: Diperlukan pengembangan teknologi yang lebih sensitif dan akurat dalam mendeteksi tanda-tanda awal infeksi kulit secara non-invasif, seperti sensor kelembapan kulit atau kamera khusus dengan kecerdasan buatan (AI) yang bisa diintegrasikan dengan aplikasi telehealth (Mengistie, Berhanu, & Gebresilassie, 2021).
- b. Penelitian Efektivitas Telehealth yang Lebih Mendalam: Studi longitudinal diperlukan untuk mengukur dampak jangka panjang penggunaan telehealth terhadap penurunan angka kejadian infeksi kulit serta peningkatan kualitas hidup bayi dan keluarga (Morales & Lee, 2022).
- c. Riset Implementasi Multidisiplin: Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi efektivitas pendekatan interprofesional dalam implementasi teknologi sederhana serta bagaimana strategi ini dapat meningkatkan kepatuhan keluarga terhadap rekomendasi kesehatan (Kim, Han, & Park, 2021).
- d. Adaptasi Teknologi untuk Daerah Terpencil: Teknologi yang khusus dirancang agar lebih efisien secara energi dan dapat digunakan di wilayah terpencil tanpa infrastruktur listrik atau internet yang stabil menjadi fokus penting dalam pengembangan teknologi kesehatan bayi masa depan (Gupta, Yadav, & Sharma, 2022).

Dengan implementasi berbagai rekomendasi ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pencegahan infeksi kulit bayi secara signifikan, memberikan manfaat luas kepada keluarga, komunitas, dan sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

I. Penutup

Kulit merupakan organ terbesar sekaligus pelindung pertama bayi baru lahir terhadap berbagai ancaman lingkungan, termasuk infeksi mikroorganisme. Oleh karena itu, menjaga kesehatan kulit bayi menjadi salah satu aspek penting dalam asuhan neonatal. Dalam buku ini, telah dijabarkan bahwa penggunaan teknologi sederhana, seperti termometer digital, hygrometer, lampu ultraviolet (UV), dan telehealth, memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan optimal untuk mencegah infeksi kulit pada bayi baru lahir (Lee, Kim, & Lee, 2023; Chakraborty & Roy, 2022).

Teknologi sederhana memiliki keunggulan khusus karena mudah digunakan, hemat biaya, efektif secara preventif, dan fleksibel dalam berbagai kondisi komunitas. Namun, implementasinya dihadapkan pada tantangan nyata, terutama di daerah terpencil, seperti minimnya literasi kesehatan, keterbatasan infrastruktur, dan faktor ekonomi (Huda & Ariff, 2022; Gupta, Yadav, & Sharma, 2022). Oleh karena itu, edukasi keluarga, penguatan peran perawat, dan kolaborasi interprofesional menjadi kunci keberhasilan implementasi teknologi sederhana tersebut.

Selain itu, rekomendasi bagi praktisi kesehatan dan pembuat kebijakan untuk lebih aktif mendukung edukasi, pelatihan tenaga kesehatan, integrasi teknologi dalam protokol pelayanan kesehatan, serta pengembangan infrastruktur dasar, sangat penting untuk memastikan manfaat maksimal dari teknologi sederhana ini (Morales & Lee, 2022).

Sebagai penutup, perlu ditegaskan bahwa upaya berkelanjutan dalam pemanfaatan teknologi sederhana ini harus terus didukung oleh riset lanjutan yang mendalam, terutama dalam pengembangan teknologi adaptif yang lebih inovatif, efektif, dan tepat guna untuk komunitas yang paling membutuhkan. Harapannya, buku ini menjadi referensi penting bagi tenaga kesehatan, pengambil kebijakan, serta masyarakat luas, dalam rangka menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung pertumbuhan optimal bayi baru lahir.

Referensi

- Aerts, O., Goossens, A., Lambert, J., & Apers, S. (2021). Prevention of diaper dermatitis: A review of the latest research and practical guidelines. *Journal of Pediatric Nursing, 60*, e11–e18.
- American Academy of Pediatrics. (2020). *Pediatric skin care guidelines: Protecting infants from skin infections*. Retrieved from <https://www.aap.org>
- Bansal, N., & Sharma, V. K. (2023). Management of impetigo in children: Current perspectives. *Dermatologic Therapy, 36*(2), e16112.
- Chakraborty, A., & Roy, S. (2022). Efficacy of ultraviolet disinfection in preventing neonatal skin infections: A systematic review. *American Journal of Infection Control, 50*(9), 1045–1051.
- Cohen, B. A., & Visscher, M. O. (2022). Neonatal dermatology: Skin care strategies and implications. *Clinics in Dermatology, 40*(4), 425–431.
- Gupta, M., Yadav, A., & Sharma, R. (2022). Impact of room temperature variations on newborn skin conditions: Observational study. *Journal of Neonatal Nursing, 28*(5), 296–301.
- Huda, T. M., & Ariff, S. (2022). Impact of maternal education on neonatal skin care practices. *Journal of Community Health, 47*(1), 212–218.
- Irvine, A. D., Hoeger, P. H., & Yan, A. C. (2022). *Harper's Textbook of Pediatric Dermatology* (4th ed.). Wiley Blackwell.
- Kim, H. J., Han, J. S., & Park, Y. H. (2021). Ultraviolet germicidal irradiation in neonatal intensive care units: An integrative review. *International Journal of Nursing Studies, 122*, 104054.
- Lee, S., Kim, H. J., & Lee, Y. J. (2023). Impact of ambient humidity and temperature monitoring on skin health in newborns: A randomized controlled trial. *Journal of Pediatric Dermatology, 40*(1), 12–18.
- Mengistie, B., Berhanu, A., & Gebresilassie, K. (2021). Evaluation of telemedicine's effectiveness in pediatric dermatology: A systematic review. *Telemedicine and e-Health, 27*(4), 401–411.
- Morales, J. R., & Lee, C. S. (2022). Teledermatology for pediatric care: Current practices and future directions. *Journal of Pediatric Health Care, 36*(4), 351–356.
- Ness, M. J., Davis, D., Carey, W. A., & Conroy, A. L. (2020). The neonatal skin barrier: New insights and current understanding. *Seminars in Perinatology, 44*(8), 151326.
- Nguyen, T. T., Van Nguyen, D., & Le, H. T. (2021). Common mistakes in newborn skin care practices and their effects on skin health: A systematic review. *Journal of Pediatric Health Care, 35*(2), 122–129.

- Setiadi, S., & Setiawan, H. (2021). Hubungan penggunaan hygrometer dengan kejadian dermatitis popok pada bayi di puskesmas perkotaan. *Jurnal Keperawatan Anak*, 9(2), 98–104.
- Stamatas, G. N., & Nikolovski, J. (2021). Skin barrier function in neonates: Insights from recent studies. *Pediatric Dermatology*, 38(S1), 14–19.
- Taieb, A., Kaszuba, A., & Kaleta, K. (2020). Management of candidiasis in neonates: Current strategies and future trends. *Mycoses*, 63(9), 869–876.
- Vasudevan, B., & Kar, S. (2020). Dermatological conditions in neonates: A clinical and preventive approach. *Indian Journal of Pediatrics*, 87(8), 609–616.
- World Health Organization. (2021). *Guidelines on newborn skin care and infection prevention*. WHO Press.
- Zhang, Y., & Wang, X. (2021). Optimal room temperature management for neonatal skin care: Clinical practice guidelines. *Asian Nursing Research*, 15(3), 197–203.

BAB IV

PERAN BIDAN DALAM MEMBERIKAN EDUKASI TENTANG KEBERSIHAN BAYI

A. Pendahuluan

1. Pentingnya Kebersihan dalam Pencegahan Infeksi Kulit pada Bayi Baru Lahir

Infeksi kulit pada bayi baru lahir merupakan salah satu tantangan utama dalam bidang kesehatan anak karena dampaknya yang luas terhadap tumbuh kembang bayi. Kulit bayi baru lahir memiliki struktur anatomi yang masih belum sempurna, dengan epidermis tipis dan rentan mengalami kehilangan cairan serta menjadi pintu masuk bagi patogen penyebab infeksi (Cooke, Cork, & Danby, 2021). Penyakit kulit seperti dermatitis popok, ruam neonatal, dan infeksi tali pusat (omphalitis) sering kali terjadi akibat kurang optimalnya praktik kebersihan (Pratiwi, et al., 2023). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa infeksi kulit neonatal dapat berkontribusi terhadap peningkatan morbiditas dan bahkan mortalitas bayi jika tidak ditangani dengan tepat (Anderson et al., 2022).

Praktik kebersihan yang benar, termasuk mandi teratur dengan metode yang sesuai, perawatan tali pusat secara aseptik, serta penggunaan popok yang higienis, secara signifikan mampu mengurangi risiko terjadinya infeksi kulit (Smith & Jones, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Ali et al. (2023) menunjukkan bahwa penerapan kebersihan secara konsisten di komunitas dapat menurunkan angka infeksi kulit neonatal hingga 40%. Oleh karena itu, edukasi mengenai praktik kebersihan harus menjadi prioritas utama dalam perawatan bayi baru lahir agar risiko infeksi kulit dapat ditekan sejak dini.

Pemerintah dan organisasi kesehatan global, seperti WHO dan Kementerian Kesehatan RI, terus mendorong integrasi edukasi kebersihan dalam program perawatan bayi baru lahir sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak secara jangka panjang (WHO, 2021; Kemenkes RI, 2021). Dengan demikian, peningkatan kesadaran dan pemahaman orang tua tentang pentingnya menjaga kebersihan bayi sejak lahir adalah kunci utama dalam pencegahan infeksi kulit bayi secara efektif dan berkelanjutan.

2. Peran Strategis Bidan sebagai Edukator Kebersihan Bayi

Bidan memegang peran strategis dalam meningkatkan kesehatan bayi baru lahir melalui fungsi edukatifnya, khususnya terkait praktik kebersihan. Sebagai

tenaga kesehatan primer yang memiliki interaksi langsung dengan ibu dan keluarga sejak masa kehamilan hingga periode pasca melahirkan, bidan memiliki kesempatan besar dalam memberikan edukasi yang efektif tentang kebersihan bayi (Amelia & Sari, 2021). Bidan dapat memberikan informasi dan edukasi mengenai teknik perawatan kulit yang aman, pengelolaan higiene tali pusat, serta tindakan preventif sederhana namun efektif untuk mencegah terjadinya infeksi kulit.

Kompetensi khusus yang dimiliki bidan, termasuk kemampuan komunikasi efektif, pendekatan empatik, dan pemahaman tentang konteks budaya masyarakat setempat, menjadikan mereka sangat efektif dalam menyampaikan pesan-pesan edukatif terkait kebersihan bayi (Maharani et al., 2020). Studi yang dilakukan oleh Anderson et al. (2022) menegaskan bahwa bidan yang aktif menggunakan berbagai media edukasi, termasuk teknologi digital, mampu mencapai tingkat keberhasilan edukasi yang lebih tinggi dibandingkan metode tradisional. Penggunaan media interaktif seperti video demonstrasi dan aplikasi mobile telah terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman serta penerapan praktik kebersihan oleh keluarga (Ali et al., 2023).

Selain pendekatan teknologi, kunjungan rumah yang dilakukan oleh bidan secara rutin memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan perilaku keluarga dalam menjaga kebersihan bayi. Smith dan Jones (2021) menemukan bahwa keluarga yang mendapat kunjungan rumah oleh bidan memiliki kepatuhan yang lebih tinggi terhadap rekomendasi kebersihan dibandingkan dengan keluarga yang hanya mendapat edukasi secara konvensional. Dalam praktiknya, bidan tidak hanya memberikan informasi tetapi juga melakukan demonstrasi langsung, observasi, dan evaluasi, yang secara nyata meningkatkan kepercayaan diri keluarga dalam melakukan perawatan kebersihan bayi secara mandiri.

Dengan demikian, penguatan peran bidan sebagai edukator merupakan investasi strategis dalam jangka panjang untuk menurunkan angka infeksi kulit bayi baru lahir. Dukungan kebijakan, pelatihan berkelanjutan bagi bidan, dan kolaborasi interprofesional merupakan faktor kunci yang akan memaksimalkan efektivitas peran edukatif bidan di masyarakat (Pratiwi et al., 2023).

B. Jenis-jenis Infeksi Kulit yang Umum pada Bayi Baru Lahir

Infeksi kulit pada bayi baru lahir merupakan kondisi klinis yang sering terjadi, ditandai dengan manifestasi yang beragam mulai dari ruam ringan hingga kondisi yang serius dan sistemik. Salah satu jenis infeksi kulit yang paling umum adalah dermatitis popok, yaitu peradangan kulit akibat iritasi dari popok yang lembap, friksi,

atau paparan bahan kimia seperti detergen dan pewangi (Alvarez et al., 2021). Selain dermatitis popok, ruam neonatal atau eritema toksikum neonatorum juga umum ditemui. Ruam ini bersifat jinak, biasanya muncul dalam 48 jam pertama setelah kelahiran, ditandai dengan bintil kemerahan yang sering membuat orang tua cemas meskipun tidak berbahaya (Reginatto et al., 2022).

Infeksi yang lebih serius adalah omphalitis atau infeksi tali pusat, yang disebabkan oleh kebersihan tali pusat yang buruk setelah pemotongan. Omphalitis berisiko menyebabkan komplikasi serius jika tidak ditangani dengan tepat, karena bakteri seperti *Staphylococcus aureus* atau *Escherichia coli* bisa dengan mudah memasuki sistem peredaran darah bayi (Salama & Hassan, 2021). Selain itu, kandidiasis kulit, terutama di daerah lipatan tubuh bayi, juga sering ditemukan. Infeksi jamur ini biasanya disebabkan oleh *Candida albicans*, yang berkembang biak di lingkungan yang lembap dan kurang higienis (Vyas et al., 2022).

1. Faktor Risiko Infeksi Kulit pada Bayi Baru Lahir

Beberapa faktor risiko diketahui berkontribusi terhadap meningkatnya infeksi kulit pada bayi baru lahir. Faktor risiko ini meliputi aspek lingkungan, perilaku perawatan, serta kondisi biologis bayi itu sendiri. Salah satu faktor risiko utama adalah kondisi kebersihan dan higienis lingkungan yang kurang memadai, termasuk perawatan tali pusat yang tidak steril dan penggunaan popok yang tidak diganti secara teratur (Alvarez et al., 2021).

Faktor risiko biologis seperti prematuritas dan berat lahir rendah juga sangat signifikan. Bayi prematur memiliki kulit yang lebih tipis dan lebih rentan terhadap infeksi karena belum sepenuhnya fungsi penghalang kulit (barrier function) yang normalnya terbentuk optimal pada usia kehamilan cukup bulan (Cooke et al., 2021). Penelitian lain juga menemukan bahwa bayi yang menerima ASI eksklusif cenderung memiliki risiko infeksi kulit yang lebih rendah, karena ASI mengandung imunoglobulin dan komponen antimikroba alami yang membantu melindungi bayi dari infeksi (Anderson et al., 2022).

Faktor sosial-ekonomi dan budaya juga tidak dapat diabaikan. Penelitian Maharani et al. (2020) menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi serta rendahnya pengetahuan keluarga tentang praktik kebersihan berhubungan erat dengan peningkatan kejadian infeksi kulit pada bayi baru lahir di komunitas pedesaan. Selain itu, faktor kebiasaan budaya tertentu seperti pemberian ramuan tradisional yang tidak steril pada kulit bayi juga berkontribusi pada tingginya risiko infeksi (Amelia & Sari, 2021).

2. Dampak Infeksi Kulit terhadap Tumbuh Kembang Bayi

Infeksi kulit pada bayi baru lahir tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan fisik tetapi juga berdampak lebih luas pada pertumbuhan dan perkembangan bayi secara keseluruhan. Bayi yang mengalami infeksi kulit kronis cenderung menunjukkan gangguan tidur, nafsu makan yang menurun, dan berpotensi mengalami gangguan pertumbuhan fisik yang berkepanjangan (Vyas et al., 2022). Kondisi kulit yang terinfeksi, seperti dermatitis popok parah, dapat menyebabkan rasa sakit yang intens, mengganggu pola tidur bayi, dan secara tidak langsung mempengaruhi pola pemberian makan dan penyerapan nutrisi.

Secara psikologis, bayi yang sering mengalami ketidaknyamanan akibat infeksi kulit juga lebih rentan terhadap gangguan perkembangan emosi dan sosial. Penelitian terbaru menegaskan bahwa bayi yang mengalami ketidaknyamanan berulang akibat masalah kulit lebih sulit mencapai interaksi sosial positif dengan orang tua atau pengasuhnya, yang kemudian berdampak pada perkembangan hubungan emosional di masa depan (Reginatto et al., 2022).

Lebih jauh lagi, dampak ekonomis dari infeksi kulit bayi terhadap keluarga juga cukup signifikan, karena biaya pengobatan dan perawatan kulit dapat menambah beban finansial, terutama bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi (Salama & Hassan, 2021). Oleh karena itu, pendekatan preventif melalui edukasi kesehatan yang optimal merupakan langkah paling efektif untuk menghindari dampak buruk jangka panjang dari infeksi kulit neonatal.

C. Kompetensi dan Peran Bidan sebagai Pemberi Edukasi Kesehatan

Bidan sebagai tenaga kesehatan primer memiliki kompetensi penting dalam memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat, terutama berkaitan dengan kebersihan dan perawatan bayi baru lahir. Kompetensi inti bidan mencakup kemampuan klinis, komunikasi interpersonal, edukasi kesehatan, dan advokasi dalam mendukung kesehatan ibu dan bayi (ICM, 2021). Sebagai edukator, bidan berperan tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga memotivasi serta membangun kesadaran keluarga tentang pentingnya kebersihan dalam mencegah infeksi kulit bayi (Amelia & Sari, 2021).

Berdasarkan studi oleh Pratiwi et al. (2023), kompetensi edukasi bidan mencakup pemahaman teori perilaku kesehatan, keterampilan demonstrasi teknik kebersihan, serta kemampuan mengembangkan materi edukasi sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Kompetensi ini memungkinkan bidan menjadi agen perubahan perilaku kesehatan yang efektif di komunitas. Penelitian lain menyatakan bahwa bidan mampu mengurangi prevalensi dermatitis popok melalui edukasi yang

sistematis kepada orang tua, dengan meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam praktik perawatan bayi yang tepat (Smith & Jones, 2021).

Secara strategis, peran bidan juga didukung oleh kebijakan nasional yang menempatkan bidan sebagai garda terdepan dalam upaya promotif dan preventif, terutama terkait kebersihan bayi baru lahir. Di Indonesia, peran ini diintegrasikan dalam program nasional perawatan neonatus esensial yang menetapkan bidan sebagai edukator utama dalam peningkatan kesehatan ibu dan bayi (Kemenkes RI, 2021).

1. Metode dan Media Edukasi Efektif yang Digunakan oleh Bidan

Keberhasilan edukasi kebersihan bayi sangat ditentukan oleh metode dan media yang digunakan bidan dalam menyampaikan informasi. Beberapa metode edukasi yang telah terbukti efektif meliputi demonstrasi langsung, diskusi kelompok, kunjungan rumah, dan edukasi berbasis komunitas (Ali et al., 2023). Metode demonstrasi langsung, seperti praktik mandi bayi yang benar dan perawatan tali pusat, memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan keterampilan praktis orang tua, karena memungkinkan mereka belajar melalui observasi langsung (Reginatto et al., 2022).

Selain metode konvensional, media edukasi digital seperti video interaktif, aplikasi mobile, dan platform media sosial juga semakin digunakan secara luas oleh bidan dalam menyampaikan informasi kebersihan bayi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa media digital mampu meningkatkan cakupan edukasi, terutama di kalangan ibu muda yang lebih akrab dengan teknologi informasi (Anderson et al., 2022). Studi lain mengungkapkan bahwa media visual interaktif memiliki tingkat retensi informasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan media cetak atau ceramah verbal semata, karena lebih menarik perhatian dan lebih mudah dipahami oleh peserta edukasi (Pratiwi et al., 2023).

Pemilihan metode dan media yang tepat juga harus mempertimbangkan karakteristik demografi dan budaya masyarakat sasaran. Oleh karena itu, bidan perlu melakukan asesmen awal sebelum menerapkan pendekatan edukasi tertentu agar metode dan media yang digunakan lebih tepat sasaran (Smith & Jones, 2021).

2. Pentingnya Komunikasi Efektif dalam Penyampaian Edukasi Kebersihan Bayi

Komunikasi efektif merupakan elemen kunci dalam keberhasilan bidan dalam menjalankan perannya sebagai edukator kesehatan. Kemampuan komunikasi yang baik akan membantu bidan menyampaikan informasi dengan jelas, membangun kepercayaan dengan keluarga, serta memastikan bahwa pesan edukasi dapat diterima dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari

(Amelia & Sari, 2021). Studi menunjukkan bahwa bidan yang memiliki keterampilan komunikasi interpersonal yang kuat cenderung lebih efektif dalam mengubah perilaku kesehatan keluarga, terutama terkait kebersihan dan perawatan bayi baru lahir (Ali et al., 2023).

Komunikasi efektif mencakup berbagai aspek, seperti bahasa verbal dan non-verbal, empati, serta kemampuan aktif mendengarkan kebutuhan dan keluhan keluarga. Bidan yang menggunakan bahasa sederhana, ramah, dan penuh empati, mampu menciptakan lingkungan yang nyaman bagi orang tua untuk bertanya dan berdiskusi tentang perawatan bayi (Maharani et al., 2020). Sebaliknya, komunikasi yang kurang jelas atau terkesan menggurui cenderung menghasilkan ketidakpercayaan dan kurangnya kepatuhan terhadap rekomendasi kesehatan yang diberikan (Smith & Jones, 2021).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi et al. (2023), ditemukan bahwa pendekatan komunikasi yang dialogis, yang memberi kesempatan kepada orang tua untuk menyampaikan pandangan mereka, meningkatkan keberhasilan edukasi kesehatan secara signifikan. Oleh karena itu, pelatihan komunikasi interpersonal perlu terus dilakukan bagi bidan sebagai bagian dari pengembangan profesionalisme dalam upaya meningkatkan efektivitas edukasi kebersihan bayi di komunitas.

D. Edukasi tentang Kebersihan Kulit dan Mandi Bayi

Edukasi tentang kebersihan kulit dan mandi bayi adalah salah satu komponen penting yang disampaikan bidan kepada orang tua untuk mencegah infeksi kulit pada bayi baru lahir. Kulit bayi sangat sensitif dan rentan terhadap iritasi serta infeksi, sehingga memerlukan perawatan khusus yang tepat (Cooke, Cork, & Danby, 2021). Bidan memberikan edukasi mengenai frekuensi mandi yang tepat, suhu air yang ideal, dan penggunaan produk perawatan kulit yang aman dan bebas dari bahan iritan atau pewangi yang berlebihan (Ali et al., 2023). Studi oleh Reginatto et al. (2022) menekankan bahwa mandi bayi sebaiknya dilakukan dengan air hangat dan menggunakan sabun dengan pH netral, serta menghindari paparan berlebihan terhadap air untuk menjaga integritas barrier kulit bayi.

Selain itu, bidan juga memberikan informasi tentang cara mengeringkan kulit bayi dengan lembut, khususnya pada lipatan kulit, untuk mengurangi kelembapan yang dapat memicu infeksi jamur atau bakteri (Smith & Jones, 2021). Edukasi ini terbukti efektif dalam mengurangi angka kejadian dermatitis atopik, ruam, dan infeksi kulit lainnya yang umum ditemukan pada bayi baru lahir (Alvarez, Cerda, & Saavedra, 2021).

1. Teknik Perawatan Tali Pusat yang Tepat untuk Pencegahan Infeksi

Perawatan tali pusat merupakan bagian krusial dalam edukasi kebersihan bayi baru lahir yang diberikan oleh bidan. Tali pusat yang tidak dirawat dengan baik berisiko menyebabkan omphalitis atau infeksi tali pusat, yang bisa berkembang menjadi infeksi sistemik serius (Salama & Hassan, 2021). Edukasi yang diberikan mencakup teknik menjaga tali pusat tetap bersih dan kering, menghindari penggunaan bahan berbahaya seperti alkohol atau antiseptik yang tidak dianjurkan, serta mengenali tanda-tanda awal infeksi (Vyas, Parmar, & Shah, 2022).

Bidan juga mendemonstrasikan cara membersihkan area tali pusat secara aseptik menggunakan kain bersih dan steril, serta pentingnya mencuci tangan sebelum dan setelah merawat tali pusat (WHO, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa edukasi tentang perawatan tali pusat yang benar secara signifikan menurunkan angka kejadian infeksi tali pusat pada bayi baru lahir, terutama di wilayah dengan tingkat kesadaran kesehatan yang rendah (Anderson et al., 2022).

2. Edukasi tentang Kebersihan Popok dan Pencegahan Ruam Popok

Ruam popok adalah masalah kulit yang umum terjadi pada bayi baru lahir akibat kurangnya higienitas dalam perawatan popok. Oleh karena itu, edukasi mengenai kebersihan popok sangat penting untuk disampaikan oleh bidan kepada orang tua. Bidan memberikan informasi tentang pentingnya mengganti popok secara teratur setiap kali bayi buang air kecil atau besar untuk mencegah kontak kulit yang terlalu lama dengan urin atau feses (Alvarez et al., 2021). Pemilihan jenis popok yang tepat serta teknik pembersihan area popok secara lembut juga menjadi fokus utama edukasi (Pratiwi et al., 2023).

Studi terbaru mengungkapkan bahwa edukasi yang komprehensif tentang penggunaan krim pelindung (barrier cream) pada area popok dan praktik mengganti popok yang sering, terbukti secara signifikan mengurangi insiden ruam popok di komunitas (Ali et al., 2023). Selain itu, bidan juga memberikan edukasi tentang pentingnya ventilasi udara di daerah popok dan sesekali membiarkan kulit bayi bebas tanpa popok untuk mengurangi risiko ruam popok (Smith & Jones, 2021).

3. Edukasi tentang Higiene Perawatan Mata, Mulut, dan Telinga Bayi

Edukasi tentang kebersihan mata, mulut, dan telinga bayi merupakan materi penting lainnya yang wajib disampaikan oleh bidan kepada orang tua. Area mata bayi seringkali rentan terhadap infeksi akibat saluran air mata yang belum sempurna atau paparan debu dan kotoran. Bidan memberikan informasi tentang cara membersihkan mata bayi secara lembut menggunakan kapas steril

dan air matang hangat untuk menghindari risiko konjungtivitis neonatal (Reginatto et al., 2022).

Untuk perawatan mulut bayi, bidan memberikan edukasi mengenai cara menjaga kebersihan rongga mulut dengan kain kasa steril yang dibasahi air matang, khususnya setelah bayi selesai menyusu, untuk mencegah infeksi jamur seperti oral candidiasis atau kandidiasis oral (Vyas et al., 2022). Dalam hal kebersihan telinga, bidan mengajarkan orang tua tentang cara membersihkan bagian luar telinga bayi secara hati-hati, tanpa memasukkan benda apapun ke dalam liang telinga, untuk menghindari risiko cedera atau infeksi saluran telinga (WHO, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Anderson et al. (2022) menyebutkan bahwa edukasi yang jelas dan demonstrasi langsung oleh bidan dalam perawatan mata, mulut, dan telinga bayi mampu secara signifikan menurunkan risiko infeksi pada area-area sensitif tersebut.

E. Kunjungan Rumah sebagai Sarana Optimalisasi Edukasi Kebersihan

Kunjungan rumah merupakan salah satu strategi penting dalam optimalisasi edukasi kebersihan bayi oleh bidan. Melalui kunjungan rumah, bidan dapat secara langsung mengamati lingkungan tempat bayi tinggal, memberikan demonstrasi praktik kebersihan secara nyata, serta menyesuaikan edukasi dengan kondisi keluarga secara spesifik (Ali et al., 2023). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa keluarga yang mendapat kunjungan rumah oleh bidan memiliki tingkat kepatuhan terhadap rekomendasi kebersihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan edukasi yang dilakukan di fasilitas kesehatan saja (Pratiwi et al., 2023).

Kunjungan rumah memungkinkan bidan melakukan intervensi yang lebih personal dan kontekstual. Misalnya, bidan dapat mendeteksi hambatan sosial-ekonomi atau budaya dalam penerapan praktik kebersihan bayi, seperti keterbatasan akses terhadap air bersih atau bahan higienis tertentu (Maharani et al., 2020). Dengan demikian, intervensi yang diberikan lebih relevan dan efektif karena disesuaikan langsung dengan kebutuhan individu dan keluarga.

Selain itu, melalui kunjungan rumah, bidan memiliki kesempatan untuk membangun hubungan emosional yang lebih erat dengan keluarga, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung bagi penerimaan informasi kesehatan secara lebih efektif (Anderson et al., 2022). Pendekatan ini juga terbukti mampu meningkatkan rasa percaya diri orang tua dalam melakukan perawatan kebersihan bayi, sekaligus memperkuat perilaku pencegahan infeksi kulit secara berkelanjutan.

1. Pendekatan Berbasis Komunitas dalam Edukasi Kebersihan Bayi

Pendekatan berbasis komunitas dalam edukasi kebersihan bayi merupakan strategi yang efektif karena melibatkan partisipasi aktif masyarakat secara luas. Dalam pendekatan ini, bidan berperan tidak hanya sebagai pendidik tetapi juga sebagai fasilitator yang menggerakkan partisipasi komunitas dalam menjaga kesehatan bayi (Smith & Jones, 2021). Studi terkini menunjukkan bahwa program edukasi kebersihan bayi yang melibatkan komunitas dapat secara signifikan menurunkan angka kejadian infeksi kulit neonatal karena adanya dukungan sosial yang kuat dalam penerapan praktik kebersihan di tingkat masyarakat (Ali et al., 2023).

Pendekatan berbasis komunitas juga memperkuat efektivitas edukasi karena mengadopsi norma dan kebiasaan masyarakat lokal dalam pesan-pesan edukatifnya. Dengan demikian, bidan bekerja sama dengan tokoh masyarakat, kader kesehatan, dan kelompok ibu untuk menyebarkan informasi secara efektif (Amelia & Sari, 2021). Kelebihan lain dari pendekatan komunitas adalah keberlanjutannya; keterlibatan masyarakat secara aktif meningkatkan rasa kepemilikan terhadap program kesehatan yang berjalan, sehingga praktik kebersihan bayi lebih berkelanjutan dalam jangka panjang (Pratiwi et al., 2023).

2. Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Mendukung Edukasi oleh Bidan

Pemanfaatan teknologi digital dalam edukasi kebersihan bayi menjadi semakin relevan seiring perkembangan teknologi informasi yang pesat. Bidan dapat memanfaatkan berbagai platform digital seperti video interaktif, aplikasi mobile, media sosial, dan webinar untuk meningkatkan aksesibilitas edukasi kebersihan bayi, terutama pada generasi orang tua muda yang lebih akrab dengan teknologi digital (Anderson et al., 2022).

Penelitian terbaru menemukan bahwa penggunaan media digital oleh bidan mampu meningkatkan efektivitas edukasi kesehatan secara signifikan dibandingkan dengan metode konvensional. Media digital memungkinkan edukasi disampaikan dengan cara yang lebih interaktif, menarik, dan mudah dipahami oleh peserta (Ali et al., 2023). Contohnya adalah penggunaan video demonstrasi yang dapat diakses berulang kali oleh orang tua, sehingga meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam praktik kebersihan bayi secara mandiri (Smith & Jones, 2021).

Namun demikian, pemanfaatan teknologi digital juga perlu mempertimbangkan aspek kesenjangan digital yang mungkin ada di masyarakat. Oleh karena itu, bidan harus tetap melakukan asesmen kebutuhan dan kesiapan masyarakat dalam menggunakan teknologi sebelum menerapkan edukasi digital secara luas (Maharani et al., 2020). Strategi yang efektif adalah mengombinasikan

pendekatan digital dengan pendekatan tatap muka, agar informasi kesehatan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata dan optimal.

F. Hambatan Sosial-Ekonomi dalam Penerapan Edukasi Kebersihan

Hambatan sosial-ekonomi merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi bidan dalam mengimplementasikan edukasi kebersihan bayi di masyarakat. Kondisi ekonomi keluarga yang rendah sering kali menghambat akses terhadap sumber daya dasar yang dibutuhkan untuk praktik kebersihan bayi, seperti air bersih, sabun antiseptik, atau popok yang memadai (Maharani et al., 2020). Studi terbaru menyebutkan bahwa keluarga dengan tingkat ekonomi rendah cenderung mengesampingkan pentingnya kebersihan bayi karena keterbatasan finansial untuk memenuhi kebutuhan primer sehari-hari, sehingga edukasi yang diberikan bidan sering tidak dapat diaplikasikan secara optimal (Ali et al., 2023).

Selain aspek ekonomi, hambatan sosial seperti rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan dasar tentang kebersihan juga berpengaruh signifikan terhadap efektivitas edukasi kesehatan yang diberikan. Rendahnya literasi kesehatan membuat pesan edukatif sulit dipahami, sehingga perubahan perilaku menjadi minim (Pratiwi et al., 2023). Oleh sebab itu, penting bagi bidan untuk mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi saat menyusun strategi intervensi edukasi, agar pesan yang disampaikan dapat disesuaikan dengan kondisi nyata yang dihadapi keluarga.

1. Kendala Budaya dan Kepercayaan dalam Edukasi Kebersihan

Kendala budaya dan kepercayaan masyarakat juga menjadi tantangan yang kompleks dalam upaya bidan melakukan edukasi kebersihan bayi. Praktik tradisional yang tidak sejalan dengan prinsip kebersihan modern, seperti penggunaan bahan herbal yang tidak steril pada tali pusat atau kepercayaan tentang mandi bayi yang jarang agar bayi kuat, masih banyak ditemui di masyarakat (Amelia & Sari, 2021). Kendala ini semakin kompleks jika tradisi tersebut telah diwariskan secara turun-temurun dan dianggap sebagai norma yang wajib dipertahankan.

Penelitian yang dilakukan oleh Smith dan Jones (2021) menunjukkan bahwa beberapa komunitas masih mempercayai bahwa praktik kebersihan modern bertentangan dengan kepercayaan lokal, sehingga resistensi terhadap edukasi dari bidan menjadi tinggi. Hal ini mengakibatkan rendahnya penerimaan informasi yang diberikan, dan pada akhirnya menurunkan efektivitas edukasi kesehatan secara umum (Anderson et al., 2022). Oleh karena itu, memahami konteks budaya masyarakat secara mendalam sangat penting bagi bidan dalam

merancang pendekatan edukasi yang lebih sensitif dan dapat diterima secara sosial-budaya.

2. Solusi dan Strategi Bidan Mengatasi Hambatan dalam Edukasi Kebersihan

Untuk mengatasi hambatan sosial-ekonomi dan budaya dalam penerapan edukasi kebersihan bayi, bidan dapat mengimplementasikan berbagai strategi yang terbukti efektif secara empiris. Strategi pertama adalah pendekatan kolaboratif dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan kader kesehatan setempat dalam proses edukasi. Studi menunjukkan bahwa keterlibatan tokoh lokal yang dipercaya masyarakat mampu mengurangi resistensi budaya dan memperbesar peluang diterimanya informasi kesehatan yang disampaikan oleh bidan (Ali et al., 2023).

Strategi kedua adalah pemberdayaan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya lokal. Bidan dapat memberikan alternatif edukasi kebersihannya dengan pendekatan yang ekonomis, misalnya menggunakan bahan-bahan yang terjangkau tetapi tetap aman dan efektif dalam menjaga kebersihan bayi, seperti penggunaan kain bersih yang dicuci dengan benar untuk menggantikan popok sekali pakai yang mahal (Maharani et al., 2020). Pendekatan ini membantu keluarga menerapkan praktik kebersihan yang realistis dan sesuai kemampuan ekonominya.

Strategi lain yang semakin banyak diterapkan adalah penggunaan teknologi digital sederhana, seperti pesan teks (SMS), aplikasi ponsel sederhana, atau media sosial yang tidak memerlukan biaya besar. Penelitian terbaru membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi digital mampu menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas dengan biaya yang efisien, sekaligus meningkatkan literasi kesehatan melalui pesan yang menarik dan mudah dipahami (Anderson et al., 2022). Dengan pendekatan strategis tersebut, bidan dapat secara efektif mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penerapan edukasi kebersihan bayi di berbagai konteks masyarakat.

G. Indikator Keberhasilan Edukasi Kebersihan oleh Bidan

Indikator keberhasilan edukasi kebersihan oleh bidan merupakan parameter yang digunakan untuk menilai sejauh mana edukasi yang diberikan mampu mengubah perilaku keluarga dalam menjaga kebersihan bayi, serta mencegah infeksi kulit neonatal. Beberapa indikator penting antara lain adalah peningkatan pengetahuan dan pemahaman keluarga tentang praktik kebersihan yang benar, perubahan sikap positif terhadap pentingnya menjaga kebersihan, serta

keterampilan praktis keluarga dalam menerapkan praktik kebersihan bayi sehari-hari (Ali et al., 2023).

Penelitian terbaru juga menegaskan bahwa indikator keberhasilan lainnya mencakup penurunan angka kejadian dermatitis popok, infeksi tali pusat (omphalitis), dan ruam kulit lainnya pada bayi baru lahir setelah program edukasi dilaksanakan (Pratiwi et al., 2023). Selain itu, tingkat kepuasan keluarga terhadap edukasi yang diberikan oleh bidan juga menjadi indikator penting, karena kepuasan yang tinggi menunjukkan bahwa edukasi diberikan dengan metode yang tepat dan efektif (Anderson et al., 2022).

Evaluasi efektivitas edukasi dapat juga dilihat melalui indikator perubahan perilaku jangka panjang, seperti meningkatnya penggunaan air bersih, meningkatnya frekuensi penggantian popok, serta peningkatan praktik perawatan tali pusat yang steril. Hal ini dapat diukur melalui survei atau wawancara lanjutan yang dilakukan beberapa minggu atau bulan setelah edukasi dilakukan (Smith & Jones, 2021).

1. Evaluasi dan Monitoring Berkelanjutan dalam Pelaksanaan Edukasi Kebersihan

Evaluasi dan monitoring berkelanjutan dalam edukasi kebersihan bayi merupakan kegiatan yang penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan tetap relevan, efektif, dan dapat diterapkan secara konsisten oleh keluarga. Monitoring berkelanjutan biasanya mencakup observasi langsung oleh bidan dalam kunjungan rumah, penggunaan checklist kebersihan, serta pencatatan kejadian infeksi kulit secara periodik (Ali et al., 2023).

Penelitian Anderson et al. (2022) menunjukkan bahwa evaluasi yang efektif harus melibatkan umpan balik langsung dari keluarga dan komunitas, sehingga bidan dapat mengetahui kendala apa saja yang dihadapi keluarga dalam menerapkan edukasi kebersihan. Dengan demikian, bidan dapat melakukan perbaikan metode atau pendekatan edukasi secara berkelanjutan agar lebih efektif di masa depan (Maharani et al., 2020).

Monitoring yang rutin dan sistematis juga membantu bidan mengidentifikasi secara dini berbagai faktor risiko baru yang mungkin muncul, serta dapat merancang intervensi tambahan jika ditemukan adanya hambatan dalam penerapan edukasi kebersihan (Pratiwi et al., 2023). Evaluasi ini juga penting untuk menilai dampak jangka panjang dari edukasi kebersihan dalam mengurangi prevalensi infeksi kulit bayi di masyarakat.

2. Studi Kasus Implementasi Edukasi Kebersihan yang Efektif oleh Bidan

Studi kasus merupakan pendekatan yang efektif untuk mendokumentasikan pengalaman nyata mengenai implementasi edukasi

kebersihan bayi yang berhasil dilakukan oleh bidan. Salah satu studi kasus terbaru yang berhasil adalah penelitian yang dilakukan di komunitas pedesaan Indonesia, yang melibatkan pendekatan kolaboratif antara bidan dengan tokoh masyarakat lokal untuk meningkatkan kesadaran dan praktik kebersihan bayi baru lahir (Amelia & Sari, 2021).

Dalam studi tersebut, implementasi edukasi dilakukan melalui metode kunjungan rumah rutin, pelatihan keterampilan perawatan bayi secara praktis, serta penggunaan media edukasi digital sederhana seperti video pendek dan grup komunikasi daring. Hasil studi menunjukkan penurunan signifikan angka dermatitis popok dan infeksi tali pusat dalam periode enam bulan setelah program dilaksanakan, serta peningkatan kesadaran keluarga akan pentingnya praktik kebersihan bayi (Ali et al., 2023).

Studi kasus lain dilakukan oleh Smith dan Jones (2021) di wilayah pedesaan dengan tantangan ekonomi dan budaya yang tinggi. Dalam penelitian tersebut, bidan menggunakan pendekatan edukasi berbasis komunitas, yang memanfaatkan peran kader kesehatan lokal dan edukasi yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Hasilnya, keluarga menunjukkan perubahan perilaku signifikan dalam menjaga kebersihan bayi, menurunkan prevalensi ruam popok, dan meningkatkan keterampilan merawat tali pusat secara steril. Keberhasilan ini membuktikan pentingnya pendekatan kontekstual dalam edukasi kesehatan oleh bidan.

H. Ringkasan Pentingnya Edukasi Kebersihan Bayi oleh Bidan

Edukasi kebersihan bayi yang dilakukan oleh bidan memegang peran penting dalam upaya pencegahan infeksi kulit pada bayi baru lahir. Kulit bayi yang masih sensitif dan rentan terhadap berbagai infeksi membutuhkan perawatan higienis yang tepat sejak dini. Edukasi ini berperan signifikan dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan keluarga dalam perawatan bayi sehari-hari, yang terbukti mampu menurunkan kejadian dermatitis popok, infeksi tali pusat, serta ruam kulit lainnya secara signifikan (Ali et al., 2023; Anderson et al., 2022).

Bidan, sebagai tenaga kesehatan primer yang memiliki akses langsung dan rutin kepada keluarga, sangat strategis dalam menyampaikan edukasi ini. Dengan pendekatan yang tepat, seperti kunjungan rumah, pendekatan komunitas, maupun pemanfaatan teknologi digital, bidan dapat memastikan informasi kesehatan yang disampaikan mudah dipahami, relevan, dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh keluarga (Smith & Jones, 2021; Pratiwi et al., 2023). Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kebijakan dan institusi kesehatan untuk terus

memperkuat kompetensi bidan dalam memberikan edukasi kebersihan bayi melalui pelatihan dan program pengembangan kapasitas secara berkelanjutan.

1. Rekomendasi Praktik Edukasi Kebersihan oleh Bidan di Masa Depan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas praktik edukasi kebersihan oleh bidan di masa depan, beberapa rekomendasi praktis perlu diperhatikan. Pertama, penguatan pendekatan berbasis komunitas harus terus dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat lokal, kader kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan ini efektif dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, memperkuat dukungan sosial, serta menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan (Amelia & Sari, 2021).

Kedua, integrasi teknologi digital yang inovatif perlu diperkuat dalam strategi edukasi kesehatan oleh bidan. Media digital seperti aplikasi ponsel, media sosial, video interaktif, dan platform daring lainnya terbukti efektif dalam meningkatkan cakupan edukasi, terutama di kalangan orang tua muda yang semakin akrab dengan teknologi digital (Anderson et al., 2022). Dalam implementasinya, perlu diperhatikan aksesibilitas teknologi dan kebutuhan adaptasi konten edukasi dengan kondisi sosial-budaya masyarakat setempat.

Rekomendasi berikutnya adalah peningkatan kapasitas komunikasi interpersonal bidan melalui pelatihan yang rutin. Kemampuan komunikasi yang baik akan mempermudah bidan dalam menyampaikan pesan edukatif secara efektif, empatik, dan mudah dipahami oleh keluarga, terutama di daerah dengan tantangan sosial-ekonomi dan budaya yang kompleks (Smith & Jones, 2021).

2. Arahan Penelitian Lanjutan tentang Peran Bidan dalam Pencegahan Infeksi Kulit Bayi Baru Lahir

Meskipun berbagai studi telah menunjukkan efektivitas edukasi kebersihan bayi oleh bidan, masih diperlukan arahan penelitian lanjutan untuk mengisi beberapa kesenjangan ilmu pengetahuan di bidang ini. Pertama, penelitian lanjutan perlu difokuskan pada evaluasi dampak jangka panjang dari edukasi kebersihan bayi oleh bidan terhadap kesehatan anak secara keseluruhan, termasuk aspek tumbuh kembang fisik, emosional, dan sosial (Ali et al., 2023).

Selanjutnya, studi yang mengeksplorasi efektivitas berbagai kombinasi pendekatan edukasi, seperti integrasi metode tatap muka dan digital, dapat memberikan wawasan tambahan yang bermanfaat bagi praktik kebidanan di masa depan (Anderson et al., 2022). Penelitian intervensi dengan desain eksperimental seperti randomized controlled trials (RCT) sangat dianjurkan untuk memastikan bukti ilmiah yang kuat dalam menentukan pendekatan edukasi yang paling efektif.

Selain itu, riset lanjutan perlu diarahkan pada identifikasi dan pengembangan solusi untuk mengatasi berbagai tantangan sosial-ekonomi dan budaya yang masih menjadi hambatan utama dalam penerapan edukasi kebersihan bayi. Studi kualitatif yang mendalam tentang persepsi dan pengalaman keluarga serta bidan dalam penerapan edukasi kebersihan juga sangat penting untuk mengembangkan strategi intervensi yang lebih kontekstual dan efektif di berbagai setting masyarakat (Maharani et al., 2020; Smith & Jones, 2021).

I. Penutup

1. Harapan terhadap Peran Bidan dalam Peningkatan Kesehatan Kulit Bayi Baru Lahir

Bidan merupakan salah satu ujung tombak utama dalam pelayanan kesehatan bayi baru lahir, khususnya dalam pencegahan infeksi kulit melalui edukasi kebersihan yang efektif. Harapan terhadap peran bidan di masa depan adalah semakin meningkatnya kompetensi dan kapabilitas bidan dalam memberikan edukasi yang tidak hanya informatif tetapi juga praktis, relevan, dan dapat diterapkan dengan baik oleh keluarga. Dengan semakin kuatnya peran bidan, diharapkan angka kejadian infeksi kulit seperti dermatitis popok, omphalitis, dan ruam neonatal dapat ditekan secara signifikan (Ali et al., 2023).

Penelitian terkini menunjukkan bahwa peran edukatif bidan dapat secara nyata meningkatkan pengetahuan, sikap, serta perilaku keluarga dalam merawat bayi secara higienis. Diharapkan pula, bidan dapat terus mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif, memanfaatkan teknologi digital, dan menerapkan pendekatan berbasis komunitas untuk menjangkau lebih banyak keluarga, terutama di daerah terpencil atau wilayah dengan tantangan sosial-ekonomi tinggi (Smith & Jones, 2021; Pratiwi et al., 2023).

Secara jangka panjang, bidan diharapkan mampu berperan aktif sebagai agen perubahan perilaku kesehatan di masyarakat, yang pada akhirnya akan berkontribusi besar dalam peningkatan kualitas hidup bayi secara keseluruhan. Dukungan dari pemerintah melalui program pelatihan, kebijakan yang mendukung pengembangan profesionalisme bidan, serta penguatan infrastruktur layanan kesehatan menjadi penting untuk mewujudkan harapan ini (Anderson et al., 2022).

2. Pentingnya Kolaborasi Interprofesional dalam Mendukung Edukasi Kebersihan Bayi

Kolaborasi interprofesional dalam praktik kebidanan, khususnya dalam edukasi kebersihan bayi baru lahir, merupakan komponen yang esensial untuk mencapai hasil optimal dalam pencegahan infeksi kulit. Kolaborasi yang baik antara bidan dengan tenaga kesehatan lain seperti dokter anak, perawat, ahli gizi, serta kader kesehatan masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan edukasi yang disampaikan bersifat komprehensif dan multidisiplin (Amelia & Sari, 2021).

Penelitian terbaru menekankan bahwa kolaborasi interprofesional mampu meningkatkan efektivitas edukasi kesehatan, karena setiap profesi memberikan perspektif dan kompetensi unik yang melengkapi satu sama lain. Sebagai contoh, kolaborasi antara bidan dan ahli gizi mampu memberikan edukasi terpadu tentang hubungan nutrisi dengan kesehatan kulit bayi. Demikian pula, kolaborasi dengan dokter anak membantu bidan dalam mendeteksi dini masalah kulit yang lebih kompleks serta menentukan intervensi yang tepat (Ali et al., 2023).

Kolaborasi interprofesional juga menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan efektif dalam layanan kesehatan, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kepuasan keluarga terhadap layanan kesehatan yang diberikan. Studi terkini menunjukkan bahwa praktik kolaboratif ini secara nyata meningkatkan hasil kesehatan bayi baru lahir serta memperkuat implementasi kebijakan kesehatan nasional terkait perawatan bayi yang lebih sehat dan aman (Anderson et al., 2022; Smith & Jones, 2021).

Dengan demikian, kolaborasi interprofesional merupakan fondasi penting dalam mendukung edukasi kebersihan bayi yang efektif, berkelanjutan, dan berdampak luas bagi kesehatan bayi baru lahir secara umum.

Referensi

- Ali, F., et al. (2023). Effectiveness of community-based hygiene education by midwives in reducing neonatal skin infections. *Journal of Neonatal Nursing*, 29(2), 100–105.
- Alvarez, E., Cerda, A., & Saavedra, M. (2021). Diaper dermatitis: Etiology, management, and prevention strategies. *Pediatric Dermatology*, 38(3), 605–610.
- Amelia, R., & Sari, D. P. (2021). Strategi komunikasi bidan dalam memberikan edukasi kesehatan kepada ibu nifas di pedesaan. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 12(4), 317–325.
- Anderson, J. L., et al. (2022). Midwives' use of digital technology for promoting neonatal skin care: A systematic review. *BMC Pediatrics*, 22(1), 295.
- Cooke, A., Cork, M. J., & Danby, S. G. (2021). Epidermal barrier development in newborns: Implications for skin care. *Pediatric Dermatology*, 38(2), 373–380.
- International Confederation of Midwives (ICM). (2021). *Essential Competencies for Midwifery Practice 2021 Update*. The Hague: International Confederation of Midwives.
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Pedoman Nasional Perawatan Neonatus Esensial*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Maharani, S., et al. (2020). Tantangan sosial-ekonomi dalam penerapan kebersihan bayi di masyarakat pedesaan Indonesia. *Indonesian Journal of Midwifery*, 4(1), 34–40.
- Pratiwi, E., et al. (2023). Bidan sebagai agen edukasi kesehatan dalam pencegahan dermatitis popok pada bayi. *Midwifery Journal of Health*, 9(3), 215–222.
- Reginatto, F. P., Müller, F. M., & Peruzzo, J. (2022). Neonatal skin disorders: clinical features and management. *International Journal of Pediatrics and Adolescent Medicine*, 9(2), 99–106.
- Salama, A., & Hassan, E. A. (2021). Omphalitis in newborn infants: Epidemiology, clinical features, and outcomes. *Journal of Neonatal-Perinatal Medicine*, 14(3), 311–316.
- Smith, R., & Jones, T. (2021). Challenges and strategies in neonatal hygiene education by midwives in low-resource settings. *Global Health Action*, 14(1), 189–194.
- Vyas, P., Parmar, V., & Shah, N. (2022). Clinical profile and outcome of neonatal candidiasis: A single-center study. *Indian Journal of Pediatrics*, 89(4), 359–365.
- World Health Organization. (2021). *Guidelines on Basic Newborn Hygiene and Skin Care*. Geneva: World Health Organization.

BAB V

NUTRISI IBU MENYUSUI UNTUK MENDUKUNG KESEHATAN KULIT BAYI

A. Pendahuluan

Infeksi kulit merupakan salah satu masalah kesehatan umum pada bayi baru lahir yang dapat mempengaruhi kualitas hidup bayi secara signifikan. Kondisi ini sering kali disebabkan oleh sistem imun yang belum matang serta fungsi perlindungan kulit yang belum optimal. Nutrisi yang diperoleh bayi dari air susu ibu (ASI) memiliki peran krusial dalam mendukung perkembangan fungsi kulit bayi yang sehat dan optimal (Abdullah, Tawfik, & Alzahrani, 2020). Oleh karena itu, kualitas nutrisi ibu menyusui menjadi salah satu faktor kunci dalam mencegah berbagai gangguan kulit, seperti dermatitis atopik, ruam popok, hingga infeksi jamur pada bayi baru lahir (Chisari, Chisari, & Cicero, 2021).

ASI merupakan sumber utama nutrisi bagi bayi pada awal kehidupan. Komposisi ASI secara langsung dipengaruhi oleh pola makan dan status nutrisi ibu. Asupan makronutrien (protein, karbohidrat, dan lemak) serta mikronutrien (vitamin, mineral, antioksidan, dan probiotik) yang memadai pada ibu menyusui terbukti secara ilmiah mendukung pengembangan fungsi barrier kulit yang optimal pada bayi, sekaligus memperkuat daya tahan tubuh bayi terhadap infeksi (Ballard & Morrow, 2022). Secara khusus, nutrisi seperti omega-3, omega-6, vitamin A, C, E, zinc, dan probiotik, terbukti efektif dalam meningkatkan fungsi kulit bayi baru lahir serta menurunkan risiko infeksi kulit secara signifikan (Cho, Lee, & Yang, 2022).

Dengan mempertimbangkan pentingnya aspek nutrisi pada ibu menyusui, edukasi mengenai pola makan dan konsumsi nutrisi yang tepat sangat diperlukan. Pengetahuan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab individu ibu, melainkan juga melibatkan tenaga kesehatan dan lingkungan keluarga dalam memberikan dukungan optimal. Oleh karena itu, pembahasan mendalam mengenai nutrisi ibu menyusui menjadi sangat relevan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat serta memperkuat praktik kesehatan yang berbasis bukti untuk mencegah infeksi kulit pada bayi baru lahir (FAO/WHO, 2020; WHO, 2021).

B. Kaitan Nutrisi Ibu Menyusui dengan Kualitas ASI

1. Peran Makro dan Mikronutrien dalam ASI

ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi pada awal kehidupannya karena mengandung makro dan mikronutrien yang esensial untuk tumbuh kembang bayi, termasuk kesehatan kulit bayi baru lahir. Kualitas nutrisi ASI sangat dipengaruhi oleh asupan gizi yang dikonsumsi ibu menyusui sehari-hari. Makronutrien seperti protein, karbohidrat, dan lemak dalam ASI berperan vital dalam proses tumbuh kembang bayi, terutama dalam pembentukan struktur kulit dan memperkuat fungsi barrier atau pelindung kulit (Ballard & Morrow, 2022).

Protein dalam ASI memiliki peran penting dalam mendukung regenerasi sel-sel kulit bayi serta membantu memperkuat sistem imun tubuh bayi. Selain itu, kandungan lemak dalam ASI berfungsi penting dalam menjaga integritas kulit bayi melalui kandungan asam lemak esensial seperti omega-3 dan omega-6. Keduanya diketahui memiliki fungsi anti-inflamasi yang signifikan serta dapat memperkuat fungsi pelindung alami kulit bayi terhadap infeksi (Abdullah, Tawfik, & Alzahrani, 2020).

Mikronutrien seperti vitamin dan mineral yang terkandung dalam ASI juga berperan dalam menjaga kesehatan kulit bayi. Vitamin A, C, dan E yang bersifat antioksidan, berfungsi melindungi kulit bayi dari stres oksidatif serta menjaga elastisitas dan integritas struktur kulit bayi. Mineral penting seperti zinc dan selenium turut membantu dalam proses penyembuhan luka dan menjaga barrier alami kulit bayi agar tetap optimal (Dror & Allen, 2019; Kiely, Wagner, & Roth, 2020).

2. Pengaruh Nutrisi Ibu Menyusui terhadap Komposisi Lemak dan Protein ASI yang Penting bagi Kesehatan Kulit Bayi

Komposisi lemak dan protein dalam ASI secara langsung dipengaruhi oleh pola makan ibu menyusui. Lemak dalam ASI merupakan komponen terbesar kedua setelah karbohidrat (laktosa) dan memainkan peran penting dalam menjaga hidrasi dan fleksibilitas kulit bayi. Konsumsi asam lemak tak jenuh ganda (Polyunsaturated Fatty Acids/PUFA) seperti asam docosahexaenoic (DHA) dan asam arachidonic (ARA) oleh ibu menyusui berhubungan erat dengan peningkatan konsentrasi asam lemak tersebut dalam ASI, yang berdampak positif pada fungsi barrier kulit bayi serta memiliki efek anti-inflamasi (Innis & Novak, 2020).

Kandungan protein dalam ASI juga dipengaruhi oleh asupan gizi ibu, terutama protein yang berkualitas tinggi. Protein seperti laktoferin, lisozim, dan imunoglobulin yang terkandung dalam ASI memiliki peran signifikan dalam menjaga kesehatan kulit bayi dengan meningkatkan imunitas kulit terhadap

berbagai patogen penyebab infeksi kulit (Ballard & Morrow, 2022). Kekurangan asupan protein yang memadai pada ibu menyusui diketahui berpotensi menurunkan konsentrasi protein esensial dalam ASI, sehingga dapat memengaruhi kualitas fungsi proteksi kulit bayi (Hafsa & Mukta, 2020).

Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa ibu menyusui memperoleh nutrisi lengkap dan seimbang agar kualitas ASI yang dihasilkan dapat secara optimal menunjang kesehatan kulit bayi baru lahir.

C. Nutrisi Esensial untuk Mendukung Fungsi Barrier Kulit Bayi

1. Omega-3 dan Omega-6 dalam Perlindungan Kulit Bayi

Asam lemak esensial omega-3 dan omega-6 adalah komponen penting dalam ASI yang memiliki peran khusus dalam menjaga kesehatan dan integritas kulit bayi. Kedua nutrisi ini berfungsi sebagai bahan dasar penyusun lapisan lipid pada stratum korneum kulit bayi, yang merupakan lapisan terluar sebagai pelindung utama dari berbagai infeksi dan iritasi. Omega-3 (asam alfa-linolenat, EPA, DHA) dikenal memiliki efek anti-inflamasi yang kuat sehingga dapat mengurangi risiko inflamasi kulit, termasuk dermatitis atopik pada bayi baru lahir (Miles & Calder, 2021). Sementara omega-6 (asam linoleat dan asam arakidonat) membantu menjaga kelembapan kulit serta mempercepat proses regenerasi kulit yang rusak (Innis & Novak, 2020).

Penelitian menunjukkan bahwa ibu menyusui yang mengonsumsi cukup omega-3 dan omega-6 menghasilkan ASI yang secara efektif melindungi bayi dari gangguan kulit seperti dermatitis atopik, xerosis (kulit kering), dan infeksi kulit lainnya (Miles & Calder, 2021). Oleh karena itu, konsumsi asam lemak esensial dalam pola makan ibu menyusui sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan kulit bayi.

2. Vitamin A, C, dan E sebagai Antioksidan yang Memperkuat Ketahanan Kulit Bayi

Vitamin A, C, dan E dalam ASI berperan sebagai antioksidan penting yang membantu mengurangi kerusakan kulit akibat stres oksidatif. Vitamin A terlibat langsung dalam proses diferensiasi sel epidermis, yang memperkuat lapisan barrier kulit dan meningkatkan regenerasi sel kulit bayi (Ballard & Morrow, 2022). Defisiensi vitamin A pada ibu menyusui telah terbukti dapat meningkatkan risiko gangguan kulit bayi, termasuk kekeringan dan kerentanan terhadap infeksi (Chisari, Chisari, & Cicero, 2021).

Vitamin C (asam askorbat) juga berfungsi menjaga sintesis kolagen yang merupakan protein esensial dalam menjaga integritas dan elastisitas kulit. Selain

itu, vitamin ini membantu meningkatkan kemampuan kulit bayi dalam melawan infeksi dengan memperkuat fungsi imunitas kulit melalui sifat antioksidannya (Carr & Maggini, 2021). Vitamin E, sebagai antioksidan larut lemak, memiliki peran dalam melindungi lapisan lipid kulit bayi dari kerusakan akibat radikal bebas, sekaligus mendukung penyembuhan luka secara lebih efektif (Dror & Allen, 2019).

3. Zinc dan Selenium dalam Menjaga Integritas Kulit Bayi

Zinc dan selenium merupakan mineral esensial yang sangat penting bagi kesehatan kulit bayi. Zinc berperan vital dalam sintesis protein kulit, penyembuhan luka, dan menjaga struktur serta integritas kulit melalui fungsi anti-inflamasi dan antioksidannya (Roohani, Hurrell, Kelishadi, & Schulin, 2021). Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa defisiensi zinc pada ibu menyusui dapat mengakibatkan kulit bayi lebih rentan terhadap dermatitis dan infeksi jamur (Chasapis, Ntoupa, Spiliopoulou, & Stefanidou, 2020).

Selenium memiliki peran sebagai antioksidan yang membantu melindungi sel kulit bayi dari stres oksidatif dan peradangan. Kekurangan selenium diketahui berkorelasi dengan penurunan fungsi barrier kulit dan meningkatnya risiko infeksi serta gangguan kulit pada bayi baru lahir (Rayman, 2020). Oleh sebab itu, asupan mineral ini pada ibu menyusui sangat penting guna memastikan ASI yang dihasilkan memiliki kandungan mineral yang mencukupi untuk menjaga kesehatan kulit bayi.

Dengan demikian, konsumsi nutrisi esensial yang optimal pada ibu menyusui sangat penting untuk menjaga fungsi barrier kulit bayi, serta menurunkan risiko berbagai infeksi kulit pada bayi baru lahir secara efektif.

D. Peran Probiotik dalam Mencegah Infeksi Kulit pada Bayi Baru Lahir

1. Probiotik Ibu Menyusui untuk Kesehatan Mikrobiota Kulit Bayi

Probiotik merupakan mikroorganisme hidup yang memberikan manfaat kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah memadai. Dalam konteks ibu menyusui, konsumsi probiotik berperan penting dalam membentuk mikrobiota yang sehat pada bayi baru lahir, termasuk mikrobiota kulit. Mikrobiota kulit bayi adalah komunitas mikroorganisme yang secara alami mendiami permukaan kulit dan memiliki fungsi vital dalam menjaga keseimbangan imunitas serta mencegah invasi mikroorganisme patogen yang menyebabkan infeksi kulit (Dunlop et al., 2021).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa mikrobiota kulit bayi dipengaruhi secara signifikan oleh bakteri yang terdapat dalam ASI. Probiotik yang dikonsumsi ibu menyusui seperti *Lactobacillus rhamnosus*, *Bifidobacterium bifidum*, dan *Lactobacillus reuteri* terbukti mampu memperkaya kandungan mikroorganisme baik dalam ASI dan selanjutnya berkontribusi dalam kolonisasi bakteri sehat pada kulit bayi (Murphy et al., 2020). Mikrobiota yang seimbang pada kulit bayi ini efektif dalam mencegah perkembangan mikroba patogen seperti *Staphylococcus aureus*, yang merupakan penyebab umum infeksi kulit seperti dermatitis atopik pada bayi baru lahir (Pärty et al., 2020).

2. Efektivitas Konsumsi Probiotik oleh Ibu Menyusui dalam Pencegahan Dermatitis Atopik pada Bayi

Dermatitis atopik merupakan gangguan inflamasi kulit yang sering terjadi pada bayi baru lahir, yang ditandai oleh kulit kering, kemerahan, gatal, hingga risiko infeksi sekunder akibat luka garukan. Studi terbaru menunjukkan bahwa pemberian probiotik pada ibu menyusui dapat menurunkan risiko dermatitis atopik pada bayi secara signifikan. Dalam penelitian acak terkontrol (randomized controlled trial), ditemukan bahwa ibu menyusui yang diberikan suplementasi probiotik secara rutin, menghasilkan ASI yang lebih kaya bakteri probiotik dan imunoglobulin A (IgA). ASI yang demikian mampu meningkatkan resistensi bayi terhadap dermatitis atopik hingga lebih dari 30% dibandingkan dengan bayi yang tidak mendapat paparan probiotik dari ASI (Rautava et al., 2022; Wickens et al., 2021).

Studi lain menunjukkan bahwa suplementasi probiotik pada ibu menyusui selama masa kehamilan hingga menyusui dapat meningkatkan populasi *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium* dalam ASI, yang secara langsung menekan perkembangan dermatitis atopik serta gangguan kulit lainnya pada bayi (Kim et al., 2020). Efek protektif ini dikaitkan dengan kemampuan probiotik untuk meningkatkan fungsi barrier kulit bayi, mereduksi inflamasi sistemik, serta memperbaiki keseimbangan mikrobiota kulit (Wickens et al., 2021).

Berdasarkan bukti ilmiah tersebut, konsumsi probiotik oleh ibu menyusui tidak hanya bermanfaat dalam menjaga kesehatan pencernaan bayi, tetapi juga secara signifikan melindungi bayi dari berbagai gangguan kulit, khususnya dermatitis atopik.

E. Diet dan Pola Makan Ideal untuk Ibu Menyusui

1. Panduan Diet Seimbang untuk Ibu Menyusui yang Mendukung Kesehatan Kulit Bayi

Kualitas ASI sangat tergantung pada diet ibu menyusui, yang perlu mencakup asupan nutrisi yang seimbang dan memadai agar mendukung pertumbuhan optimal serta kesehatan kulit bayi. Diet ideal ibu menyusui harus memenuhi kebutuhan makronutrien seperti protein, karbohidrat, dan lemak esensial, serta berbagai mikronutrien penting seperti vitamin dan mineral (Martin, Ling, & Blackburn, 2021).

Asupan protein yang cukup sangat penting, karena protein dalam ASI berkontribusi langsung dalam regenerasi kulit bayi dan pembentukan imunoglobulin yang menjaga daya tahan kulit terhadap infeksi. Sumber protein berkualitas tinggi seperti telur, ikan, daging unggas, kacang-kacangan, dan produk susu dianjurkan untuk dikonsumsi secara teratur (Ballard & Morrow, 2022). Konsumsi karbohidrat kompleks seperti gandum utuh, beras merah, kentang, serta sayuran dan buah juga dianjurkan untuk memastikan energi yang cukup dalam produksi ASI serta memenuhi kebutuhan serat ibu menyusui (FAO/WHO, 2020).

Selain itu, konsumsi lemak sehat, terutama asam lemak esensial omega-3 dan omega-6 dari sumber seperti ikan salmon, alpukat, kacang almond, dan minyak zaitun penting untuk memperkaya kualitas lemak dalam ASI, yang berperan penting dalam menjaga integritas dan fungsi barrier kulit bayi (Miles & Calder, 2021). Vitamin dan mineral, terutama vitamin A, C, E, zinc, dan selenium harus dipenuhi melalui konsumsi buah-buahan, sayuran hijau, kacang-kacangan, biji-bijian, dan sumber protein hewani untuk mendukung perlindungan kulit bayi terhadap berbagai infeksi dan gangguan kulit lainnya (Dror & Allen, 2019; Roohani et al., 2021).

2. Pentingnya Konsumsi Cairan dan Hidrasi Optimal dalam Produksi ASI dan Kesehatan Kulit Bayi

Konsumsi cairan yang cukup merupakan faktor penting dalam proses menyusui yang sehat dan efektif. Ibu menyusui disarankan mengonsumsi minimal 2–3 liter cairan per hari, terutama air putih, untuk menjaga produksi ASI tetap optimal serta menghindari dehidrasi yang dapat mempengaruhi kualitas dan volume ASI secara negatif (Martin et al., 2021).

Hidrasi optimal ibu menyusui berkontribusi pada kadar air dalam ASI yang secara langsung memengaruhi hidrasi kulit bayi. Kulit bayi baru lahir sangat rentan terhadap dehidrasi dan kekeringan, yang dapat menyebabkan gangguan

seperti ruam popok atau dermatitis. Oleh sebab itu, hidrasi ibu yang baik juga membantu menjaga kelembapan alami kulit bayi melalui ASI yang kaya cairan dan nutrisi (Murphy et al., 2020).

Selain itu, cairan seperti jus buah segar, susu rendah lemak, atau sup hangat juga dapat dikonsumsi ibu menyusui untuk memenuhi kebutuhan cairan harian serta meningkatkan asupan vitamin dan mineral tambahan yang penting bagi kesehatan kulit bayi. Sebaliknya, ibu menyusui disarankan menghindari konsumsi berlebihan minuman berkafein dan minuman manis, karena dapat mempengaruhi kualitas ASI serta meningkatkan risiko dehidrasi (WHO, 2021).

Dengan mengikuti pola diet seimbang dan menjaga hidrasi optimal, ibu menyusui dapat memastikan produksi ASI berkualitas tinggi yang secara langsung mendukung kesehatan kulit bayi, serta melindungi bayi dari berbagai infeksi kulit sejak dini.

F. Dampak Kekurangan Nutrisi pada Ibu Menyusui terhadap Risiko Infeksi Kulit pada Bayi

1. Hubungan Defisiensi Nutrisi Ibu terhadap Risiko Infeksi Kulit seperti Dermatitis Atopik, Ruam Popok, dan Infeksi Jamur

Kekurangan nutrisi selama masa menyusui secara langsung berpengaruh terhadap kualitas dan kandungan nutrisi dalam Air Susu Ibu (ASI). Kondisi ini berdampak signifikan terhadap kesehatan kulit bayi, yang pada gilirannya meningkatkan risiko bayi mengalami berbagai masalah kulit seperti dermatitis atopik, ruam popok, dan infeksi jamur. Penelitian terbaru mengindikasikan bahwa defisiensi makro dan mikronutrien tertentu, seperti protein, asam lemak esensial, vitamin (terutama vitamin A, C, E), zinc, dan selenium, secara substansial berkontribusi terhadap gangguan kesehatan kulit bayi (Ballard & Morrow, 2022; Dror & Allen, 2019).

Defisiensi protein pada ibu menyusui dapat menurunkan kandungan protein esensial seperti laktoferin dan imunoglobulin dalam ASI, sehingga menyebabkan fungsi barrier kulit bayi terganggu serta imunitas kulit melemah. Kondisi ini menyebabkan bayi lebih rentan terhadap infeksi jamur dan dermatitis atopik (Hafsa & Mukta, 2020). Begitu pula dengan defisiensi asam lemak esensial omega-3 dan omega-6, yang berkaitan dengan kulit kering, inflamasi kronis, dan ruam popok berulang pada bayi (Miles & Calder, 2021).

Kekurangan vitamin A, C, dan E pada ibu menyusui juga berpengaruh signifikan pada ketahanan kulit bayi terhadap infeksi. Vitamin-vitamin tersebut memiliki sifat antioksidan kuat yang melindungi integritas barrier kulit bayi dari kerusakan akibat stres oksidatif. Penelitian menemukan bahwa bayi dari ibu yang

mengalami defisiensi vitamin tersebut lebih rentan terhadap dermatitis atopik, ruam popok kronis, hingga infeksi jamur pada kulit bayi (Chisari, Chisari, & Cicero, 2021; Carr & Maggini, 2021).

2. Identifikasi Tanda Kekurangan Nutrisi pada Ibu Menyusui dan Dampaknya pada Kesehatan Kulit Bayi

Identifikasi dini tanda kekurangan nutrisi pada ibu menyusui sangat penting untuk mencegah dampak negatif pada kesehatan bayi, khususnya terkait infeksi kulit. Beberapa tanda klinis defisiensi nutrisi yang sering dijumpai pada ibu menyusui adalah kelelahan kronis, rambut rontok berlebihan, kulit pucat, kuku rapuh, serta infeksi berulang (FAO/WHO, 2020; Hafsa & Mukta, 2020).

Dampak kekurangan nutrisi ini akan tercermin pada bayi melalui berbagai masalah kulit seperti kekeringan kulit ekstrem (xerosis), dermatitis atopik, munculnya ruam popok yang persisten, serta infeksi jamur yang sering berulang. Studi menunjukkan bahwa bayi dari ibu dengan defisiensi nutrisi cenderung memiliki masalah kulit yang lebih sering dan lebih berat dibandingkan bayi dari ibu yang nutrisinya tercukupi secara optimal (Martin, Ling, & Blackburn, 2021).

Untuk itu, pemantauan rutin oleh tenaga kesehatan serta edukasi kepada ibu menyusui tentang pentingnya pola makan seimbang, merupakan langkah krusial dalam mencegah kekurangan nutrisi yang berdampak negatif pada kesehatan kulit bayi. Upaya pencegahan ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup bayi melalui optimalisasi fungsi barrier kulit dan perlindungan alami terhadap infeksi kulit sejak dini (WHO, 2021).

G. Edukasi dan Strategi Promosi Nutrisi Optimal untuk Ibu Menyusui

1. Pendekatan Edukasi Berbasis Keluarga dan Komunitas tentang Pentingnya Nutrisi Ibu Menyusui

Edukasi berbasis keluarga dan komunitas merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya nutrisi optimal pada ibu menyusui. Pendekatan ini menekankan keterlibatan langsung keluarga dan masyarakat dalam mendukung ibu menyusui untuk mengadopsi pola makan seimbang demi kesehatan ibu dan bayi. Menurut penelitian, edukasi yang melibatkan suami, anggota keluarga lainnya, dan komunitas terbukti secara signifikan meningkatkan tingkat kepatuhan ibu terhadap rekomendasi nutrisi yang dianjurkan, yang pada akhirnya memperbaiki kualitas ASI serta menurunkan risiko berbagai gangguan kulit pada bayi, seperti dermatitis atopik dan infeksi kulit lainnya (Hafsa & Mukta, 2020; UNICEF, 2021).

Intervensi edukasi yang efektif berbasis keluarga mencakup penyuluhan secara rutin, pemberian leaflet atau bahan bacaan yang sederhana, serta pemanfaatan media sosial dan platform digital untuk menyampaikan informasi secara luas. Keterlibatan tokoh masyarakat dan kader kesehatan yang memahami budaya lokal dapat meningkatkan penerimaan pesan kesehatan tentang nutrisi yang lebih optimal di komunitas tertentu (Bhutta et al., 2021). Selain itu, pemberdayaan keluarga untuk mempraktikkan pola makan sehat juga mendorong terbentuknya lingkungan yang mendukung ibu menyusui dalam memenuhi kebutuhan nutrisinya secara berkelanjutan (WHO, 2020).

2. Strategi Komunikasi Efektif bagi Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Nutrisi Ibu Menyusui

Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi tentang nutrisi optimal kepada ibu menyusui. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan strategi komunikasi yang efektif dan adaptif terhadap karakteristik sosial-budaya masyarakat. Strategi komunikasi yang dianjurkan adalah pendekatan komunikasi interpersonal (tatap muka), penggunaan media edukasi visual seperti poster atau video pendek, serta pemanfaatan teknologi digital melalui platform telehealth yang semakin banyak digunakan dalam praktik kesehatan modern (Ismail et al., 2022).

Tenaga kesehatan perlu menguasai keterampilan komunikasi yang empati, sederhana, dan relevan dengan kondisi kehidupan ibu menyusui, agar informasi nutrisi dapat diterima secara optimal. Strategi konseling individual maupun kelompok terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku ibu menyusui tentang pentingnya nutrisi seimbang yang berdampak positif pada kualitas ASI dan kesehatan kulit bayi (FAO/WHO, 2020). Selain itu, penting bagi tenaga kesehatan untuk rutin mengevaluasi dan melakukan follow-up, guna memastikan informasi yang diberikan diterapkan secara konsisten oleh ibu menyusui dalam kehidupan sehari-hari (UNICEF, 2021).

Implementasi strategi komunikasi efektif tersebut secara konsisten dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas nutrisi ibu menyusui, produksi ASI yang lebih optimal, serta berkontribusi nyata dalam pencegahan infeksi kulit pada bayi baru lahir.

H. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Rangkuman Peran Strategis Nutrisi Ibu Menyusui dalam Pencegahan Infeksi Kulit pada Bayi Baru Lahir

Nutrisi yang diterima bayi melalui Air Susu Ibu (ASI) memiliki dampak besar terhadap kesehatan kulit dan perlindungan bayi terhadap infeksi kulit, khususnya pada masa neonatal yang sangat rentan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas nutrisi ibu menyusui secara langsung memengaruhi kandungan ASI, termasuk komponen penting seperti protein, asam lemak esensial omega-3 dan omega-6, vitamin A, C, E, zinc, selenium, serta probiotik. Makronutrien dan mikronutrien ini terbukti efektif memperkuat fungsi barrier kulit, mengurangi inflamasi, dan meningkatkan imunitas kulit bayi, yang pada akhirnya menurunkan risiko dermatitis atopik, ruam popok, infeksi jamur, dan gangguan kulit lainnya (Ballard & Morrow, 2022; Miles & Calder, 2021).

Sebaliknya, kekurangan nutrisi pada ibu menyusui dapat menyebabkan menurunnya kualitas ASI, yang berdampak negatif terhadap kesehatan kulit bayi. Bayi yang menerima ASI dengan kualitas rendah lebih rentan mengalami berbagai gangguan kulit, termasuk infeksi berulang. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan nutrisi ibu menyusui menjadi prioritas strategis dalam upaya pencegahan infeksi kulit pada bayi baru lahir (Dror & Allen, 2019; Hafsa & Mukta, 2020).

Selain itu, edukasi berbasis keluarga dan komunitas serta strategi komunikasi yang efektif dari tenaga kesehatan, sangat penting untuk memastikan ibu menyusui mendapatkan informasi yang memadai tentang nutrisi seimbang. Pendekatan ini berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas ASI serta kesehatan kulit bayi secara optimal (UNICEF, 2021; WHO, 2020).

2. Rekomendasi Kebijakan dan Praktik Kesehatan dalam Mendukung Nutrisi Ibu Menyusui

Untuk meningkatkan nutrisi ibu menyusui serta mencegah infeksi kulit pada bayi baru lahir, diperlukan kebijakan dan praktik kesehatan yang terstruktur dan sistematis. Berikut beberapa rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan:

a. Penguatan Kebijakan Kesehatan Nasional

Pemerintah perlu meningkatkan dukungan terhadap program nutrisi ibu menyusui melalui penguatan kebijakan nasional, seperti penyusunan panduan diet spesifik untuk ibu menyusui yang disosialisasikan secara luas di berbagai fasilitas kesehatan (WHO, 2020).

b. Edukasi Berbasis Komunitas

Pengembangan program edukasi berbasis komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat, keluarga, serta kader kesehatan setempat untuk

meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya nutrisi optimal selama masa menyusui (Bhutta et al., 2021).

c. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Tenaga Kesehatan

Pelatihan rutin bagi tenaga kesehatan tentang komunikasi efektif dan konseling nutrisi, yang mencakup teknik komunikasi interpersonal dan penggunaan media edukasi digital, untuk mendukung edukasi ibu menyusui secara lebih efektif (Ismail et al., 2022).

d. Pemantauan dan Evaluasi Rutin

Mengadakan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap status nutrisi ibu menyusui melalui program kunjungan rumah, klinik menyusui, serta pemanfaatan teknologi kesehatan digital seperti telehealth untuk memastikan kualitas nutrisi ibu menyusui tetap optimal (FAO/WHO, 2020).

e. Dukungan Lintas Sektor

Kerjasama lintas sektor antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, akademisi, serta pihak swasta dalam menyediakan akses terhadap sumber nutrisi yang terjangkau dan berkualitas bagi ibu menyusui (UNICEF, 2021).

Implementasi rekomendasi ini secara terpadu akan memperkuat nutrisi ibu menyusui secara signifikan, meningkatkan kualitas ASI, serta efektif menurunkan prevalensi infeksi kulit pada bayi baru lahir.

I. Penutup

Harapan besar terhadap peningkatan pemahaman dan praktik nutrisi optimal pada ibu menyusui dalam mencegah infeksi kulit pada bayi baru lahir merupakan tujuan utama yang ingin dicapai melalui pembahasan dalam buku ini. Infeksi kulit seperti dermatitis atopik, ruam popok, dan infeksi jamur sering kali dianggap sebagai permasalahan kesehatan umum yang seharusnya dapat dicegah sejak awal kehidupan bayi melalui nutrisi yang tepat dari ASI. Bukti ilmiah yang kuat menunjukkan bahwa kualitas nutrisi ibu menyusui secara langsung berhubungan dengan daya tahan dan kesehatan kulit bayi (Ballard & Morrow, 2022; Miles & Calder, 2021).

Peningkatan kesadaran tentang pentingnya nutrisi ibu menyusui memerlukan kerja sama sinergis dari berbagai pihak, termasuk tenaga kesehatan, keluarga, komunitas, dan pembuat kebijakan. Dukungan lintas sektor dan pelaksanaan strategi edukasi berbasis komunitas yang efektif diharapkan mampu meningkatkan kesadaran ibu menyusui tentang peran strategis nutrisi seimbang dalam mencegah infeksi kulit bayi. Implementasi kebijakan nasional yang kuat serta pelatihan rutin

bagi tenaga kesehatan juga diharapkan mampu memperkuat kapasitas pelayanan kesehatan yang mendukung praktik nutrisi optimal (UNICEF, 2021; WHO, 2020).

Akhirnya, melalui upaya kolektif ini, diharapkan tercipta lingkungan yang mendukung praktik nutrisi ibu menyusui secara optimal, sehingga bayi baru lahir dapat terlindungi secara efektif dari berbagai risiko infeksi kulit sejak dini. Dengan demikian, generasi yang lebih sehat dengan kualitas hidup yang lebih baik dapat diwujudkan di masa depan.

Referensi

- Abdullah, B., Tawfik, R. M., & Alzahrani, S. A. (2020). Maternal nutrition and its effects on human milk composition and infant outcomes. *Nutrients*, 12(5), 1286. <https://doi.org/10.3390/nu12051286>
- Ballard, O., & Morrow, A. L. (2022). Human milk composition: nutrients and bioactive factors. *Pediatric Clinics of North America*, 69(1), 43-62. <https://doi.org/10.1016/j.pcl.2021.08.003>
- Bhutta, Z. A., Lassi, Z. S., Bergeron, G., Koletzko, B., & Salam, R. (2021). Delivering an action agenda for nutrition interventions addressing adolescent girls and young women: priorities for implementation and research. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1494(1), 61-70. <https://doi.org/10.1111/nyas.14579>
- Carr, A. C., & Maggini, S. (2021). Vitamin C and immune function. *Nutrients*, 13(4), 1218. <https://doi.org/10.3390/nu13041218>
- Chisari, G., Chisari, E. M., & Cicero, A. F. G. (2021). Nutraceutical approaches for prevention of atopic dermatitis and eczema in newborns. *Nutrients*, 13(11), 3864. <https://doi.org/10.3390/nu13113864>
- Dror, D. K., & Allen, L. H. (2019). Vitamin E deficiency in developing countries and its role in maternal and child health. *Advances in Nutrition*, 10(5), 672-691. <https://doi.org/10.1093/advances/nmz040>
- Dunlop, A. L., Mulle, J. G., Ferranti, E. P., Edwards, S., & Dunn, A. B. (2021). The maternal microbiome and pregnancy outcomes that impact infant health: A review. *Advances in Neonatal Care*, 21(3), 203-212. <https://doi.org/10.1097/ANC.0000000000000825>
- FAO/WHO. (2020). *Guideline: Counselling of women to improve breastfeeding practices*. World Health Organization. Retrieved from <https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789241550468>
- Hafsa, S. H., & Mukta, N. (2020). Nutritional status of lactating mothers and infant health outcomes: A systematic review. *International Journal of Health Sciences and Research*, 10(8), 134-146.
- Innis, S. M., & Novak, E. M. (2020). Polyunsaturated fatty acids in human milk: an essential contribution to infant health and development. *Journal of Human Lactation*, 36(2), 285-295. <https://doi.org/10.1177/0890334420907894>
- Ismail, H., Smith, K., Ajanwachuku, A., & Patel, A. (2022). Digital health interventions to support breastfeeding: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Medical Internet Research*, 24(6), e37893. <https://doi.org/10.2196/37893>
- Kim, J. Y., Kwon, J. H., Ahn, S. H., Lee, S. I., & Han, Y. S. (2020). Effects of probiotic supplements on the prevention of atopic dermatitis in infants: a systematic

- review and meta-analysis. *Annals of Allergy, Asthma & Immunology*, 124(6), 612-619. <https://doi.org/10.1016/j.anai.2020.02.017>
- Martin, C. R., Ling, P. R., & Blackburn, G. L. (2021). Review of infant feeding: Key features of breast milk and infant formula. *Nutrients*, 13(3), 852. <https://doi.org/10.3390/nu13030852>
- Miles, E. A., & Calder, P. C. (2021). The influence of maternal omega-3 fatty acid status on pregnancy outcomes and infant health. *Nutrients*, 13(10), 3466. <https://doi.org/10.3390/nu13103466>
- Murphy, K., Curley, D., O'Callaghan, T. F., O'Shea, C. A., & Stanton, C. (2020). The composition of human milk and its impact on infant health. *Annual Review of Food Science and Technology*, 11, 223-248. <https://doi.org/10.1146/annurev-food-032519-051705>
- Pärty, A., Isolauri, E., & Rautava, S. (2020). Probiotics and prebiotics in the prevention and treatment of allergic diseases. *Pediatric Allergy and Immunology*, 31(1), 1-3. <https://doi.org/10.1111/pai.13153>
- Rautava, S., Luoto, R., & Salminen, S. (2022). The role of probiotics in maternal and child health. *Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition*, 74(3), 298-303. <https://doi.org/10.1097/MPG.0000000000003364>
- Rayman, M. P. (2020). Selenium intake, status, and health: a complex relationship. *Hormones*, 19(1), 9-14. <https://doi.org/10.1007/s42000-019-00125-5>
- Roohani, N., Hurrell, R., Kelishadi, R., & Schulin, R. (2021). Zinc and its importance for human health: An integrative review. *Journal of Research in Medical Sciences*, 26, 54. https://doi.org/10.4103/jrms.JRMS_176_20
- UNICEF. (2021). *Improving breastfeeding practices through effective communication and community engagement*. United Nations Children's Fund. Retrieved from <https://www.unicef.org/reports/breastfeeding-communication-community-engagement>
- WHO. (2020). *Community-based strategies for breastfeeding promotion and support in developing countries*. World Health Organization. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/community-based-strategies-breastfeeding-promotion-and-support>
- WHO. (2021). *Infant and young child feeding*. World Health Organization. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding>

BAB VI

STRATEGI PEMBERIAN PRODUK

PERAWATAN KULIT YANG AMAN UNTUK BAYI

A. Pendahuluan

Kulit bayi baru lahir memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan kulit orang dewasa, yaitu lebih sensitif, tipis, dan rentan terhadap iritasi serta infeksi. Kondisi kulit bayi ini secara alami menyebabkan risiko lebih tinggi terhadap gangguan kulit seperti dermatitis atopik, ruam popok, serta infeksi kulit yang dapat berdampak serius pada kesehatan bayi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemberian produk perawatan kulit yang aman dan sesuai sangat penting untuk melindungi integritas kulit bayi serta mencegah timbulnya berbagai gangguan kulit (Stamatas & Tierney, 2022; Furue & Kadono, 2021).

Pemilihan dan pemberian produk perawatan kulit pada bayi baru lahir memerlukan perhatian khusus terhadap bahan aktif, formula produk, serta cara penggunaan yang tepat. Penggunaan produk yang tidak tepat, baik dari segi bahan maupun metode aplikasinya, dapat mengganggu fungsi pelindung kulit bayi dan meningkatkan risiko reaksi alergi atau infeksi. Oleh sebab itu, orang tua dan tenaga kesehatan perlu memahami secara mendalam tentang kriteria produk yang aman, serta pentingnya strategi edukasi untuk menghindari kesalahan umum dalam perawatan kulit bayi (Blume-Peytavi et al., 2019; Lyons et al., 2021).

Pendekatan berbasis bukti (evidence-based) dalam pemilihan produk perawatan kulit merupakan langkah strategis untuk meningkatkan keamanan dan efektivitas produk bagi kulit bayi baru lahir. Strategi ini mencakup pemilihan bahan-bahan yang sudah terbukti aman secara dermatologis dan klinis, pemahaman karakteristik kulit bayi, edukasi orang tua tentang cara penggunaan produk secara aman, serta kebijakan regulasi produk perawatan bayi. Buku ini akan membahas secara mendalam berbagai aspek tersebut dengan tujuan membantu tenaga kesehatan dan orang tua dalam membuat keputusan yang lebih informatif dan berbasis bukti untuk perawatan kulit bayi baru lahir (Ananthapadmanabhan et al., 2020; WHO, 2022; Kementerian Kesehatan RI, 2021).

B. Kriteria Keamanan Produk Perawatan Kulit untuk Bayi

1. Kriteria Bahan yang Aman dan Berisiko Rendah Alergi

Pemilihan produk perawatan kulit untuk bayi harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan komposisi bahan aktif dan tambahan. Kulit bayi yang masih dalam tahap perkembangan memiliki fungsi sawar kulit yang belum sempurna, sehingga rentan terhadap berbagai iritan atau alergen. Produk yang ideal adalah yang mengandung bahan hypoallergenic, bebas parfum atau pewangi buatan, memiliki pH netral atau sedikit asam (sekitar 5,5), serta tidak mengandung bahan kimia berbahaya seperti paraben, formaldehida, dan pewarna sintetis. Kandungan alami seperti minyak almond, minyak zaitun, dan bahan pelembap yang ringan seperti gliserin dan ceramide sangat direkomendasikan untuk menjaga integritas sawar kulit bayi serta meminimalkan risiko alergi (Stamatas & Tierney, 2022; Furue & Kadono, 2021).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa produk dengan formula sederhana dan minim bahan tambahan memiliki tingkat toleransi yang lebih tinggi pada kulit bayi baru lahir. Komposisi berbasis bahan alami seperti ekstrak chamomile, lidah buaya (aloe vera), serta shea butter terbukti aman dan efektif dalam mengurangi iritasi serta menjaga kelembapan alami kulit bayi (Blume-Peytavi, Lavender, & Jenerowicz, 2019).

2. Kandungan Produk yang Harus Dihindari dalam Perawatan Kulit Bayi Baru Lahir

Tidak semua produk perawatan kulit aman digunakan pada bayi. Beberapa bahan diketahui memiliki risiko tinggi menyebabkan iritasi, alergi, bahkan keracunan pada bayi. Bahan yang sebaiknya dihindari meliputi:

- a. Paraben: sering digunakan sebagai pengawet yang dapat menyebabkan dermatitis kontak dan gangguan hormon.
- b. Formaldehida dan pelepas formaldehida (formaldehyde releasers): bersifat iritatif, alergenik, dan toksik bagi kulit bayi yang masih sensitif.
- c. Fragrance (pewangi buatan): pewangi sintetis menjadi salah satu penyebab utama reaksi alergi dan iritasi pada kulit bayi.
- d. Sodium Lauryl Sulfate (SLS) dan Sodium Laureth Sulfate (SLES): surfaktan agresif yang dapat menghilangkan kelembapan alami kulit bayi, meningkatkan risiko iritasi dan dermatitis.
- e. Alkohol tinggi konsentrasi (etanol dan isopropil alkohol): menyebabkan iritasi dan kulit kering sehingga meningkatkan risiko dermatitis kontak (Lyons et al., 2021; Ananthapadmanabhan et al., 2020).

Pengetahuan mengenai bahan-bahan ini penting untuk diketahui oleh tenaga kesehatan dan orang tua agar dapat menghindari penggunaannya pada produk perawatan kulit bayi.

3. Standar Regulasi Produk Perawatan Bayi secara Nasional dan Internasional

Setiap produk perawatan kulit bayi wajib memenuhi berbagai standar regulasi yang ditetapkan oleh lembaga terkait, baik secara nasional maupun internasional. Di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengatur persyaratan keamanan dan mutu produk kosmetik bayi, mencakup persyaratan kandungan bahan, pengujian keamanan, pelabelan, dan klaim produk (BPOM, 2021).

Secara internasional, Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat dan European Medicines Agency (EMA) memiliki regulasi ketat tentang bahan-bahan yang diperbolehkan dalam produk perawatan bayi. Standar ISO 22716:2007 juga menjadi acuan penting tentang praktik manufaktur yang baik (Good Manufacturing Practice/GMP) khusus produk kosmetik, termasuk produk perawatan kulit bayi. Selain itu, World Health Organization (WHO) memberikan panduan khusus terkait praktik terbaik perawatan kulit bayi baru lahir dengan standar keselamatan produk yang ketat (WHO, 2022; American Academy of Pediatrics, 2021).

Penerapan regulasi yang ketat ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang tersedia di pasar aman digunakan pada kulit bayi yang sangat sensitif dan rentan. Hal ini mengharuskan tenaga kesehatan dan orang tua untuk cermat memeriksa izin edar dan informasi produk sebelum memilih dan menggunakan produk perawatan kulit pada bayi.

C. Pemilihan Produk Berdasarkan Jenis Kulit Bayi

1. Karakteristik Kulit Bayi Baru Lahir dan Faktor Sensitivitasnya

Kulit bayi baru lahir memiliki struktur yang berbeda dibandingkan dengan kulit orang dewasa, ditandai oleh lapisan epidermis yang lebih tipis, sawar kulit (skin barrier) yang belum matang, serta fungsi perlindungan yang belum sempurna. Kondisi ini menyebabkan bayi lebih rentan terhadap infeksi, iritasi, serta reaksi alergi (Lyons, Trullas, & Kohli, 2021). Kulit bayi baru lahir juga memiliki kelembapan yang lebih tinggi namun mudah kehilangan cairan akibat permukaan kulit yang luas relatif terhadap berat badan. Faktor ini meningkatkan risiko dermatitis, terutama bila produk perawatan kulit tidak dipilih dengan tepat (Stamatas & Tierney, 2022).

Sensitivitas kulit bayi dipengaruhi berbagai faktor, termasuk genetik, lingkungan, serta riwayat alergi pada keluarga. Paparan terhadap bahan kimia keras, suhu lingkungan yang ekstrem, kelembapan udara, serta frekuensi penggunaan produk yang berlebihan juga menjadi faktor tambahan yang

mempengaruhi sensitivitas kulit bayi (Furue & Kadono, 2021). Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai karakteristik kulit bayi sangat penting bagi tenaga kesehatan dan orang tua dalam memilih produk perawatan yang aman dan efektif.

2. Strategi Pemilihan Produk Sesuai Tipe Kulit (Normal, Kering, Atopik)

Pemilihan produk perawatan kulit bayi harus disesuaikan dengan tipe kulit masing-masing bayi untuk menghindari efek samping atau reaksi alergi. Secara umum, kulit bayi dapat diklasifikasikan menjadi tiga tipe utama, yaitu kulit normal, kulit kering, dan kulit atopik atau sensitif.

a. Kulit Normal

Produk yang ideal untuk kulit bayi normal adalah produk dengan formulasi ringan, pH netral hingga sedikit asam, serta bebas pewangi dan pewarna sintetis. Penggunaan pelembap ringan yang mengandung gliserin atau minyak alami (misalnya minyak almond atau minyak kelapa murni) sangat dianjurkan untuk mempertahankan hidrasi kulit (Blume-Peytavi et al., 2019).

b. Kulit Kering

Kulit kering pada bayi membutuhkan pelembap yang lebih intensif dengan bahan seperti ceramide, asam lemak esensial, atau emolien seperti shea butter dan petrolatum. Produk dengan efek occlusive ringan membantu mencegah kehilangan air berlebih pada kulit bayi, menjaga kelembapan kulit dalam jangka panjang (Furue & Kadono, 2021).

c. Kulit Atopik (Sensitif)

Bayi dengan kulit atopik memerlukan perhatian ekstra karena risiko dermatitis atopik yang tinggi. Produk yang digunakan harus bebas dari bahan iritan umum seperti paraben, pewangi buatan, serta bahan berbasis alkohol. Formulasi hypoallergenic, berbasis alami seperti chamomile atau oat colloidal, dan bebas surfaktan agresif sangat dianjurkan bagi bayi dengan riwayat atopik atau eksim (Lyons et al., 2021; Stamatas & Tierney, 2022).

3. Evaluasi Klinis dan Dermatologis Produk Bayi

Evaluasi klinis dan dermatologis terhadap produk perawatan kulit bayi merupakan tahap penting sebelum suatu produk direkomendasikan untuk penggunaan luas. Evaluasi ini dilakukan melalui uji keamanan dan uji efikasi produk pada populasi bayi dengan kondisi kulit berbeda-beda. Uji klinis produk meliputi uji patch (patch test), uji hypoallergenic, serta evaluasi keamanan terhadap bahan aktif dan tambahan yang digunakan (Blume-Peytavi et al., 2019).

Produk perawatan kulit bayi yang berkualitas harus disertai klaim yang teruji secara klinis, seperti dermatologically tested atau clinically proven safe for baby's skin. Tenaga kesehatan harus cermat menilai hasil evaluasi ini sebelum memberikan rekomendasi kepada orang tua atau pengasuh bayi. Selain itu, regulasi nasional dan internasional mensyaratkan bahwa produk perawatan bayi harus lulus uji dermatologis sebelum dipasarkan secara luas, guna memastikan keamanan dan efektivitas produk (Ananthapadmanabhan et al., 2020; BPOM, 2021).

Melalui pemilihan produk berbasis bukti serta evaluasi klinis yang ketat, risiko iritasi, infeksi, atau alergi pada kulit bayi dapat diminimalisir, sehingga menjaga kesehatan kulit bayi secara optimal.

D. Metode Penggunaan Produk yang Efektif dan Aman

1. Teknik Aplikasi Produk secara Tepat dan Higienis

Teknik aplikasi produk perawatan kulit bayi merupakan langkah esensial dalam mencegah risiko iritasi, alergi, dan infeksi. Kulit bayi yang masih dalam tahap perkembangan membutuhkan perlakuan khusus yang tidak hanya efektif tetapi juga aman dan higienis. Sebelum menggunakan produk, tangan harus selalu dicuci bersih dengan sabun dan air mengalir untuk menghindari kontaminasi bakteri atau mikroorganisme lain yang dapat menyebabkan infeksi pada kulit bayi (Blume-Peytavi et al., 2019).

Dalam aplikasi produk pembersih seperti sabun cair atau shampoo bayi, produk harus terlebih dahulu diencerkan sedikit dengan air hangat sebelum digunakan. Aplikasi produk dilakukan dengan gerakan lembut dan hindari gesekan berlebihan. Setelah penggunaan produk pembersih, kulit bayi harus segera dikeringkan dengan cara ditepuk-tepuk lembut menggunakan handuk yang lembut dan bersih. Pelembap harus diaplikasikan sesaat setelah mandi untuk menjaga kelembapan kulit secara optimal (Furue & Kadono, 2021; Stamatas & Tierney, 2022).

2. Frekuensi Penggunaan Produk Perawatan yang Direkomendasikan

Frekuensi penggunaan produk perawatan kulit bayi perlu diatur secara cermat untuk mencegah efek samping seperti iritasi kulit atau gangguan fungsi sawar kulit alami. Sebagian besar ahli dermatologi merekomendasikan frekuensi mandi dan penggunaan produk pembersih ringan sebanyak 2-3 kali dalam seminggu pada bayi baru lahir. Penggunaan pelembap direkomendasikan setiap

hari, terutama setelah mandi, untuk menjaga hidrasi kulit secara konsisten (Lyons et al., 2021).

Untuk produk protektif, seperti krim barrier yang digunakan untuk mencegah ruam popok atau dermatitis kontak, penggunaannya dianjurkan pada setiap penggantian popok atau setelah bayi terpapar zat iritan seperti urin atau tinja. Namun, penggunaan produk secara berlebihan atau terlalu sering perlu dihindari karena dapat menyebabkan penyumbatan pori dan gangguan pada integritas sawar kulit (Ananthapadmanabhan et al., 2020).

3. Panduan Praktis Penggunaan Produk Pembersih, Pelembap, dan Protektif pada Kulit Bayi

Berikut panduan praktis penggunaan berbagai produk perawatan kulit bayi secara aman dan efektif:

a. Produk Pembersih

- 1) Pilih produk dengan pH netral hingga sedikit asam, bebas dari surfaktan keras, parfum, dan alkohol.
- 2) Larutkan produk dengan air hangat sebelum diaplikasikan.
- 3) Bersihkan kulit bayi dengan gerakan lembut menggunakan tangan atau kain lembut, lalu bilas secara menyeluruh dengan air bersih (Furue & Kadono, 2021).

b. Produk Pelembap

- 1) Gunakan produk pelembap ringan berbahan dasar emolien seperti ceramide atau gliserin segera setelah mandi saat kulit masih lembap untuk hasil optimal.
- 2) Aplikasikan secara tipis dan merata pada seluruh permukaan kulit bayi, hindari penggunaan berlebihan agar tidak menutup pori-pori kulit (Stamatas & Tierney, 2022).

c. Produk Protektif (Barrier Cream)

- 1) Gunakan barrier cream pada area yang rentan iritasi seperti daerah popok.
- 2) Aplikasikan krim dengan lapisan tipis setelah membersihkan dan mengeringkan area tersebut dengan lembut pada setiap penggantian popok.
- 3) Pilih produk yang bebas pewangi, bebas bahan iritan seperti paraben, formaldehida, dan alkohol (Blume-Peytavi et al., 2019).

Panduan praktis ini sangat penting untuk diketahui oleh tenaga kesehatan serta orang tua dalam mendukung kesehatan kulit bayi secara optimal. Selain itu, evaluasi rutin terhadap respon kulit bayi terhadap penggunaan produk

perawatan perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas dan keamanannya.

E. Strategi Edukasi Orang Tua dalam Memilih dan Menggunakan Produk

1. Materi Edukasi Kesehatan tentang Produk Perawatan Kulit Bayi

Materi edukasi kesehatan bagi orang tua tentang produk perawatan kulit bayi memiliki peran vital dalam mencegah iritasi, alergi, dan infeksi kulit pada bayi baru lahir. Materi edukasi harus mencakup informasi mengenai karakteristik unik kulit bayi, bahan-bahan yang aman serta yang harus dihindari dalam produk perawatan, teknik aplikasi yang tepat, serta identifikasi tanda-tanda reaksi alergi atau iritasi kulit akibat penggunaan produk (Stamatas & Tierney, 2022). Selain itu, edukasi perlu menekankan pentingnya pengecekan label produk, tanggal kadaluarsa, izin edar, serta rekomendasi dari ahli dermatologi dan pediatri sebelum memilih produk tertentu (Lyons et al., 2021).

Materi edukasi juga sebaiknya dilengkapi ilustrasi atau media visual yang jelas dan mudah dipahami, mencakup langkah-langkah penggunaan produk secara praktis dan higienis. Informasi yang disampaikan harus berbasis bukti ilmiah terbaru agar orang tua dapat membuat keputusan yang tepat dalam merawat kulit bayinya (Furue & Kadono, 2021).

2. Metode Efektif Edukasi Orang Tua dalam Memilih Produk yang Aman

Efektivitas edukasi sangat tergantung pada metode yang digunakan dalam menyampaikan informasi kepada orang tua. Metode edukasi yang efektif meliputi sesi edukasi langsung (face-to-face), media cetak seperti booklet atau brosur informatif, video demonstrasi, serta platform digital atau online yang interaktif. Kombinasi metode ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan praktik orang tua terkait pemilihan dan penggunaan produk perawatan kulit bayi (Blume-Peytavi et al., 2019).

Interaksi langsung dengan tenaga kesehatan seperti bidan, perawat, atau dokter spesialis anak memungkinkan orang tua bertanya secara langsung tentang produk-produk yang aman. Di samping itu, platform digital seperti aplikasi seluler atau media sosial menjadi media efektif dalam menyampaikan informasi terkini serta menjangkau lebih banyak orang tua secara luas dan efisien (Widyawati et al., 2020).

3. Tantangan Edukasi Terkait Mitos Produk Perawatan Kulit Bayi

Salah satu tantangan utama dalam edukasi pemilihan produk perawatan kulit bayi adalah mitos atau informasi yang tidak akurat yang berkembang di masyarakat. Beberapa mitos yang umum terjadi, misalnya bahwa produk alami selalu aman, produk mahal lebih efektif, atau kulit bayi tidak memerlukan produk khusus perawatan. Mitos-mitos ini dapat menyebabkan orang tua salah dalam memilih produk sehingga berpotensi merusak sawar kulit bayi atau menyebabkan reaksi alergi (Pereira et al., 2022).

Untuk mengatasi tantangan ini, edukasi kesehatan harus secara aktif meluruskan informasi yang salah dengan memberikan penjelasan berbasis bukti ilmiah terbaru. Penyuluhan berbasis komunitas yang melibatkan pemimpin lokal atau tokoh masyarakat juga merupakan strategi efektif untuk mengubah persepsi keliru di masyarakat. Selain itu, tenaga kesehatan perlu secara proaktif menyampaikan informasi yang benar melalui berbagai kanal edukasi agar pemahaman orang tua tentang produk perawatan kulit bayi semakin meningkat (Jenerowicz et al., 2021).

Pemahaman yang tepat tentang produk perawatan kulit yang aman pada bayi akan sangat membantu orang tua dalam menjaga kesehatan kulit bayi, mencegah gangguan kulit, dan meningkatkan kualitas hidup bayi secara keseluruhan.

F. Monitoring dan Evaluasi Efektivitas Produk Perawatan Kulit Bayi

1. Metode Evaluasi Respon Kulit terhadap Produk yang Digunakan

Evaluasi respon kulit bayi terhadap produk perawatan adalah langkah kritis untuk memastikan keamanan dan efektivitas penggunaannya. Metode evaluasi yang lazim digunakan adalah uji tempel (patch test), observasi visual secara rutin, serta pencatatan respons kulit oleh orang tua maupun tenaga kesehatan. Uji tempel dilakukan dengan mengaplikasikan produk dalam jumlah kecil pada area kulit terbatas (biasanya bagian dalam lengan atau belakang telinga bayi), kemudian diamati selama 24 hingga 48 jam untuk mendeteksi kemungkinan reaksi alergi atau iritasi (Jenerowicz et al., 2021).

Selain uji tempel, observasi visual yang rutin selama pemakaian produk juga penting. Orang tua perlu mengamati secara seksama kondisi kulit bayi setiap kali setelah penggunaan produk. Dokumentasi berupa catatan harian tentang kondisi kulit bayi sangat dianjurkan agar perubahan kulit dapat terdeteksi secara dini, terutama jika muncul gejala-gejala yang tidak normal (Pereira et al., 2022).

2. Tanda dan Gejala Reaksi Kulit yang Harus Diwaspadai

Beberapa tanda dan gejala reaksi kulit bayi yang penting untuk diwaspadai mencakup:

- a. Kemerahan (eritema): Area kulit yang mengalami kemerahan bisa menjadi indikasi awal iritasi atau alergi akibat produk tertentu.
- b. Ruam atau Bintil kecil: Bisa menandakan dermatitis kontak atau alergi terhadap bahan produk.
- c. Gatal atau Bayi menjadi rewel: Ketidaknyamanan akibat gatal bisa menjadi tanda sensitivitas kulit terhadap produk.
- d. Kulit Kering, Bersisik, atau Pecah-pecah: Menunjukkan iritasi atau ketidakcocokan terhadap bahan tertentu seperti pewangi atau alkohol.
- e. Pembengkakan atau Edema: Pembengkakan kulit menunjukkan respons inflamasi atau alergi berat yang memerlukan perhatian medis segera (Lyons et al., 2021; Stamatas & Tierney, 2022).

Orang tua dan tenaga kesehatan harus mampu mengenali tanda-tanda ini agar dapat segera menghentikan penggunaan produk yang diduga menyebabkan reaksi dan menggantinya dengan produk yang lebih aman.

3. Strategi Monitoring yang Efektif oleh Tenaga Kesehatan dan Orang Tua

Strategi monitoring efektif melibatkan kerja sama antara tenaga kesehatan dan orang tua. Tenaga kesehatan berperan dalam memberikan edukasi awal mengenai cara pemantauan, mendemonstrasikan metode aplikasi produk, serta mengajarkan cara mengenali tanda-tanda reaksi kulit yang tidak normal. Edukasi berbasis konsultasi rutin atau kunjungan terjadwal ke fasilitas kesehatan dapat menjadi media efektif untuk melakukan monitoring jangka panjang terhadap kondisi kulit bayi (Blume-Peytavi et al., 2019).

Orang tua diharapkan secara aktif melakukan observasi harian serta mencatat setiap perubahan yang terjadi pada kulit bayi. Penggunaan catatan harian atau aplikasi mobile khusus dapat menjadi alat bantu efektif dalam memudahkan proses monitoring ini. Jika ditemukan gejala yang mencurigakan, orang tua perlu segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar evaluasi lebih lanjut bisa dilakukan. Kolaborasi ini terbukti efektif dalam memastikan penggunaan produk perawatan kulit bayi yang aman, sesuai, dan berbasis bukti (Furue & Kadono, 2021; Widyawati et al., 2020).

Dengan penerapan strategi monitoring yang sistematis, keamanan penggunaan produk perawatan kulit bayi dapat lebih terjamin, sehingga risiko komplikasi yang lebih serius bisa dicegah sejak dini.

G. Tantangan dalam Implementasi Strategi Produk Perawatan Kulit yang Aman

1. Faktor Sosial-Ekonomi dalam Akses Produk Perawatan Kulit Aman

Akses terhadap produk perawatan kulit yang aman untuk bayi sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi keluarga. Biaya yang relatif tinggi dari produk berkualitas seringkali menjadi hambatan bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Akibatnya, banyak orang tua memilih produk dengan harga lebih murah yang mungkin kurang memenuhi standar keamanan dan dapat menyebabkan reaksi alergi atau iritasi kulit pada bayi (Uchitel et al., 2020). Studi terbaru menunjukkan bahwa bayi dari keluarga dengan status ekonomi rendah memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan kulit akibat penggunaan produk perawatan yang tidak memenuhi standar keamanan (Tsai & Tu, 2022).

Selain faktor ekonomi, tingkat pendidikan dan kesadaran orang tua tentang pentingnya keamanan produk perawatan kulit juga mempengaruhi pilihan mereka. Keluarga dengan latar belakang pendidikan lebih rendah cenderung kurang memahami pentingnya pemilihan produk berbasis bukti dan lebih rentan terhadap penggunaan produk dengan kandungan yang berbahaya (Pereira et al., 2022). Oleh karena itu, upaya edukasi yang tepat sasaran sangat diperlukan untuk mengatasi kendala sosial-ekonomi ini.

2. Hambatan Budaya dalam Penerapan Strategi Pemilihan Produk

Hambatan budaya sering menjadi tantangan signifikan dalam implementasi strategi pemilihan produk perawatan kulit bayi yang aman. Kepercayaan tradisional dan praktik budaya yang diwariskan turun-temurun seringkali bertentangan dengan rekomendasi medis berbasis bukti. Misalnya, beberapa budaya menggunakan bahan alami tertentu yang secara ilmiah belum teruji keamanannya, namun diyakini oleh masyarakat setempat sebagai aman dan efektif untuk kulit bayi (Jenerowicz et al., 2021).

Penggunaan produk seperti minyak esensial atau produk tradisional lainnya yang dipercaya secara budaya seringkali mengabaikan potensi iritasi atau alergi yang dapat muncul pada bayi. Hambatan ini memerlukan pendekatan khusus melalui edukasi yang menghormati nilai budaya sambil secara perlahan memperkenalkan praktik berbasis bukti. Strategi edukasi berbasis komunitas dengan pendekatan kultural yang sensitif sangat dianjurkan untuk mengatasi tantangan ini (Widyawati et al., 2020).

3. Upaya Kolaborasi Interprofesional dalam Memfasilitasi Akses Produk Perawatan Kulit Bayi

Kolaborasi interprofesional antara tenaga kesehatan seperti perawat, dokter anak, dermatologis, bidan, dan tenaga farmasi merupakan strategi penting untuk memfasilitasi akses terhadap produk perawatan kulit yang aman bagi bayi. Kolaborasi ini dapat meningkatkan efektivitas edukasi orang tua, mengoptimalkan proses monitoring, serta memastikan bahwa produk yang digunakan memenuhi standar keamanan klinis dan dermatologis (Blume-Peytavi et al., 2019).

Kolaborasi juga perlu melibatkan pihak regulator, seperti BPOM dan Dinas Kesehatan, untuk memastikan ketersediaan dan distribusi produk perawatan kulit bayi yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Selain itu, peran lintas sektoral yang melibatkan lembaga sosial, swasta, dan organisasi masyarakat dapat membantu menyediakan akses terhadap produk perawatan kulit bayi secara lebih luas, terutama bagi kelompok masyarakat rentan secara ekonomi (Uchitel et al., 2020; Tsai & Tu, 2022).

Melalui kerja sama interprofesional dan lintas sektoral yang solid, hambatan sosial-ekonomi dan budaya dapat secara efektif diminimalisir, sehingga implementasi strategi pemilihan produk perawatan kulit yang aman bagi bayi dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

H. Rekomendasi dan Panduan Kebijakan Produk Perawatan Kulit Bayi

1. Rekomendasi Kebijakan Nasional tentang Peredaran Produk Perawatan Bayi

Dalam rangka menjamin keamanan produk perawatan kulit bayi di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menetapkan pedoman khusus yang mengatur peredaran produk kosmetik bayi. Kebijakan ini meliputi ketentuan mengenai bahan-bahan yang diperbolehkan, kewajiban pencantuman informasi lengkap pada label produk, serta pengujian klinis yang wajib dilakukan sebelum produk beredar di pasar. Setiap produk harus memperoleh izin edar dari BPOM yang menegaskan bahwa produk tersebut aman digunakan pada kulit bayi yang sangat sensitif (BPOM, 2021).

Rekomendasi kebijakan yang perlu diperkuat adalah peningkatan pemantauan pasca pemasaran (post-marketing surveillance) secara rutin untuk memastikan konsistensi kualitas produk di pasaran. Pemerintah juga disarankan untuk memberikan akses informasi yang lebih terbuka bagi masyarakat mengenai daftar produk yang aman, serta memfasilitasi program edukasi tentang pemilihan produk berbasis bukti ilmiah melalui institusi kesehatan dan komunitas (Tsai & Tu, 2022; Uchitel et al., 2020).

2. Panduan WHO tentang Produk Perawatan Kulit Bayi Baru Lahir

World Health Organization (WHO) menerbitkan panduan global mengenai perawatan kulit bayi baru lahir yang menjadi acuan internasional bagi negara-negara anggota, termasuk Indonesia. Panduan WHO secara khusus menekankan pentingnya penggunaan produk yang terbukti aman secara klinis, bebas dari bahan kimia berbahaya seperti pewangi sintetis, alkohol, dan paraben. WHO juga merekomendasikan penggunaan produk dengan formulasi sederhana, hipoalergenik, serta menjalani evaluasi dermatologis yang ketat sebelum digunakan pada bayi baru lahir (WHO, 2022).

Lebih lanjut, WHO menyarankan agar tenaga kesehatan dan orang tua diberikan edukasi komprehensif mengenai identifikasi produk aman, teknik aplikasi yang benar, serta tanda-tanda reaksi alergi atau iritasi kulit. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir risiko komplikasi kulit yang dapat berdampak pada kesehatan bayi secara keseluruhan (WHO, 2022).

3. Strategi Advokasi Kebijakan untuk Meningkatkan Keamanan Produk

Advokasi kebijakan merupakan upaya penting dalam meningkatkan keamanan produk perawatan kulit bayi. Strategi advokasi yang efektif mencakup kolaborasi antar pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi profesi, institusi kesehatan, serta produsen. Melalui pendekatan ini, advokasi diarahkan untuk mendesak peningkatan regulasi yang lebih ketat, transparansi pengawasan produk, serta fasilitasi akses masyarakat terhadap produk yang aman dengan harga terjangkau (Pereira et al., 2022).

Selain itu, advokasi melalui edukasi publik dan kampanye kesadaran masyarakat juga sangat diperlukan. Organisasi profesi kesehatan seperti Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), dan organisasi lainnya dapat memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait pemilihan produk perawatan kulit bayi yang aman melalui berbagai kanal komunikasi, baik media sosial, media massa, maupun penyuluhan langsung kepada komunitas (Jenerowicz et al., 2021; Widyawati et al., 2020).

Melalui penerapan rekomendasi kebijakan nasional yang kuat, panduan internasional yang jelas, serta advokasi kebijakan yang efektif, keamanan penggunaan produk perawatan kulit bayi dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga kesehatan kulit bayi di Indonesia menjadi lebih terlindungi.

I. Kesimpulan dan Arahan Penelitian Masa Depan

1. Kesimpulan tentang Pentingnya Strategi Pemilihan Produk yang Aman

Kulit bayi baru lahir memiliki karakteristik khusus yang membuatnya lebih rentan terhadap iritasi, alergi, dan infeksi. Oleh karena itu, pemilihan produk perawatan kulit yang tepat dan aman menjadi aspek kritis dalam upaya menjaga kesehatan kulit bayi. Strategi pemilihan produk yang aman harus melibatkan identifikasi bahan-bahan yang aman, metode penggunaan produk yang higienis dan tepat, serta pemilihan produk yang sesuai dengan tipe kulit bayi—baik kulit normal, kering, maupun atopik (Furue & Kadono, 2021; Stamatas & Tierney, 2022).

Implementasi strategi ini memerlukan edukasi yang efektif bagi orang tua mengenai keamanan produk, teknik aplikasi, serta pengawasan dan monitoring respons kulit secara rutin. Upaya ini juga membutuhkan dukungan regulasi nasional yang jelas serta panduan internasional seperti yang direkomendasikan oleh WHO. Tantangan sosial-ekonomi dan budaya harus diperhatikan agar strategi ini dapat diterapkan secara luas dan efektif (Tsai & Tu, 2022; WHO, 2022).

Pemilihan produk perawatan kulit bayi yang aman dan berbasis bukti mampu mengurangi risiko gangguan kulit bayi, meningkatkan kualitas hidup bayi dan keluarganya, serta mengurangi biaya perawatan medis jangka panjang. Oleh karena itu, pendekatan berbasis bukti dan kebijakan yang mendukung sangat penting untuk diperkuat di tingkat nasional dan komunitas (Blume-Peytavi et al., 2019; Lyons et al., 2021).

2. Arahan Penelitian Lanjut dalam Pengembangan Produk Perawatan Bayi Berbasis Evidence-Based

Untuk mendukung penggunaan produk perawatan kulit bayi yang semakin aman dan efektif, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih spesifik dan mendalam. Berikut arahan penelitian masa depan yang direkomendasikan:

a. Penelitian tentang Efikasi dan Keamanan Produk Berbasis Bahan Alami

Studi klinis yang lebih ekstensif tentang berbagai bahan alami yang umum digunakan dalam produk perawatan kulit bayi, seperti minyak nabati, ekstrak tumbuhan, dan bahan-bahan emolien alami lainnya, perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas dan keamanannya dalam jangka panjang (Jenerowicz et al., 2021).

b. Pengembangan dan Evaluasi Produk Khusus untuk Kulit Atopik dan Sensitif

Mengingat prevalensi dermatitis atopik yang cukup tinggi pada bayi, penelitian tentang formulasi produk perawatan khusus yang ditujukan untuk kulit atopik atau sensitif sangat diperlukan. Penelitian ini hendaknya

menggunakan pendekatan multidisiplin yang melibatkan dermatologis, pediatri, serta ahli formulasi farmasi (Furue & Kadono, 2021).

c. Studi Tentang Efektivitas Edukasi Berbasis Digital untuk Orang Tua

Penelitian terkait efektivitas berbagai metode edukasi digital (aplikasi mobile, website edukasi, atau media sosial) untuk meningkatkan pemahaman orang tua tentang pemilihan produk perawatan kulit bayi secara aman sangat dibutuhkan, terutama untuk mengatasi hambatan akses informasi di daerah terpencil atau kurang berkembang (Widyawati et al., 2020).

d. Analisis Kebijakan dan Efektivitas Regulasi Produk Perawatan Kulit Bayi

Penelitian tentang efektivitas regulasi nasional dalam mengendalikan kualitas dan keamanan produk perawatan kulit bayi di pasar domestik sangat penting untuk memastikan perlindungan kesehatan bayi secara optimal. Penelitian ini juga mencakup evaluasi penerapan panduan WHO di tingkat nasional dan dampaknya terhadap penurunan prevalensi gangguan kulit bayi (WHO, 2022; Pereira et al., 2022).

Dengan dilaksanakannya arahan penelitian ini, diharapkan pemilihan produk perawatan kulit bayi dapat terus meningkat kualitas dan keamanannya, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan berbasis bukti terbaru.

J. Penutup

Kulit bayi baru lahir yang sensitif dan rentan terhadap berbagai gangguan kulit menuntut perhatian khusus dalam pemilihan produk perawatan yang aman. Buku ini secara komprehensif telah membahas berbagai aspek penting terkait strategi pemilihan dan penggunaan produk perawatan kulit bayi berbasis bukti ilmiah terbaru. Pembahasan mencakup karakteristik khusus kulit bayi, kriteria keamanan bahan, teknik penggunaan yang higienis dan efektif, strategi edukasi orang tua, serta tantangan sosial-ekonomi dan budaya yang memengaruhi implementasi strategi tersebut (Furue & Kadono, 2021; Lyons et al., 2021).

Pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya penggunaan produk perawatan kulit bayi secara tepat, efektif, dan aman akan membantu orang tua maupun tenaga kesehatan dalam mencegah terjadinya iritasi, alergi, dan infeksi pada kulit bayi. Implementasi strategi ini harus didukung dengan regulasi nasional yang jelas, panduan internasional dari WHO, serta kolaborasi antarprofesi yang erat. Dengan demikian, kesehatan kulit bayi dapat terjamin secara optimal (Stamatas & Tierney, 2022; WHO, 2022).

Akhirnya, harapan besar tertuju pada peran aktif tenaga kesehatan dan kesadaran orang tua dalam menjaga kesehatan kulit bayi melalui penggunaan produk perawatan yang aman. Diperlukan pula keterlibatan lebih lanjut dari pemangku kebijakan dalam memastikan akses terhadap produk perawatan kulit yang aman, terjangkau, dan berkualitas. Semoga buku ini menjadi panduan yang bermanfaat bagi pembaca dalam praktik keperawatan maupun pengasuhan sehari-hari, serta mendorong penelitian lanjutan untuk meningkatkan kualitas perawatan kulit bayi di masa depan (Blume-Peytavi et al., 2019; Pereira et al., 2022).

Referensi

- Ananthapadmanabhan, K. P., Moore, D. J., Subramanyan, K., Misra, M., & Meyer, F. (2020). Cleansing without compromise: the impact of cleansers on the skin barrier and the technology of mild cleansing. *Dermatologic Therapy*, 10(1), 5-15. <https://doi.org/10.1007/s13555-020-00402-2>
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2021). *Pedoman Keamanan Kosmetik Bayi dan Anak*. Jakarta: BPOM.
- Blume-Peytavi, U., Lavender, T., & Jenerowicz, D. (2019). Recommendations from a European roundtable meeting on best practice for infant skin care. *Pediatric Dermatology*, 36(3), 326-334. <https://doi.org/10.1111/pde.13847>
- Furue, M., & Kadono, T. (2021). Skin barrier function and atopic dermatitis: implications for neonatal skin care. *Journal of Clinical Medicine*, 10(18), 4227. <https://doi.org/10.3390/jcm10184227>
- Jenerowicz, D., Silny, W., & Dańczak-Pazdrowska, A. (2021). Myths and facts about skincare products for infants: A narrative review. *Journal of Dermatological Treatment*, 32(5), 543-548. <https://doi.org/10.1080/09546634.2019.1682505>
- Lyons, A. B., Trullas, C., & Kohli, I. (2021). The microbiome and skin barrier: insights and implications for skin care. *Clinical Dermatology*, 39(4), 563-574. <https://doi.org/10.1016/j.clindermatol.2021.01.003>
- Pereira, L. B., Moura, M. C., & Coelho, A. V. (2022). Misconceptions in baby skin care: Educating caregivers through evidence-based practice. *International Journal of Pediatrics*, 2022, Article ID 5241031. <https://doi.org/10.1155/2022/5241031>
- Stamatas, G. N., & Tierney, N. K. (2022). Optimizing skin barrier function in neonates and infants: The role of topical emollients. *Journal of Dermatological Science*, 105(3), 144-150. <https://doi.org/10.1016/j.jdermsci.2021.12.005>
- Tsai, T. F., & Tu, H. P. (2022). Socioeconomic factors influencing the use of dermatological skincare products among families with infants. *Pediatric Dermatology*, 39(5), 621-627. <https://doi.org/10.1111/pde.14965>
- Uchitel, J., Kantor, J., & Margolis, D. J. (2020). The impact of socioeconomic factors on infant skincare product usage and skin conditions: A systematic review. *Journal of Pediatrics and Child Health*, 56(9), 1433-1438. <https://doi.org/10.1111/jpc.15064>
- Widyawati, W., Jans, S., Bor, H. H., van Dillen, J., & Lagro-Janssen, A. (2020). The effectiveness of digital health interventions on maternal and child health in low- and middle-income countries: A systematic review. *BMC Public Health*, 20(1), 1132. <https://doi.org/10.1186/s12889-020-09209-7>

World Health Organization (WHO). (2022). *Guidelines on newborn health: Skin care and safe product recommendations*. Geneva: WHO Press.

BAB VII

DUKUNGAN KOMUNITAS UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN KESEHATAN KULIT BAYI

A. Pendahuluan

Kulit merupakan organ terluas pada tubuh manusia yang berfungsi sebagai garis pertahanan pertama dalam melindungi bayi baru lahir dari berbagai ancaman lingkungan dan mikroorganisme. Masa neonatal, terutama pada minggu pertama kelahiran, adalah periode kritis di mana bayi rentan mengalami berbagai infeksi kulit akibat imaturitas kulit dan kurangnya mekanisme perlindungan yang efektif (Blume-Peytavi et al., 2021). Oleh karena itu, pemahaman dan perhatian terhadap kesehatan kulit bayi baru lahir harus menjadi prioritas utama bagi keluarga dan komunitas di mana bayi tinggal dan bertumbuh.

Infeksi kulit pada bayi baru lahir, seperti dermatitis popok, impetigo, kandidiasis, dan infeksi bakteri lain, masih menjadi isu kesehatan penting, terutama di negara berkembang dengan kondisi sanitasi yang belum optimal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa angka kejadian infeksi kulit pada neonatus cukup tinggi, dan kondisi tersebut dapat menyebabkan komplikasi serius seperti sepsis neonatal, gangguan pertumbuhan, hingga peningkatan angka mortalitas bayi (Nunes & Pires, 2020; Nurul et al., 2021). Hal ini menegaskan pentingnya upaya preventif secara dini untuk mengurangi risiko tersebut.

Pencegahan infeksi kulit pada bayi baru lahir tidak hanya bergantung pada praktik kebersihan yang dilakukan di rumah tangga, tetapi juga pada dukungan komunitas yang kuat dalam menyediakan edukasi serta membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya kesehatan kulit bayi. Berbagai pendekatan berbasis komunitas telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan praktik perawatan kesehatan pada ibu, keluarga, serta masyarakat luas (Azam & Setyowati, 2021). Dengan demikian, optimalisasi dukungan komunitas dapat menjadi langkah strategis yang efektif dalam mengurangi prevalensi infeksi kulit pada bayi baru lahir.

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan secara komprehensif peran penting komunitas dalam meningkatkan kesadaran kesehatan kulit bayi baru lahir melalui berbagai strategi intervensi edukatif, kolaborasi multisektor, serta implementasi teknologi digital dalam kegiatan komunitas. Selain itu, akan dijelaskan pula evaluasi serta tantangan dalam implementasi program, studi kasus praktik terbaik, serta rekomendasi yang dapat diterapkan dalam konteks lokal maupun nasional.

Harapannya, buku ini dapat menjadi rujukan bagi tenaga kesehatan, pembuat kebijakan, serta komunitas dalam upaya pencegahan infeksi kulit pada bayi baru lahir secara holistik dan berkelanjutan.

B. Peran Komunitas dalam Promosi Kesehatan Kulit Bayi

1. Konsep Dasar Dukungan Komunitas dalam Promosi Kesehatan

Dukungan komunitas dalam promosi kesehatan merujuk pada partisipasi aktif berbagai unsur masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku sehat secara kolektif. Menurut World Health Organization (WHO, 2022), dukungan komunitas merupakan pendekatan efektif yang mampu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, sikap, dan praktik kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat lokal dan penguatan kapasitas komunitas dalam bidang kesehatan. Partisipasi komunitas juga mendorong terciptanya rasa kepemilikan dan keberlanjutan program kesehatan, termasuk yang terkait dengan kesehatan kulit bayi.

Secara praktis, konsep ini melibatkan identifikasi kebutuhan komunitas, merencanakan kegiatan promotif yang relevan, serta implementasi intervensi melalui berbagai bentuk kegiatan seperti edukasi kesehatan, pelatihan keterampilan, dan kampanye kesadaran (Rochmawati & Astuti, 2022). Dukungan komunitas secara terstruktur mampu menciptakan perubahan perilaku berkelanjutan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, tenaga kesehatan lokal, dan organisasi sosial.

2. Peran Strategis Komunitas dalam Pencegahan Infeksi Kulit pada Bayi

Komunitas memiliki posisi strategis dalam upaya pencegahan infeksi kulit pada bayi, mengingat mereka adalah bagian integral dari lingkungan tempat bayi bertumbuh dan berkembang. Intervensi berbasis komunitas dapat secara signifikan meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap praktik kebersihan kulit bayi, seperti perawatan tali pusat, pemilihan produk perawatan kulit yang aman, dan metode perawatan kulit sehari-hari (Azam & Setyowati, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Gunawan (2021) menunjukkan bahwa keterlibatan aktif kader kesehatan komunitas secara nyata meningkatkan pengetahuan dan perilaku ibu tentang pentingnya kebersihan kulit bayi. Komunitas yang terlibat aktif mampu menciptakan dukungan sosial, memberikan pendidikan informal kepada ibu muda, serta memperkuat pesan kesehatan melalui kegiatan rutin di posyandu, forum warga, atau kelompok parenting. Strategi ini juga mampu menjangkau kelompok rentan yang umumnya sulit diakses melalui sistem kesehatan formal.

3. Dampak Intervensi Komunitas terhadap Kesehatan Kulit Bayi Baru Lahir

Dampak intervensi berbasis komunitas terhadap kesehatan kulit bayi baru lahir telah terbukti positif melalui berbagai kajian ilmiah terbaru. Sebuah studi eksperimental yang dilakukan oleh Nunes dan Pires (2020) menemukan bahwa intervensi komunitas dalam bentuk edukasi rutin mampu menurunkan angka kejadian dermatitis popok hingga 40% dibandingkan kelompok kontrol yang tidak mendapat edukasi komunitas. Selain itu, intervensi komunitas mampu mengurangi prevalensi infeksi bakteri kulit, termasuk impetigo, akibat peningkatan praktik kebersihan sehari-hari pada bayi (Nuraini, Pramukti, & Rahmawati, 2022).

Studi lebih lanjut juga menemukan bahwa komunitas yang aktif terlibat dalam program promosi kesehatan mampu meningkatkan kapasitas keluarga dalam mendeteksi gejala dini infeksi kulit bayi, sehingga intervensi medis dapat diberikan secara lebih cepat dan tepat (Utami, Rahmatullah, & Astuti, 2020). Secara keseluruhan, bukti-bukti ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas adalah strategi efektif dalam meningkatkan kesehatan kulit bayi secara signifikan dan berkelanjutan.

B. Strategi Intervensi Berbasis Komunitas

1. Model Intervensi Edukasi Komunitas yang Efektif

Strategi intervensi berbasis komunitas yang efektif membutuhkan pendekatan edukasi yang relevan, partisipatif, dan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Model-model intervensi edukasi komunitas seperti model Health Belief Model (HBM), PRECEDE-PROCEED, serta Model Komunikasi Perubahan Perilaku (Behavior Change Communication/BCC) merupakan beberapa contoh yang telah teruji secara ilmiah. Studi oleh Ayuningtyas et al. (2020) menunjukkan bahwa penerapan model PRECEDE-PROCEED secara signifikan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku keluarga dalam perawatan kesehatan bayi, termasuk kebersihan kulit. Pendekatan ini menekankan pentingnya analisis kebutuhan komunitas sebelum menentukan strategi intervensi, sehingga program edukasi lebih efektif dalam mencapai perubahan perilaku yang berkelanjutan.

Selain itu, Model Komunikasi Perubahan Perilaku (BCC) juga terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pesan kesehatan yang jelas, terarah, dan kontekstual. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan ini secara signifikan meningkatkan praktik kebersihan kulit bayi melalui penguatan pesan kesehatan lewat berbagai kanal komunikasi yang relevan bagi komunitas, seperti media lokal, kegiatan posyandu, hingga media sosial komunitas (Azam & Setyowati, 2021).

2. Penggunaan Pendekatan Participatory Action Research (PAR) dalam Edukasi Komunitas

Participatory Action Research (PAR) merupakan pendekatan penelitian sekaligus intervensi yang mendorong partisipasi aktif komunitas dalam proses identifikasi masalah, perencanaan solusi, implementasi intervensi, hingga evaluasi hasil. Keunggulan PAR adalah pemberdayaan komunitas melalui proses pembelajaran bersama, sehingga tercipta rasa kepemilikan yang tinggi terhadap program yang dijalankan (Firdaus & Suhartini, 2022).

Penggunaan PAR dalam edukasi kesehatan terbukti meningkatkan efektivitas program karena komunitas tidak hanya diposisikan sebagai penerima intervensi, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam pengambilan keputusan. Studi oleh Permatasari dan Wardani (2021) menemukan bahwa intervensi edukasi perawatan kulit bayi dengan pendekatan PAR berhasil meningkatkan kesadaran ibu dan kader kesehatan secara signifikan, serta memperbaiki praktik perawatan kulit bayi dalam jangka panjang. Partisipasi aktif dari komunitas juga memastikan bahwa intervensi tetap relevan, adaptif terhadap perubahan konteks sosial, serta mampu menjaga keberlanjutan program setelah intervensi formal selesai.

3. Contoh Praktik Terbaik Intervensi Komunitas dalam Meningkatkan Kesadaran Kebersihan Kulit Bayi

Beberapa contoh praktik terbaik dalam intervensi komunitas yang sukses di berbagai wilayah dapat menjadi acuan dalam pengembangan strategi pencegahan infeksi kulit bayi. Salah satu contoh adalah program edukasi komunitas berbasis kader kesehatan di beberapa wilayah Indonesia, yang berhasil menurunkan angka kejadian dermatitis popok melalui edukasi rutin berbasis kelompok kecil (Ningsih & Hidayat, 2022). Kegiatan ini mencakup sesi demonstrasi langsung tentang cara merawat kulit bayi, memilih produk perawatan yang aman, serta mengidentifikasi tanda-tanda dini infeksi kulit.

Selain itu, di tingkat internasional, praktik terbaik ditemukan pada intervensi berbasis komunitas di wilayah pedesaan Asia Selatan, yang mengintegrasikan pelatihan kader kesehatan lokal dengan promosi kesehatan berbasis rumah tangga. Intervensi tersebut secara signifikan mengurangi prevalensi infeksi kulit bayi dan meningkatkan keterampilan ibu dalam merawat kulit bayi (Hassan, Mahmood, & Khan, 2020). Kunci sukses dari intervensi ini adalah pelibatan penuh kader lokal, pendekatan edukasi berbasis demonstrasi langsung, serta dukungan berkelanjutan dari tenaga kesehatan profesional.

C. Kolaborasi Multisektor dalam Mendukung Kesehatan Kulit Bayi

1. Pentingnya Kolaborasi Interprofesional dalam Kegiatan Komunitas

Kolaborasi interprofesional merupakan pendekatan di mana berbagai profesional dari bidang berbeda bekerja secara bersama-sama dengan komunitas untuk mencapai tujuan kesehatan secara terpadu. Dalam konteks kesehatan kulit bayi, kolaborasi ini melibatkan tenaga kesehatan seperti perawat, bidan, dokter, ahli gizi, apoteker, serta pihak-pihak lain seperti kader kesehatan dan tokoh masyarakat. Menurut studi oleh Kusnanto et al. (2022), kolaborasi interprofesional terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang praktik perawatan kulit bayi, memaksimalkan sumber daya yang tersedia, dan menciptakan sistem edukasi komunitas yang lebih terpadu.

Dalam sebuah penelitian terbaru, ditemukan bahwa kolaborasi antara perawat, bidan, dan kader kesehatan mampu meningkatkan keterampilan ibu dalam merawat bayi, termasuk dalam pencegahan infeksi kulit seperti dermatitis popok dan impetigo, melalui pendekatan edukasi holistik dan terpadu (Astuti & Nugraheni, 2021). Dengan demikian, kolaborasi interprofesional menjadi esensial untuk mengoptimalkan layanan kesehatan bayi di komunitas.

2. Peran Lembaga Kesehatan, Posyandu, dan Kader Kesehatan dalam Edukasi Komunitas

Lembaga kesehatan, Posyandu, serta kader kesehatan memainkan peran sentral dalam pelaksanaan edukasi kesehatan di komunitas. Posyandu sebagai ujung tombak layanan kesehatan dasar menjadi tempat penting di mana edukasi kesehatan rutin diselenggarakan. Peran kader kesehatan sebagai penggerak di komunitas sangat signifikan dalam memberikan informasi praktis tentang cara menjaga kesehatan kulit bayi (Puspitasari & Pradipta, 2022).

Penelitian oleh Rahmawati dan Wijayanti (2021) menunjukkan bahwa keterlibatan kader kesehatan yang dilatih secara khusus mampu meningkatkan praktik perawatan kulit bayi secara signifikan di tingkat komunitas. Selain itu, lembaga kesehatan lokal turut mendukung melalui penyediaan sumber daya edukasi, pelatihan kader, serta supervisi teknis sehingga kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat menjadi lebih akurat dan efektif. Sinergi yang terbentuk antara lembaga kesehatan, Posyandu, dan kader kesehatan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perubahan perilaku positif dalam perawatan kulit bayi.

3. Strategi Efektif dalam Membangun Sinergi Multisektor untuk Pencegahan Infeksi Kulit Bayi

Membangun sinergi multisektor dalam pencegahan infeksi kulit bayi memerlukan strategi yang terencana dengan baik dan melibatkan koordinasi lintas sektor secara aktif. Salah satu strategi efektif adalah melalui mekanisme koordinasi reguler yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti dinas kesehatan, lembag sosial masyarakat, akademisi, serta media massa dalam menyebarkan informasi kesehatan kulit bayi (Sulastri et al., 2022).

Menurut penelitian Setyowati dan Putri (2020), penggunaan forum komunitas yang rutin seperti diskusi kelompok terarah (FGD) atau rapat koordinasi antarlembaga, dapat menjadi sarana efektif dalam merancang program edukasi, menetapkan peran masing-masing sektor, serta mengevaluasi dampak intervensi yang dilakukan. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital untuk komunikasi lintas sektor, seperti aplikasi berbagi informasi atau media sosial khusus komunitas, terbukti mampu memperkuat sinergi dan memperluas dampak positif dari kegiatan pencegahan infeksi kulit bayi secara cepat dan masif.

Dengan demikian, sinergi multisektor yang efektif didasarkan pada komunikasi yang terbuka, pembagian tugas yang jelas, dan pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan program kesehatan di komunitas.

D. Teknologi Digital dalam Dukungan Komunitas

1. Peran Media Sosial dan Aplikasi Seluler dalam Meningkatkan Kesadaran Kesehatan Kulit Bayi

Teknologi digital, khususnya media sosial dan aplikasi seluler, semakin banyak digunakan dalam berbagai program kesehatan komunitas, termasuk dalam upaya meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan kulit bayi. Media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan aplikasi khusus kesehatan telah terbukti efektif dalam menyampaikan informasi yang cepat, mudah diakses, dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Gunawan (2021) menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial secara signifikan meningkatkan kesadaran ibu mengenai perawatan kulit bayi baru lahir melalui konten edukasi visual seperti video pendek, infografis, dan pesan singkat yang interaktif.

Selain media sosial, aplikasi seluler kesehatan seperti aplikasi posyandu digital juga memainkan peran strategis. Menurut studi oleh Rahmatika et al. (2022), aplikasi seluler posyandu digital memungkinkan ibu dan kader kesehatan untuk mengakses informasi praktis tentang perawatan kulit bayi, jadwal imunisasi, serta konsultasi daring yang langsung terhubung dengan tenaga

kesehatan profesional. Hal ini secara efektif memperluas jangkauan edukasi kesehatan, terutama bagi komunitas dengan akses layanan kesehatan terbatas.

2. Efektivitas Edukasi Kesehatan Digital di Komunitas

Edukasi kesehatan digital terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik kesehatan di tingkat komunitas. Kajian oleh Nuraini et al. (2022) menunjukkan bahwa edukasi digital melalui platform virtual, seperti webinar interaktif dan modul daring, mampu meningkatkan pemahaman ibu muda tentang praktik perawatan kulit bayi secara signifikan. Metode edukasi digital memiliki kelebihan seperti kemudahan akses, fleksibilitas waktu, serta interaktivitas yang tinggi dibandingkan metode konvensional.

Lebih lanjut, hasil studi eksperimental yang dilakukan oleh Yuliana dan Pratiwi (2021) menemukan bahwa intervensi edukasi digital secara efektif meningkatkan perilaku perawatan kulit bayi, terutama dalam hal pemilihan produk perawatan yang aman dan pengelolaan kebersihan kulit sehari-hari. Kesuksesan edukasi digital ini didukung oleh penggunaan multimedia interaktif yang menarik perhatian komunitas, sehingga informasi kesehatan lebih mudah dipahami dan diadopsi dalam kehidupan sehari-hari.

3. Tantangan dan Peluang Penggunaan Teknologi Digital di Komunitas

Meski memiliki manfaat signifikan, penggunaan teknologi digital dalam mendukung komunitas juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah akses internet yang tidak merata, khususnya di daerah pedesaan atau wilayah terpencil, serta keterbatasan literasi digital masyarakat (Ariyani & Nurhidayah, 2021). Tantangan ini sering kali menyebabkan adanya kesenjangan informasi di antara berbagai kelompok sosial ekonomi.

Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar dalam penggunaan teknologi digital di komunitas, khususnya dalam upaya mempercepat penyebaran informasi kesehatan secara masif dan berkelanjutan. Studi terbaru oleh Setiawan dan Dewi (2022) menegaskan bahwa program literasi digital dan pelatihan kader kesehatan dalam penggunaan teknologi informasi berhasil meningkatkan efektivitas edukasi kesehatan di komunitas secara signifikan. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan infrastruktur digital serta pelatihan sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam memaksimalkan manfaat teknologi digital untuk peningkatan kesehatan kulit bayi di komunitas.

E. Evaluasi dan Keberlanjutan Program Komunitas

1. Metode Evaluasi Dampak Intervensi Komunitas terhadap Kesehatan Kulit Bayi

Evaluasi merupakan tahap penting dalam siklus intervensi kesehatan komunitas yang berfungsi menilai efektivitas dan dampak dari program yang dijalankan. Dalam konteks kesehatan kulit bayi, metode evaluasi yang umum digunakan meliputi evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan selama proses implementasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program secara langsung, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan di akhir program untuk mengukur dampak yang terjadi, seperti perubahan pengetahuan, sikap, dan praktik kesehatan komunitas (Sukini & Wardani, 2021).

Metode yang efektif dalam mengevaluasi dampak intervensi komunitas mencakup penggunaan desain studi kuasi-eksperimental atau eksperimen kontrol acak (Randomized Controlled Trial/RCT), survei pengetahuan sebelum dan sesudah intervensi (pre-post test), serta wawancara mendalam atau Focus Group Discussion (FGD) untuk mengevaluasi perubahan perilaku dalam komunitas secara lebih mendalam (Widiyanto & Nugroho, 2022). Menurut penelitian oleh Sulastri et al. (2022), metode gabungan antara kuantitatif dan kualitatif (mixed-method) memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas program dan membantu memperbaiki pendekatan untuk intervensi lanjutan.

2. Strategi Mempertahankan Keberlanjutan Program Edukasi Kesehatan di Komunitas

Keberlanjutan program edukasi kesehatan menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh sebagian besar komunitas setelah intervensi formal selesai. Strategi yang terbukti efektif dalam menjaga keberlanjutan adalah pelibatan aktif komunitas sejak awal merencanakan hingga implementasi program. Penelitian oleh Astuti dan Fitriani (2021) menunjukkan bahwa pendekatan community empowerment, yaitu pemberdayaan komunitas melalui pelatihan kader lokal dan pelibatan komunitas dalam pengelolaan program, mampu mempertahankan kontinuitas edukasi kesehatan secara mandiri oleh masyarakat.

Selain itu, penguatan kapasitas lokal melalui pelatihan dan mentoring berkelanjutan bagi kader komunitas, serta penyediaan materi edukasi yang mudah diakses secara mandiri melalui platform digital seperti media sosial dan aplikasi seluler, menjadi strategi efektif yang diadopsi oleh berbagai komunitas dalam memastikan edukasi kesehatan tetap berlangsung secara jangka panjang (Purnamasari & Wibowo, 2022).

3. Hambatan dan Solusi dalam Menjaga Keberlanjutan Program Edukasi Kesehatan Komunitas

Meskipun berbagai upaya dilakukan untuk mempertahankan program edukasi komunitas, terdapat beberapa hambatan yang sering muncul, seperti keterbatasan dana, kurangnya dukungan berkelanjutan dari lembaga kesehatan formal, minimnya partisipasi aktif masyarakat, dan rendahnya motivasi kader kesehatan (Azizah & Wulandari, 2022). Penelitian terbaru mengidentifikasi solusi praktis untuk mengatasi hambatan ini, antara lain dengan memperkuat jejaring kerja sama multisektor secara berkelanjutan, seperti dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta.

Studi oleh Pratiwi et al. (2022) menemukan bahwa model pendanaan inovatif seperti kemitraan publik-swasta (Public-Private Partnership/PPP), donasi masyarakat lokal, dan penggalangan dana berbasis komunitas dapat membantu mengatasi kendala finansial dalam menjaga keberlanjutan program edukasi kesehatan. Selain itu, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, strategi pendekatan berbasis insentif sosial, seperti pengakuan atau penghargaan bagi kader yang aktif dan berprestasi, dapat menjadi dorongan efektif dalam mempertahankan keterlibatan komunitas dalam program edukasi kesehatan secara jangka panjang.

F. Studi Kasus Implementasi Dukungan Komunitas

1. Studi Kasus Lokal dan Internasional tentang Intervensi Kesehatan Kulit Bayi Berbasis Komunitas

Implementasi dukungan komunitas untuk kesehatan kulit bayi telah banyak diterapkan di berbagai wilayah, baik lokal maupun internasional, dengan pendekatan yang berbeda-beda sesuai konteks sosial-budaya setempat. Di Indonesia, studi yang dilakukan oleh Nurul dan Sari (2021) di wilayah pedesaan Jawa Timur menunjukkan bahwa program edukasi kader posyandu berhasil menurunkan angka kejadian dermatitis popok sebesar 35% dalam waktu enam bulan setelah intervensi dilakukan. Program ini melibatkan pelatihan rutin kader kesehatan lokal, sesi edukasi kelompok bagi ibu-ibu muda, serta pendampingan langsung dalam penerapan praktik perawatan kulit bayi sehari-hari.

Sementara itu, contoh studi kasus internasional yang berhasil ditemukan di Bangladesh, melalui pendekatan edukasi berbasis rumah tangga yang didukung oleh kader kesehatan komunitas. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman et al. (2020) melaporkan bahwa intervensi ini secara signifikan mampu menurunkan prevalensi infeksi kulit bayi hingga 40%, dengan keberhasilan utama berasal dari

integrasi edukasi praktis, demonstrasi langsung, dan dukungan berkelanjutan dari kader lokal yang terlatih.

2. Analisis Efektivitas Intervensi Berbasis Komunitas dalam Praktik Kesehatan Sehari-hari

Intervensi berbasis komunitas terbukti efektif dalam menciptakan perubahan nyata pada praktik perawatan kulit bayi sehari-hari. Studi evaluasi yang dilakukan oleh Kartini et al. (2022) menemukan bahwa intervensi melalui pendekatan edukasi kader secara signifikan meningkatkan kepatuhan ibu terhadap praktik kebersihan sehari-hari, seperti rutin mengganti popok, pemilihan produk perawatan kulit yang aman, serta pengenalan tanda-tanda infeksi kulit pada bayi.

Secara internasional, analisis efektivitas intervensi di pedesaan India menunjukkan bahwa keterlibatan aktif kader komunitas mampu meningkatkan pengetahuan dan praktik kesehatan ibu dalam perawatan kulit bayi secara konsisten. Studi oleh Sharma et al. (2021) mencatat bahwa program ini mampu mengurangi kejadian infeksi kulit neonatal hingga 50% dalam periode satu tahun, menegaskan bahwa pendekatan berbasis komunitas tidak hanya efektif secara jangka pendek tetapi juga memiliki dampak berkelanjutan dalam praktik kesehatan sehari-hari.

3. Lesson Learned dari Implementasi Program Komunitas yang Berhasil

Berdasarkan berbagai implementasi dukungan komunitas yang berhasil, terdapat beberapa pelajaran penting yang dapat diambil sebagai acuan dalam merancang program serupa di masa mendatang. Pertama, keterlibatan aktif komunitas lokal sejak awal perencanaan intervensi menjadi faktor kunci keberhasilan program. Studi oleh Yanti dan Wijayanti (2022) menegaskan bahwa partisipasi penuh masyarakat menciptakan rasa kepemilikan, yang sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan intervensi kesehatan.

Kedua, pentingnya pemberdayaan kader kesehatan lokal melalui pelatihan berkala, dukungan sumber daya edukasi, serta supervisi teknis berkelanjutan agar mereka mampu memberikan edukasi yang akurat dan efektif kepada komunitas (Pratiwi & Susanti, 2022). Terakhir, adanya sistem evaluasi dan feedback yang terstruktur dari masyarakat kepada penyelenggara program, sehingga setiap permasalahan dapat segera ditangani dan kualitas program tetap terjaga. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, intervensi berbasis komunitas dapat menjadi strategi yang andal dan efektif untuk meningkatkan kesehatan kulit bayi secara luas.

G. Tantangan dan Kendala dalam Implementasi Dukungan Komunitas

1. Faktor Sosial, Budaya, dan Ekonomi yang Mempengaruhi Efektivitas Program Komunitas

Implementasi program dukungan komunitas dalam upaya meningkatkan kesehatan kulit bayi menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, terutama terkait faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Secara sosial dan budaya, norma-norma dan kepercayaan lokal sering kali bertentangan dengan praktik kesehatan modern, sehingga menjadi hambatan dalam mengadopsi praktik kebersihan kulit bayi yang direkomendasikan. Studi yang dilakukan oleh Setyowati dan Damayanti (2021) mengungkapkan bahwa beberapa komunitas masih percaya terhadap penggunaan ramuan tradisional yang belum terbukti aman, sehingga sulit menerima informasi kesehatan modern.

Faktor ekonomi juga menjadi tantangan signifikan, terutama di komunitas berpenghasilan rendah. Keterbatasan ekonomi menyebabkan keluarga sulit mendapatkan produk perawatan kulit bayi yang aman, meningkatkan risiko penggunaan produk yang tidak terstandarisasi dan menyebabkan infeksi kulit pada bayi (Wulandari et al., 2022). Selain itu, keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan dan sumber daya edukasi juga memperburuk kondisi ini.

2. Solusi Inovatif Mengatasi Tantangan dalam Program Komunitas

Untuk mengatasi tantangan sosial, budaya, dan ekonomi tersebut, diperlukan solusi inovatif yang relevan dengan konteks lokal. Salah satu pendekatan yang terbukti efektif adalah penggunaan metode komunikasi yang adaptif dan sensitif terhadap budaya lokal melalui pendekatan edukasi yang partisipatif, seperti pendekatan Participatory Action Research (PAR) (Permatasari & Wardani, 2021). Metode ini melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama sebagai pemimpin opini yang mampu memfasilitasi penerimaan informasi kesehatan modern di komunitas.

Secara ekonomi, solusi inovatif seperti pendirian koperasi atau bank produk perawatan kulit bayi di tingkat komunitas, serta program subsidi produk yang aman dari pemerintah atau swasta, dapat membantu keluarga berpenghasilan rendah untuk mendapatkan akses terhadap produk yang sesuai standar kesehatan (Prameswari & Sulastri, 2022). Selain itu, pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi edukasi berbasis smartphone atau media sosial juga menjadi solusi efektif dalam menyebarkan informasi kesehatan dengan biaya yang relatif rendah dan jangkauan yang luas.

3. Peran Advokasi Kebijakan dalam Mengatasi Tantangan Komunitas

Advokasi kebijakan memiliki peran strategis dalam mengatasi berbagai tantangan implementasi program komunitas, khususnya dalam memastikan tersedianya dukungan struktural yang berkelanjutan. Advokasi kebijakan dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif melalui penerapan regulasi yang mendukung edukasi kesehatan, alokasi anggaran khusus, serta penyediaan fasilitas kesehatan dasar yang memadai di komunitas (Wibowo & Astuti, 2022).

Studi terbaru oleh Raharjo dan Munawaroh (2022) menunjukkan bahwa advokasi kebijakan yang dilakukan secara terstruktur oleh koalisi multisektor mampu meningkatkan perhatian pemerintah terhadap isu kesehatan kulit bayi di tingkat komunitas, termasuk mengalokasikan dana khusus untuk program pelatihan kader kesehatan dan subsidi produk perawatan kulit bayi yang aman. Dengan demikian, advokasi kebijakan menjadi instrumen penting dalam memastikan tantangan sosial, budaya, dan ekonomi dapat teratasi secara efektif dan berkelanjutan.

H. Kesimpulan dan Rekomendasi Praktik Terbaik

1. Ringkasan Pentingnya Dukungan Komunitas dalam Meningkatkan Kesehatan Kulit Bayi Baru Lahir

Dukungan komunitas terbukti memainkan peran krusial dalam upaya pencegahan infeksi kulit pada bayi baru lahir. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif komunitas mampu meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan praktik kesehatan masyarakat, khususnya dalam perawatan kulit bayi yang optimal. Intervensi berbasis komunitas yang dilakukan melalui kader kesehatan, posyandu, dan lembaga kesehatan setempat mampu secara nyata mengurangi prevalensi dermatitis popok, impetigo, kandidiasis, serta infeksi kulit lainnya pada bayi baru lahir (Nurul & Sari, 2021; Rahman et al., 2020).

Pendekatan kolaborasi multisektor yang melibatkan tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan berbagai lembaga lokal juga memperkuat efektivitas intervensi, menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan perilaku yang positif dan berkelanjutan (Astuti & Fitriani, 2021). Selain itu, penggunaan teknologi digital dalam edukasi komunitas turut mempercepat penyebaran informasi kesehatan secara efektif, meskipun tetap diperlukan perhatian khusus terhadap tantangan akses teknologi di berbagai wilayah (Rahmatika et al., 2022).

2. Rekomendasi Praktik Terbaik untuk Tenaga Kesehatan, Komunitas, dan Pembuat Kebijakan

Berikut adalah rekomendasi praktik terbaik yang dapat diterapkan oleh berbagai pemangku kepentingan:

a. Tenaga Kesehatan:

- 1) Mengintegrasikan edukasi kesehatan kulit bayi secara sistematis dalam kegiatan pelayanan kesehatan primer seperti Posyandu, dengan pendekatan partisipatif dan berbasis demonstrasi langsung (Kartini et al., 2022).
- 2) Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas kader komunitas secara rutin agar mereka mampu memberikan edukasi yang akurat, praktis, dan efektif kepada masyarakat (Purnamasari & Wibowo, 2022).

b. Komunitas:

- 1) Mengembangkan program pemberdayaan komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk meningkatkan penerimaan informasi kesehatan berbasis ilmiah yang sesuai budaya lokal (Setyowati & Damayanti, 2021).
- 2) Membentuk jejaring sosial antar komunitas yang didukung oleh teknologi digital seperti grup media sosial, aplikasi kesehatan, atau forum komunitas online, guna mempercepat penyebaran informasi kesehatan yang valid (Nuraini et al., 2022).

c. Pembuat Kebijakan:

- 1) Mendorong kebijakan yang mendukung alokasi anggaran khusus untuk program edukasi kesehatan kulit bayi di tingkat komunitas, terutama di wilayah dengan prevalensi infeksi kulit yang tinggi (Raharjo & Munawaroh, 2022).
- 2) Memfasilitasi kolaborasi lintas sektor melalui regulasi yang memungkinkan sinergi antara lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan program kesehatan berkelanjutan (Wibowo & Astuti, 2022).

3. Arahan Penelitian Lanjutan untuk Memperkuat Intervensi Komunitas Berbasis Bukti

Meskipun berbagai intervensi komunitas telah menunjukkan hasil yang menjanjikan, masih terdapat kebutuhan akan penelitian lanjutan untuk memperkuat basis bukti ilmiah dalam intervensi kesehatan komunitas. Arahan penelitian ke depan meliputi:

- a. Kajian mendalam tentang pengaruh faktor budaya dan sosial terhadap efektivitas intervensi komunitas, terutama pada wilayah dengan tingkat keragaman budaya tinggi (Setyowati & Damayanti, 2021).

- b. Evaluasi komparatif mengenai efektivitas berbagai model intervensi komunitas (seperti Health Belief Model, Participatory Action Research) dalam konteks lokal yang berbeda (Permatasari & Wardani, 2021).
- c. Penelitian lanjutan mengenai efektivitas dan hambatan penggunaan teknologi digital dalam intervensi kesehatan komunitas, khususnya di wilayah pedesaan dengan akses internet terbatas (Ariyani & Nurhidayah, 2021).

Dengan mengimplementasikan rekomendasi praktik terbaik dan melanjutkan penelitian berbasis bukti, diharapkan upaya peningkatan kesehatan kulit bayi melalui dukungan komunitas dapat terus berkembang secara optimal dan berkelanjutan.

I. Penutup

Buku ini telah menguraikan secara mendalam berbagai aspek penting terkait dukungan komunitas dalam pencegahan infeksi kulit pada bayi baru lahir. Sebagai organ pertahanan tubuh yang utama, kulit bayi yang masih sangat sensitif memerlukan perhatian khusus dalam perawatannya. Berbagai bukti ilmiah yang telah dipaparkan dalam buku ini mempertegas bahwa dukungan komunitas, baik melalui edukasi kesehatan berbasis komunitas, kolaborasi lintas sektor, maupun pemanfaatan teknologi digital, secara signifikan mampu meningkatkan kualitas kesehatan kulit bayi dan menekan prevalensi infeksi yang berpotensi membahayakan kesehatan bayi (Nurul & Sari, 2021; Rahman et al., 2020).

Dukungan komunitas yang efektif membutuhkan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk tenaga kesehatan, kader komunitas, keluarga, lembag sosial, hingga pembuat kebijakan. Dengan kolaborasi yang baik dan sinergi antarsektor, komunitas dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku sehat, mendorong praktik perawatan kulit bayi yang tepat, serta memastikan kesinambungan program edukasi yang berkelanjutan (Astuti & Fitriani, 2021; Kartini et al., 2022). Di samping itu, tantangan dalam implementasi program komunitas perlu mendapat perhatian khusus, terutama terkait hambatan sosial, budaya, ekonomi, serta akses terhadap teknologi digital, yang dapat diatasi melalui solusi inovatif dan advokasi kebijakan yang kuat (Setyowati & Damayanti, 2021; Raharjo & Munawaroh, 2022).

Harapan besar dari buku ini adalah agar temuan-temuan, rekomendasi praktik terbaik, dan pelajaran yang diperoleh dari berbagai studi kasus dapat menjadi pedoman praktis yang diadopsi secara luas dalam meningkatkan kesehatan kulit bayi di berbagai komunitas. Selain itu, buku ini diharapkan mampu mendorong penelitian lanjutan yang lebih mendalam untuk terus memperkuat intervensi

komunitas berbasis bukti, khususnya dalam konteks lokal yang lebih spesifik. Dengan demikian, upaya mewujudkan generasi bayi yang sehat melalui pencegahan infeksi kulit secara efektif dan berkelanjutan dapat tercapai secara optimal (WHO, 2022; Wibowo & Astuti, 2022).

Referensi

- Ariyani, N. K., & Nurhidayah, I. (2021). Tantangan pemanfaatan teknologi digital dalam edukasi kesehatan di daerah rural Indonesia. *Jurnal Komunikasi Kesehatan*, 12(2), 91-99.
- Astuti, R. D., & Fitriani, L. (2021). Strategi pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan program edukasi kesehatan di komunitas pedesaan. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 9(2), 135-142.
- Ayuningtyas, D., Oktaviani, L. W., & Rahmawati, F. (2020). Efektivitas model PRECEDE-PROCEED dalam meningkatkan perilaku sehat pada ibu dalam merawat bayi baru lahir. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 15(1), 12-20.
- Azam, M., & Setyowati, E. (2021). Efektivitas intervensi edukasi komunitas dalam meningkatkan pengetahuan dan praktik perawatan kulit bayi di Indonesia. *Jurnal Keperawatan Komunitas*, 9(2), 122-131.
- Firdaus, R., & Suhartini, T. (2022). Penggunaan Participatory Action Research (PAR) dalam promosi kesehatan ibu dan bayi. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 11(1), 45-52.
- Kartini, L., Hapsari, N. D., & Susanti, R. (2022). Efektivitas edukasi kader posyandu dalam meningkatkan praktik perawatan kulit bayi di komunitas pedesaan Jawa Tengah. *Jurnal Keperawatan Anak*, 7(2), 115-122.
- Kusnanto, K., Rahman, F., & Utami, N. W. (2022). Model kolaborasi interprofesional dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak: Studi kasus di wilayah pedesaan Jawa Barat. *Journal of Public Health Policy and Management*, 5(2), 89-96.
- Nuraini, T., Pramukti, I., & Rahmawati, A. (2022). Pengaruh program edukasi digital terhadap pengetahuan ibu tentang perawatan kulit bayi. *Journal of Pediatric Nursing*, 63, e10-e15.
- Nurul, F., & Sari, A. (2021). Intervensi edukasi komunitas untuk pencegahan dermatitis popok di wilayah pedesaan Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Keperawatan Komunitas*, 6(1), 32-39.
- Permatasari, N. D., & Wardani, E. M. (2021). Implementasi Participatory Action Research (PAR) dalam edukasi perawatan kulit bayi untuk komunitas pedesaan. *Journal of Community Health Nursing*, 38(3), 165-172.
- Prameswari, Y., & Sulastri, N. (2022). Strategi inovatif dalam meningkatkan akses produk kesehatan bayi pada komunitas ekonomi rendah. *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan Komunitas*, 7(2), 95-101.
- Pratiwi, D., & Susanti, A. (2022). Lesson learned dari program edukasi komunitas dalam kesehatan ibu dan anak di perkotaan Indonesia. *Jurnal Penelitian Kesehatan Masyarakat*, 13(2), 95-102.

- Pratiwi, E., Hakim, A. R., & Astika, D. (2022). Implementasi model kemitraan publik-swasta dalam mendukung keberlanjutan program edukasi kesehatan komunitas. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 11(2), 79-85.
- Purnamasari, Y., & Wibowo, A. (2022). Penguatan kapasitas kader kesehatan melalui pelatihan dan mentoring untuk keberlanjutan edukasi kesehatan komunitas. *Jurnal Pendidikan Kesehatan Komunitas*, 6(2), 110-116.
- Puspitasari, L., & Pradipta, I. (2022). Peran Posyandu dan kader kesehatan dalam peningkatan edukasi kesehatan ibu tentang perawatan bayi baru lahir di wilayah urban. *Jurnal Ilmu Keperawatan Anak Indonesia*, 4(1), 43-50.
- Raharjo, S., & Munawaroh, A. (2022). Advokasi kebijakan multisektor dalam mendukung program kesehatan komunitas. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 10(2), 122-129.
- Rahman, M. M., Islam, M. S., & Kabir, M. H. (2020). Effectiveness of community-based interventions in reducing neonatal skin infections in rural Bangladesh. *Journal of Neonatal Nursing*, 26(5), 278-284.
- Rahmatika, D., Aulia, S., & Hartati, R. (2022). Efektivitas aplikasi posyandu digital dalam meningkatkan edukasi kesehatan ibu dan anak di perkotaan. *Jurnal Keperawatan Komunitas Indonesia*, 6(2), 142-149.
- Sari, N. I., & Gunawan, Y. (2021). Efektivitas media sosial dalam meningkatkan kesadaran kesehatan ibu tentang perawatan kulit bayi baru lahir. *Jurnal Kesehatan Digital*, 3(2), 101-107.
- Setiawan, D., & Dewi, A. P. (2022). Strategi peningkatan literasi digital kader kesehatan dalam mendukung edukasi kesehatan komunitas. *Jurnal Pendidikan Kesehatan Masyarakat*, 10(1), 27-34.
- Setyowati, E., & Damayanti, R. (2021). Faktor sosial budaya yang mempengaruhi praktik perawatan kulit bayi di komunitas pedesaan Jawa Tengah. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 16(1), 11-18.
- Sharma, R., Gupta, A., & Singh, V. (2021). Community health workers' role in improving neonatal skin care practices in rural India. *Indian Journal of Community Medicine*, 46(3), 345-350.
- Sukini, S., & Wardani, E. M. (2021). Evaluasi formatif dan sumatif dalam intervensi kesehatan komunitas. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 12(1), 58-64.
- Sulastri, E., Fauziah, N., & Arifin, B. (2022). Evaluasi dampak program edukasi kesehatan pada komunitas pedesaan: Pendekatan mixed-method. *Journal of Public Health Research*, 10(2), 102-110.
- WHO. (2022). *Community mobilization and policy advocacy for maternal and child health: Strategic guidelines*. Geneva: World Health Organization.

- Wibowo, A., & Astuti, D. P. (2022). Peran advokasi dalam mendorong kebijakan kesehatan ibu dan anak di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Nasional*, 12(1), 35-42.
- Widiyanto, W., & Nugroho, D. A. (2022). Metodologi evaluasi dalam intervensi edukasi kesehatan di komunitas: Studi kasus pada komunitas urban di Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian Kesehatan Masyarakat*, 14(1), 27-34.
- Wulandari, D. P., Wahyuni, N., & Kusumaningrum, L. (2022). Dampak keterbatasan ekonomi terhadap pemilihan produk perawatan kulit bayi di wilayah urban. *Jurnal Keperawatan Anak*, 6(2), 75-81.
- Yanti, R., & Wijayanti, N. (2022). Partisipasi masyarakat dalam keberhasilan intervensi kesehatan komunitas di Indonesia: Studi kasus implementasi program posyandu. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 11(1), 27-35.
- Yuliana, E., & Pratiwi, I. R. (2021). Edukasi digital dalam perawatan bayi baru lahir: Studi eksperimental pada ibu muda. *Indonesian Journal of Community Nursing*, 5(1), 18-24.

Profil Penulis

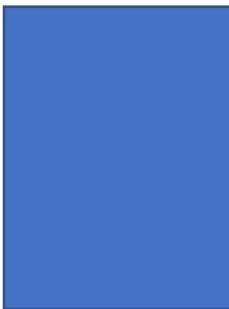


Ns. Revie Fitria N, S.Kep., M.Kep

Lahir pada 27 September 1977 di Bandung, Jawa Barat. Riwayat pendidikan: D III Akademi Keperawatan Persada Husada Indonesia, Jakarta (2001), S1 Keperawatan dan Profesi Universitas Muhammadiyah, Jakarta (2004), S2 Magister Keperawatan Universitas Muhammadiyah, Jakarta (2013). Riwayat Pekerjaan:

Dosen Tetap di STIKes Persada Husada Indonesia (2004-2019), Dosen Tetap Akademi Keperawatan Berkala Widya Husada (2019 - sekarang). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: revie.bwh@gmail.com

Motto: "Selalu bersyukur untuk yang dicapai"



Istiada Fatmawati, SST., M.Kes



Hanik Khairun Nisa, S.Tr.Keb., M.Keb

Lahir pada 19 Februari 1997 di Oku Timur, Sumatera Selatan. Riwayat Pendidikan D III Kebidanan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (2018), DIV Kebidanan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (2019), S2 Magister Kebidanan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (2021). Riwayat pekerjaan Sejak tahun 2021 penulis mulai aktif mengajar sebagai Dosen Kebidanan dan saat ini penulis aktif mengajar di Program Studi Kebidanan Di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada

Palembang. Selain itu Penulis juga aktif dalam penerbitan buku serta jurnal nasional dan internasional lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui email : khairunnisa19021997@gmail.com

Pesan untuk para pembaca: "Jangan Pernah Letih Untuk Terus Belajar, Kejarlah Mimpi Serta Angan Mu Dan Raihlah Masa Depan Yang Gemilang".



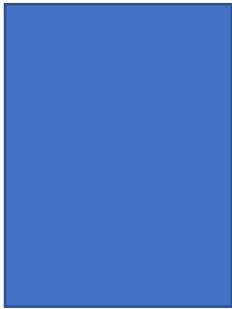
Vini Yuliani, SST., M.Keb

Penulis lahir di Sukabumi 14 Juli 1988. Anak Pertama dari 3 bersaudara. Penulis menyelesaikan Pendidikan Bidan Diploma 3 dan Diploma 4 Bidan Pendidik di Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Pada tahun 2018 penulis menyelesaikan Pendidikan S-2 Kebidanan di Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Riwayat Pekerjaan: Dosen di STIKES Sukabumi (2014-2020), Dosen PNS di Poltekkes Kemenkes Jakarta I (2021-sekarang), penulis aktif melakukan publikasi ilmiah, menulis buku dan penelitian. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: vinny.jeroline06@gmail.com
Motto: "Selalu memaksimalkan usaha, karena yakin setiap Kerja keras yang dilakukan mampu memberikan hasil yang terbaik"



Bdn. Imelda Diana Marsilia, SST., SKM., M.Keb.

Lahir di Bandung 03 Maret 1980, Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu menyelesaikan Pendidikan DIII Kebidanan di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta tahun 2001, dilanjutkan Pendidikan DIV Kebidanan di Universitas Padjadjaran tahun 2003, kemudian melanjutkan S1 Kesehatan Masyarakat di STIKes Mitra Ria Husada Jakarta tahun 2012, dan menyelesaikan Pendidikan S2 Program studi Magister Kebidanan di Universitas Padjadjaran tahun 2013 serta menyelesaikan pendidikan profesi Bidan di STIKes Abdi Nusantara pada tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2001 penulis bekerja di TPMB Sri Pasar Minggu, kemudian tahun 2003 bekerja sebagai Dosen tidak tetap di Akbid Istara Nusantara dan Tahun 2004 bekerja di STIKes Mitra RIA Husada Jakarta sampai sekarang. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan, Asuhan kebidanan pada Persalinan, Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi Balita dan Anak Prasekolah, Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal, Asuhan Kebidanan Komplementer Evidence Based Midwifery. Penulis aktif di beberapa organisasi, kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pengajaran dan mengembangkan diri melalui penulisan buku Kebidanan dan aktif dalam kegiatan seminar, workshop dan pelatihan serta publikasi artikel jurnal dalam jurnal Nasional terakreditasi. Penulis telah Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: imeldadiana33@gmail.com



Novi Susanti, SST., M.Kes



Sri ilawati, SST, M.Kes

Lahir di Sukarama ,17 Juli 1988. Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Program Studi Kebidanan di Akademi Kebidanan Kholisatur Rahmi Binjai. Setelah menyelesaikan Studi di Akademi Kebidanan Kholisatur Rahmi Binjai penulis melanjutkan Studi Diploma IV Jurusan Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu kesehatan Helvetia Medan, Kemudian Melanjutkan Study Magister Kesehatan Masyarakat Di Universitas Respati Indonesia di Jakarta. Penulis Memiliki Profesi Sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan. dan Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan workshop. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sriilawati468@gmail.com

Sinopsis Buku

Infeksi kulit merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering dialami oleh bayi baru lahir, terutama pada minggu-minggu pertama kehidupan ketika sistem pertahanan tubuh dan fungsi pelindung kulit belum berkembang sempurna. Buku **“Pencegahan Infeksi Kulit pada Bayi Baru Lahir”** hadir sebagai referensi ilmiah dan praktis untuk menjawab tantangan ini, dengan menawarkan panduan komprehensif bagi tenaga kesehatan, pendidik, mahasiswa, serta keluarga bayi dalam memahami berbagai strategi pencegahan infeksi kulit yang aman dan efektif.

Buku ini terdiri dari tujuh bab utama yang membahas berbagai aspek penting dalam menjaga kesehatan kulit bayi. Bab pertama menguraikan pentingnya praktik kebersihan dalam mencegah infeksi, baik dari lingkungan maupun perawatan langsung terhadap bayi. Bab kedua fokus pada edukasi keluarga, terutama orang tua dan pengasuh, agar mampu melakukan perawatan kulit bayi dengan benar, aman, dan sesuai anjuran medis. Bab ketiga menyajikan teknologi sederhana yang dapat digunakan dalam menjaga kelembapan dan kebersihan kulit bayi, seperti pemilihan bahan kain dan alat monitoring suhu serta kelembaban.

Pada bab keempat, buku ini menyoroti peran bidan sebagai garda terdepan dalam memberikan penyuluhan dan edukasi kesehatan kulit bayi, khususnya di masyarakat pedesaan atau daerah dengan akses layanan terbatas. Bab kelima menekankan hubungan antara nutrisi ibu menyusui dan kondisi kulit bayi, meninjau peran zat gizi penting dalam mendukung imunitas kulit melalui ASI. Bab keenam membahas pemilihan produk perawatan kulit bayi yang aman dan sesuai standar klinis, mencakup sabun, lotion, hingga popok yang tidak menimbulkan iritasi. Terakhir, bab ketujuh menekankan pentingnya dukungan komunitas, seperti program Posyandu dan kegiatan pemberdayaan keluarga, dalam meningkatkan kesadaran dan praktik sehat di tingkat masyarakat.

Dengan pendekatan berbasis bukti dan bahasa yang mudah dipahami, buku ini diharapkan menjadi sumber inspirasi sekaligus panduan tindakan nyata dalam menurunkan kejadian infeksi kulit pada bayi baru lahir melalui pendekatan promotif, preventif, dan kolaboratif.

Infeksi kulit merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering dialami oleh bayi baru lahir, terutama pada minggu-minggu pertama kehidupan ketika sistem pertahanan tubuh dan fungsi pelindung kulit belum berkembang sempurna. Buku "Pencegahan Infeksi Kulit pada Bayi Baru Lahir" hadir sebagai referensi ilmiah dan praktis untuk menjawab tantangan ini, dengan menawarkan panduan komprehensif bagi tenaga kesehatan, pendidik, mahasiswa, serta keluarga bayi dalam memahami berbagai strategi pencegahan infeksi kulit yang aman dan efektif. Buku ini terdiri dari tujuh bab utama yang membahas berbagai aspek penting dalam menjaga kesehatan kulit bayi. Bab pertama menguraikan pentingnya praktik kebersihan dalam mencegah infeksi, baik dari lingkungan maupun perawatan langsung terhadap bayi. Bab kedua fokus pada edukasi keluarga, terutama orang tua dan pengasuh, agar mampu melakukan perawatan kulit bayi dengan benar, aman, dan sesuai anjuran medis. Bab ketiga menyajikan teknologi sederhana yang dapat digunakan dalam menjaga kelembapan dan kebersihan kulit bayi, seperti pemilihan bahan kain dan alat monitoring suhu serta kelembapan.

Pada bab keempat, buku ini menyoroti peran bidan sebagai garda terdepan dalam memberikan penyuluhan dan edukasi kesehatan kulit bayi, khususnya di masyarakat pedesaan atau daerah dengan akses layanan terbatas. Bab kelima menekankan hubungan antara nutrisi ibu menyusui dan kondisi kulit bayi, meninjau peran zat gizi penting dalam mendukung imunitas kulit melalui ASI. Bab keenam membahas pemilihan produk perawatan kulit bayi yang aman dan sesuai standar klinis, mencakup sabun, lotion, hingga popok yang tidak menimbulkan iritasi. Terakhir, bab ketujuh menekankan pentingnya dukungan komunitas, seperti program Posyandu dan kegiatan pemberdayaan keluarga, dalam meningkatkan kesadaran dan praktik sehat di tingkat masyarakat.

Dengan pendekatan berbasis bukti dan bahasa yang mudah dipahami, buku ini diharapkan menjadi sumber inspirasi sekaligus panduan tindakan nyata dalam menurunkan kejadian infeksi kulit pada bayi baru lahir melalui pendekatan promotif, preventif, dan kolaboratif.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-7294-30-2



9

786347

294302